



MINISTERIO
DE SANIDAD

AMIR

PRUEBAS SELECTIVAS CUADERNO DE EXAMEN

MEDICINA - VERSIÓN: 0
SIMULACRO 5

NÚMERO DE MESA:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

Nº DE D.N.I. O EQUIVALENTE PARA EXTRANJEROS:

APELLIDOS Y NOMBRE:

ADVERTENCIA IMPORTANTE ANTES DE COMENZAR SU EXAMEN, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

- 1. MUY IMPORTANTE:** Compruebe que este Cuaderno de Examen, lleva todas sus páginas y no tiene defectos de impresión. Si detecta alguna anomalía, pida otro Cuaderno de Examen a la Mesa. **Realice esta operación al principio**, pues si tiene que cambiar el cuaderno de examen posteriormente, se le facilitará una versión "0", que no coincide con su versión personal en la colocación de preguntas y **no dispondrá** de tiempo adicional.
2. El cuestionario se compone de 200 preguntas más 10 de reserva. Tenga en cuenta que hay 30 **preguntas que están ligadas a una imagen**. Todas las imágenes están en un cuadernillo de imágenes separado.
3. Compruebe que el **número de versión** de examen que figura en su "Hoja de Respuestas", **coincide** con el número de versión que figura en el cuestionario. Compruebe también el resto de sus datos identificativos.
4. La "Hoja de Respuestas" está nominalizada. Se compone de dos ejemplares en papel autocopiativo que deben colocarse correctamente para permitir la impresión de las contestaciones en todos ellos. Recuerde que debe firmar esta Hoja.
5. Compruebe que la respuesta que va a señalar en la "Hoja de Respuestas" corresponde al número de pregunta del cuestionario. **Sólo se valoran** las respuestas marcadas en la "Hoja de Respuestas", siempre que se tengan en cuenta las instrucciones contenidas en la misma.
6. Si inutiliza su "Hoja de Respuestas" pida un nuevo juego de repuesto a la Mesa de Examen y **no olvide** consignar sus datos personales.
7. Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de cuatro horas y media improrrogables y que están prohibidos el uso de calculadoras y la utilización de teléfonos móviles, o de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos.
8. **No se entregarán**, en ningún caso, **los cuestionarios** con las preguntas de examen. Las distintas versiones de los cuadernos de examen se publicarán en la Web del Ministerio de Sanidad, al cierre de la última mesa de examen.

1. Pregunta asociada a la imagen 1.

En la región postero-lateral de la rodilla se halla situada una estructura cordonal. Está coloreada en amarillo en estas dos imágenes y señalada por flechas. Incluida en la fascia del bíceps en el muslo, en la rodilla rodea el cuello del peroné. De su integridad dependen:

1. La sensibilidad de la cara posterior de la pierna y la región aquilea.
2. La capacidad de extensión (flexión dorsal) del tobillo y de los dedos del pie.
3. La capacidad de flexión plantar del tobillo y de los dedos del pie.
4. La sensibilidad de la planta del pie y del pulpejo de los dedos.

Respuesta correcta: 2.

Comentario:

Pregunta que por la imagen puede ser difícil, pero que se simplifica si leemos con cuidado el enunciado. La estructura “amarilla” por excelencia en los libros de Anatomía es el nervio, y una de las lesiones nerviosas típicas de una estructura que rodea el cuello del peroné es la lesión del nervio peroneo común, también llamado ciático poplíteo externo. Si recordamos que la lesión del ciático poplíteo externo produce un “pie caído”, podremos deducir fácilmente que inerva la musculatura que realiza flexión dorsal del tobillo y los dedos del pie (músculos peroneos, tibial anterior, extensor largo de los dedos y extensor largo del dedo gordo). Además lleva la sensibilidad de la cara anterolateral de la pierna y el dorso del pie.

2. Pregunta asociada a la imagen 2.

¿Con cuál de las estructuras señaladas en la imagen contacta directamente el acueducto de Silvio?

1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.

Respuesta correcta: 2.

Comentario:

El acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio comunica el tercer y el cuarto (en la imagen, número 2) ventrículos cerebrales. El resto de números de la imagen corresponden al septum pellucidum (1), el tentorio o tienda del cerebelo (3), y la hipófisis (4).

3. Pregunta asociada a la imagen 3.

Una paciente diagnosticada de bocio multinodular es sometida a una tiroidectomía total. La imagen muestra el campo quirúrgico al finalizar la intervención (lado izquierdo). ¿Cuál es la estructura señalada con la pinza quirúrgica?:

1. Conducto torácico.
2. Nervio laríngeo recurrente.
3. Nervio vago.
4. Nervio laríngeo superior.

Respuesta correcta: 2.

Comentario:

La causa más frecuente de lesión iatrogénica del nervio laríngeo recurrente es en la tiroidectomía. Durante el acto quirúrgico es una de las estructuras más importantes que debemos localizar y respetar en todo su recorrido dada la cercanía a la glándula extirpada.

4. Pregunta asociada a la imagen 4.

Mujer de 65 años. Consulta por síndrome constitucional asociado a dolor abdominal epigástrico progresivo irradiado a espalda, de dos meses de evolución. El diagnóstico de sospecha de adenocarcinoma de páncreas se confirma por biopsia guiada por ecoendoscopia. Se realiza TC de abdomen tras administración de contraste intravenoso para valoración de estructuras vasculares próximas al tumor pancreático, a fin de establecer su posible afectación. (ver imagen). ¿Qué estructura vascular está ausente, trombosada por infiltración tumoral, condicionando circulación colateral en la pared gástrica?:

1. Vena mesentérica superior.
2. Vena coronaria estomáquica.
3. Vena esplénica.
4. Vena porta.

Respuesta correcta: 3.

Comentario:

Se trata de una paciente con adenocarcinoma de páncreas a quien realizan un TC abdominal con contraste para descartar afectación vascular. Se trata de una reconstrucción coronal donde se observa la vena esplénica con un trayecto afilado y además se observa la circulación colateral en la pared gástrica. Esta pregunta se podía contestar también con la pista que nos dan de que su trombosis ha provocado la aparición de circulación colateral (varices) gástrica pues la trombosis de la vena esplénica lo puede desencadenar. Dado que no tiene afectación de la vena mesentérica superior o vena porta ni arteria mesentérica superior, tronco celiaco, aorta o vena cava sería en principio un tumor resecable.

5. Pregunta asociada a la imagen 5.

Un hombre de 29 años acude a la consulta por presentar aumento de tamaño de un ganglio linfático en axila desde hace tres meses. No hay otros antecedentes personales de interés, salvo un diagnóstico previo hace 9 meses de eritema indurado. La exploración ofrece datos relevantes. El diagnóstico más probable de esta biopsia del ganglio linfático es:

1. Linfadenitis dermatopática.
2. Linfadenitis tuberculosa.
3. Sarcoidosis.
4. Linfadenitis sifilítica.

Respuesta correcta: 2.

Comentario:

Pregunta relativamente sencilla si nos guiamos por la clínica y por la imagen. La imagen muestra un granuloma necrotizante con material caseoso en su interior (es el material amorfo rosado que se ve a la derecha de la imagen), rodeado de una empalizada de macrófagos epitelioides y hasta se ve alguna célula gigante multinucleada; solo con esto ya podríamos decir que es una tuberculosis. Pero además nos dan otra pista, y es que la única clínica del paciente es una adenopatía y que además presentó un "eritema indurado" (de Bazin), que es una paniculitis lobulillar con vasculitis que se produce como consecuencia de una reacción de hipersensibilidad frente a antígenos de *M. tuberculosis*. La linfadenitis dermatopática es la presencia de adenopatías en pacientes con enfermedades crónicas de la piel (linfomas cutáneos, psoriasis...) pero ni hay granulomas ni el paciente tiene patología cutánea. La sífilis tampoco va con granulomas y la única duda podía estar con la sarcoidosis, pero los granulomas sarcoideos no tienen necrosis caseosa en el centro y la pista del eritema indurado previo nos orienta claramente a la tuberculosis.

6. Pregunta asociada a la imagen 6.

Una paciente de 76 años consulta por dolor en la masticación y alteraciones en la oclusión dentaria. Entre sus antecedentes destaca una hipertensión de muchos años de evolución que trata con dieta hiposódica y nifedipino y unos episodios de pérdida de conciencia diagnosticados, hace más de 25 años, de "epilepsia", por los que sigue tratamiento con 100 mg/día de fenitoína. Por lo demás, se encuentra bien, ha perdido peso y mantiene una vida normal por edad. La exploración de la boca puede observarse en la figura. ¿Cuál sería la actitud más razonable en un primer momento?:

1. Dado que el hipotiroidismo es la causa más probable del problema de la paciente, solicitaría una analítica completa que incluya TSH.
2. Consideraría la posibilidad de factores yatrógenos y evaluar la retirada tanto de la fenitoína como del nifedipino.
3. Lo más probable es que factores locales como una mala higiene dental estén en el origen del problema, por lo que haría recomendaciones en este sentido y remitiría la paciente a un odontólogo.
4. La causa más habitual de hiperplasia gingival en la vejez son las leucemias monocíticas, por lo que iniciaría estudios en este sentido.

Respuesta correcta: 2.

Comentario:

La imagen número 6 nos muestra un paciente con hiperplasia gingival. La hiperplasia gingival asociada a medicamentos es una reacción adversa que aparece tras el uso sistémico de algunos fármacos. No se conoce con precisión su patogénesis. Causa dolor al masticar, trastornos del habla, hemorragia gingival, alteraciones periodontales, oclusión dentaria y daños estéticos. La hiperplasia gingival puede aparecer hasta en un 50% de pacientes tratados con fenitoína y se ha asociado (aunque con menor frecuencia) con la administración de otros antiepilépticos. Asimismo, constituye uno de los efectos adversos más frecuentes de los antagonistas del calcio, en especial de nifedipino, así como de la ciclosporina.

7. Pregunta asociada a la imagen 7.

Un joven de 26 años de edad, sin antecedentes patológicos de interés, acude al Servicio de Urgencias por palpitaciones de algo más de una hora de duración. Está consciente y la presión arterial es de 95/60 mm de Hg. El trazado electrocardiográfico se muestra en la imagen. ¿Cuál de los siguientes le parece el diagnóstico más probable?:

1. Taquicardia paroxística supraventricular por reentrada intranodal.
2. Fibrilación auricular en un paciente con síndrome de Wolf-Parkinson-White.
3. Taquicardia ventricular.
4. Fibrilación ventricular.

Respuesta correcta: 2.

Comentario:

Pregunta difícil en la que hay que interpretar un electrocardiograma no muy habitual. El ECG muestra una taquicardia irregular, por lo que nuestra sospecha debe ser fibrilación auricular. Además, la anchura de los QRS es variable, y los más anchos tienen en su inicio una muesca que recuerda a una onda delta. Este trazado ECG es muy característico y se llama fibrilación auricular preexcitada. Es una fibrilación auricular que ocurre en un paciente con Wolff-Parkinson-White, y en el que algunos estímulos se conducen a los ventrículos preferencialmente por la vía accesoria (los que tienen QRS más ancho) y otros por el nodo AV (los que tienen QRS más estrecho).

8. Pregunta asociada a la imagen 8.

Un hombre de 51 años de edad acude al servicio de urgencias por presentar dolor torácico irradiado a miembro superior izquierdo y espalda, de 90 minutos de duración, asociado a mal estado general, sudoración y signos de deficiente perfusión periférica. A la auscultación presenta ritmo de galope, tercer ruido; y crepitantes en ambas bases pulmonares. Se

realiza coronariografía urgente (ver imagen). Tras evaluar esta imagen. ¿Qué alteraciones electrocardiográficas esperaría encontrar en dicho paciente?:

1. Elevación de segmento ST en derivaciones II, III y avF.
2. Elevación de segmento ST en derivaciones V2, V3, V4 y V5.
3. Descenso de segmento ST en derivaciones V2, V3, V4 y V5.
4. Descenso de segmento ST en derivaciones II, III y avF, asociado a descenso en avL.

Respuesta correcta: 2.

Comentario:

Pregunta difícil dado que tenemos que interpretar una coronariografía. Nos presentan un caso clínico de dolor torácico de características anginosas de nueva aparición (no nos cuentan antecedentes de angina habitual) y por tanto debemos encuadrarlo en el bloque de síndrome coronario agudo (SCA). Además se hace una coronariografía urgente, lo que refuerza nuestra sospecha dado que cuadra con el diagnóstico de SCA. La imagen muestra una arteria principal inicial y corta que rápidamente se bifurca en dos grandes arterias. Sospechamos por tanto que estamos sondando el tronco coronario izquierdo, que se bifurca rápidamente en circunfleja y descendente anterior. Una de esas arterias presenta una oclusión (hay un stop brusco al paso de contraste), por lo que estaremos ante un SCACEST. En el ECG habrá, por lo tanto, elevación del ST. Entre las opciones con elevación del ST, la 1 dice elevación del ST en cara inferior, y la 2 dice elevación del ST en cara anterior. Si la opción correcta fuera la 1, deberíamos estar sondando la coronaria derecha y ver que en ella hay una oclusión. Como no es así, sino que estamos sondando el tronco, la opción correcta debe ser la 2. No hacía falta por lo tanto saber que la arteria ocluida era específicamente la descendente anterior (la arteria que se bifurca hacia abajo en la imagen es la circunfleja); con saber simplemente que estamos visualizando el árbol coronario izquierdo habría sido suficiente para contestar la pregunta. Adjuntamos una figura con la explicación de la imagen.

9. Pregunta asociada a la imagen 9.

Una mujer de 35 años acude a consulta porque presenta dolor torácico al esfuerzo. No tiene factores de riesgo cardiovascular. Se ausculta un soplo sistólico en foco aórtico que aumenta con la maniobra de Valsalva. El ECG muestra ritmo sinusal, ondas Q, trastornos de la repolarización y criterios de hipertrofia ventricular izquierda. En la figura puede apreciarse una imagen de su ecocardiografía. Señale la opción FALSA:

1. Se trata de una enfermedad hereditaria.
2. Esta enfermedad se asocia a muerte súbita.
3. La fibrilación auricular

tiene una mayor incidencia en las personas con esta enfermedad.

4. La disnea no aparecerá hasta que la paciente desarrolle disfunción sistólica ventricular izquierda.

Respuesta correcta: 4.

Comentario:

Pregunta sencilla dado que el caso clínico es tan típico de miocardiopatía hipertrófica que no hace ni falta ver la imagen; un soplo que aumenta con la maniobra de Valsalva en un paciente joven y con criterios de hipertrofia en el ECG no puede indicar otra cosa. La imagen es un ecocardiograma de baja calidad en eje paraesternal largo en el que se observa, a la izquierda de la imagen, un ventrículo izquierdo muy hipertrófico; adjuntamos una imagen explicativa de las estructuras que se observan en la imagen (aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y raíz aórtica). La MCH asocia clínica de insuficiencia cardíaca “diastólica” (con fracción de eyección preservada), por lo que no es necesario que los pacientes desarrollen disfunción ventricular para que comiencen a manifestar disnea.

10. Pregunta asociada a la imagen 10.

Señale en qué tipo de la clasificación de De Bakey se podría incluir la patología que se muestra en la imagen:

1. Tipo I.
2. Tipo II.
3. Tipo III.
4. Para poder clasificarla, se debe de apreciar la zona de reentrada distal a la luz de la aorta, lo que no se visualiza en la imagen.

Respuesta correcta: 3.

Comentario:

Pregunta puramente teórica sobre la disección de aorta. La clasificación de De Bakey no se emplea en la práctica clínica (probablemente la pregunta la haya puesto un radiólogo y no un cardiólogo) y clasifica las disecciones en 3 grupos: I (implica tanto aorta ascendente como descendente), II (implica sólo aorta ascendente) y III (implica sólo aorta descendente). La interpretación de la imagen es sencilla dado que es una reconstrucción tridimensional de TC, en la cual se ve la disección como si la estuvieras viendo en una pieza anatómica. La disección comienza en la aorta descendente, apreciándose unafilamiento progresivo de su luz; se trata por lo tanto de un tipo III de De Bakey. La clasificación empleada en la práctica clínica de las disecciones de aorta es la de Stanford porque implica decisiones clínicas: tipo A (involucra aorta ascendente: emergencia quirúrgica) y tipo B (no involucra aorta ascendente: manejo inicial conservador).

11. Pregunta asociada a la imagen 11.

Mujer de 29 años que presenta dolor abdominal mesogástrico, continuo, de cinco días de evolución. Se realiza un estudio de imagen

mediante tomografía computarizada, ¿cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Invaginación ileo-cólica.
2. Ileítis isquémica.
3. Enfermedad de Crohn.
4. Colitis rádica.

Respuesta correcta: 3.

Comentario:

Pregunta algo compleja ya que se basa en los hallazgos de una prueba de imagen que no estamos acostumbrados a interpretar (TC abdominal con contraste oral). Se trata de una paciente joven sin factores de riesgo cardiovascular en principio, por lo que las opciones 2 y 4 son muy poco probables y las opciones 1 y 3 son más probables (especialmente la 3). La opción 1 no es la respuesta ya que nos aportarían la típica imagen en “donut”, además de tratarse de una patología más bien de la infancia (salvo casos excepcionales de invaginación por tumores de intestino delgado). La opción correcta es la 3 y en la imagen del TC (con contraste intestinal y corte en fosa iliaca derecha) se aprecia un segmento largo de íleon con paredes engrosadas, con relleno filiforme de su luz. Se trata, por tanto, de una paciente con un brote suboclusivo (cinco días de clínica) por enfermedad de Crohn con patrón estenosante.

12. Pregunta asociada a la imagen 12.

¿Cuál de los siguientes hallazgos NO esperaría encontrar en el líquido que se muestra en la imagen?:

1. Triglicéridos 90 mg/dL.
2. Proteínas totales 3 g/dL.
3. Leucocitos >500/mm³.
4. Gradiente de albúmina 0.9 g/dL.

Respuesta correcta: 1.

Comentario:

Pregunta relativamente compleja ya que no nos aportan datos clínicos y tan sólo disponemos del aspecto del líquido ascítico obtenido por paracentesis diagnóstica (paracentesis que está siendo realizada en una localización atípica ya que habitualmente suele pincharse en la fosa iliaca izquierda para evitar que el ciego pueda ser puncionado si accedemos por fosa iliaca derecha). A simple vista parece un líquido turbio o quiloso (el líquido ascítico normal, por ejemplo en una cirrosis, es completamente claro y transparente). Las opciones 2, 3 y 4 (proteínas altas, leucocitos altos y gradiente seroascítico de albúmina de no hipertensión portal) van en el mismo sentido ya que serían todas ellas posibles en un líquido infectado y/o con quiloso. La que sería menos posible encontrar en una ascitis opaca y con sospecha de ascitis quilosa serían unos triglicéridos tan bajos (habitualmente son mayores a 200 e incluso mayores de 1000)

13. Pregunta asociada a la imagen 13.

Un paciente de 78 años con historia de síndrome depresivo, hipertensión y dislipemia en tratamiento con trazodona, enalapril y simvastatina y antecedentes de apendicectomía hace 20 años, ingresa por un ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral media izquierda sin criterios de fibrinólisis. En el 5º día del ingreso el paciente presenta una marcada distensión abdominal y ausencia de eliminación de heces y gas. El abdomen es discretamente doloroso a la palpación de forma difusa sin peritonismo y el peristaltismo está disminuido. Se solicita una radiografía de abdomen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Vólvulo de sigma.
2. Síndrome de Ogilvie.
3. Oclusión intestinal por bridas, en relación a la cirugía previa.
4. Obstrucción intestinal por neoplasia de ciego.

Respuesta correcta: 2.

Comentario:

Por un lado se trata de un cuadro clínico típico, lo que hace que sólo con la descripción del caso clínico sospechemos la causa del cuadro. Por otro lado, la imagen no es del todo clara lo que puede dificultar la pregunta. El caso clínico es el típico de un paciente con un síndrome de Ogilvie, un paciente mayor que está ingresado por otra causa y desarrolla de forma más o menos brusca un cuadro de dolor abdominal y distensión sin signos de gravedad. En la radiografía simple de abdomen (proyección AP) se ve dilatación de todo el marco cólico y también distensión de algunas asas de delgado, lo que debe hacernos pensar en un síndrome de Ogilvie. No obstante, la clave en esta pregunta es la clínica, como os mencionamos.

14. Pregunta asociada a la imagen 14.

Paciente de 40 años, fumador de 25 paquetes/año. Consumidor de alcohol de 20 UBEs (Unidades de bebida estándar)/día en los últimos meses. Diagnosticado de infección por el VHC hace 8 años sin tratamiento. Relata un cuadro de dolor abdominal de varios días de evolución 2 meses antes por el que llegó a consultar y que duró aproximadamente 1 semana. Consulta ahora por dolor abdominal inicialmente en epigastrio y posteriormente difuso. En el momento del ingreso se aprecia mal estado general, edemas en extremidades inferiores y un abdomen distendido con signos de ascitis. En la analítica practicada en una muestra de sangre se apreciaron los siguientes datos: creatinina 0,68 mg/dL (0,4-1,2), glucosa 84 mg/dL (75-115), AST 21 UI/L (0-35), ALT 15 UI/L (0-35), albúmina 21 g/L (35-52), bilirrubina 0,6 mg/dL (0,3-1,2),

hemoglobina 10,7 g/dL, plaquetas 288.000/mm³, leucocitos 8.200 /mm³, ratio del tiempo de protrombina 1,12 (0,8-1,2). Se realizó una TC abdominal que se presenta en la imagen asociada y también una paracentesis obteniéndose un líquido amarillento claro con los siguientes datos analíticos: glucosa 68 mg/dL, albúmina 17 g/L, bilirrubina 0,4 mg/dL, amilasa 3200 U/L y 200 células /mm³ (70% neutrófilos). Con los datos disponibles, ¿cuál es, entre los siguientes, el diagnóstico más probable en este caso?:

1. Pseudoquiste pancreático con ascitis pancreática.
2. Neoplasia quística pancreática con ascitis por carcinomatosis.
3. Peritonitis secundaria por perforación del tubo digestivo.
4. Descompensación ascítica en paciente con hepatopatía crónica avanzada.

Respuesta correcta: 1.

Comentario:

Se trata de un paciente con factores de riesgo para pancreatitis (fumador y muy bebedor) con un episodio de probable pancreatitis aguda hace unas semanas (“dolor abdominal de varios días hace 2 meses que le duró una semana y por el que no llegó a consultar”). Acude posteriormente por ascitis. A pesar de que el paciente presente factores de riesgo de cirrosis / hepatopatía crónica (bebedor + VHC), no parece ser el caso por los datos de la exploración y de la analítica (bilirrubina, INR, plaquetas normales). Además, si calculamos el gradiente de albúmina nos da: 2,1 - 1,7 = 0,4 (gradiente sin hipertensión portal). Por último, la imagen (reconstrucción coronal de TC de abdomen con contraste i.v. y contraste oral) muestra un gran quiste en región pancreática así como una cantidad muy considerable de líquido libre intraperitoneal con amilasa muy alta. Con todo, la opción correcta es la 1. Así, se trata de un paciente que tuvo una pancreatitis aguda por la que no consultó y que vuelve meses después con una complicación tardía importante (pseudoquiste grande + ascitis pancreática por probable rotura del mismo).

15. Pregunta asociada a la imagen 15.

Frotis de sangre perteneciente a una paciente multipara de 40 años con síndrome anémico, sin otros antecedentes de interés. Señalado en el frotis con una flecha se observa un glóbulo rojo normal, de color y tamaño. ¿Qué estudio analítico, de los siguientes, proporcionaría el diagnóstico del tipo de anemia que padece esta paciente?:

1. Nivel sérico de vitamina B12.
2. Electroforesis de hemoglobinas.
3. Test de Coombs directo.
4. Nivel de ferritina en suero.

Respuesta correcta: 4.

Comentario:

Pregunta fácil que puede contestarse sin necesidad de la imagen. En una mujer joven (40 años) en edad fértil (múltipara) la causa más frecuente de anemia es por déficit de hierro en relación, en este caso en concreto, con los sangrados y con el aumento de la demanda de hierro que se produce durante el embarazo. En la imagen señalan un hematíe normal en color y tamaño. Si se compara con el resto de los hematíes es fácil distinguir que la mayoría tienen un centro mucho más pálido. Se trata de hematíes hipocromos, con menor contenido de hemoglobina en su interior, típico de la anemia ferropénica.

16. Pregunta asociada a la imagen 16.

Una mujer de 38 años sin antecedentes personales de interés, consulta por la aparición de lesiones pruriginosas en ambas palmas acompañadas de cefaleas, malestar general y febrícula. A la exploración presenta adenopatías palpables cervicales dolorosas, lesiones en las palmas (figura) y un rash de coloración rosada tenue en el tronco. No recuerda lesiones cutáneo-mucosas en ninguna localización los meses anteriores a la aparición del cuadro actual. En relación al cuadro que presenta la paciente, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

1. En esta situación está indicado realizar un test de Tzanck y tratamiento con aciclovir 800 mg/12 horas durante 5 días de la paciente y de las parejas sexuales identificadas.
2. En esta situación está indicado realizar una prueba treponémica y tratar con una monodosis intramuscular de 2,4 millones de UI de penicilina G benzatina.
3. Sospechar una fiebre botonosa mediterránea y prescribir tratamiento con doxiciclina.
4. Habrá que sospechar un lupus eritematoso sistémico con afectación cutánea e iniciar tratamiento con hidroxicloloroquina.

Respuesta correcta: 2.

Comentario:

Paciente joven con fiebre/febrícula, adenopatías y sobre todo rash con afectación palmo-plantar. Lo primero a plantear es una sífilis secundaria, que se diagnostica mediante serología (test treponémico y test no treponémico) y se trata con una inyección i.m. de penicilina G-benzatina (opción 2). La única duda podría estar con una rickettsiosis como la fiebre botonosa mediterránea, que sería lo segundo a pensar con un exantema palmo-plantar, pero sin embargo no nos dicen nada ni de garrapatas ni de la típica escara negra. El herpes genital no cursa con rash generalizado y el LES no provoca afectación palmo-plantar.

17. Pregunta asociada a la imagen 17.

Un hombre de 47 años, fumador activo, con historia de abuso de drogas por vía parenteral acude a Urgencias por un cuadro de 2 horas de evolución de dolor costal izquierdo pleurítico de inicio agudo y disnea progresiva hasta hacerse de reposo. En las 2 semanas previas había presentado febrícula, malestar general y tos seca. A la exploración el paciente impresiona de gravedad, está taquipneico a 36 rpm, con tiraje supraclavicular, saturación de oxígeno por pulsioximetría de 81%, cianosis, sudoración, taquicardia a 135 latidos por minuto y PA de 75/47 mm Hg. La tráquea está desviada hacia el lado derecho y la auscultación demuestra ausencia completa de murmullo vesicular en hemitórax izquierdo. Se realiza una serología VIH que resulta positiva y presenta un recuento de linfocitos CD4 de 176 células/ml. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Rotura de bulla enfisematosa subpleural.
2. Neumonía bacteriana necrotizante adquirida en la comunidad.
3. Tuberculosis pulmonar.
4. Neumonía por *Pneumocystis jirovecii*.

Respuesta correcta: 4.

Comentario:

Esta pregunta hay que leerla de final a principio. Nos presentan un paciente VIH con <200 CD4 (no conocido previamente) que consulta por un cuadro subagudo de febrícula, malestar general y tos seca y que de repente se pone grave porque hace un neumotórax. Esta presentación clínica es característica de una neumonía por *Pneumocystis*, que de forma no infrecuente se complica con neumotórax espontáneo. La tuberculosis y la neumonía comunitaria no se complican en forma de neumotórax sino en forma de derrame pleural. La duda podría estar con la rotura de una bulla subpleural, que podría explicar el neumotórax pero no explicaría la clínica de infección respiratoria de dos semanas de evolución que presentaba el paciente.

18. Pregunta asociada a la imagen 18.

Hombre de 61 años afecto de síndrome nefrótico con HTA de 160/90 mmHg y función renal conservada. Analíticamente, destaca una tasa de filtrado glomerular (GFR) de 50 mL/min y una proteinuria de 3,48 g/24 horas. Se realizó biopsia renal. En el estudio anatomopatológico se observó un ratio de 3/35 glomerulos esclerosados y una alteración glomerular diagnóstica (figura 1, PAS, x 200). Se reconocieron ocasionales arteriolas con la pared engrosada y aspecto hialino. Se realizó estudio de inmunofluorescencia directa observándose depósitos de IgG +++ y C3 ++ en el glomerulo, de carácter granular. ¿Cuál es su diagnóstico?:

1. Para poder diagnosticar la lesión se precisa tinción de rojo congo para excluir una amiloidosis.
2. Es una glomerulonefritis segmentaria y focal.
3. Es una glomeruloesclerosis diabética.
4. Es una glomerulonefritis membranosa.

Respuesta correcta: 4.

Comentario:

Esta pregunta se contestaba sin necesidad de recurrir a la imagen. Nos presentan un síndrome nefrótico impuro (HTA) en un adulto, por lo que la opción más probable es una GN membranosa (respuesta 4 CORRECTA); la biopsia muestra engrosamiento generalizado de la membrana basal glomerular y existen en la inmunofluorescencia depósitos granulares de Ig y C3 en la vertiente subepitelial. Del resto de opciones: - Nos dicen que solo hay 3 de 35 glomerulos esclerosados, lo que descarta la GNEFyS (respuesta 2 incorrecta) y la GN diabética (respuesta 3 incorrecta) que también suele cursar con glomeruloesclerosis (máximo cuando no nos dicen que el paciente sea diabético). - No nos presentan datos para sospechar una amiloidosis (mieloma múltiple, enfermedad inflamatoria crónica no controlada).

19. Pregunta asociada a la imagen 19.

Paciente que refiere dolores lumbares de repetición, con irradiación a zona inguinal y cadera izquierda. Los hallazgos en la radiografía que se muestra le sugieren el diagnóstico de:

1. Patología discal herniaria.
2. Espondilodiscitis.
3. Masa retroperitoneal, probablemente liposarcoma.
4. Pielonefritis xantogranulomatosa (por obstrucción litiasica).

Respuesta correcta: 4.

Comentario:

Nos presentan un paciente con cuadro clínico compatible de crisis renales de repetición, en el que la radiografía de abdomen muestra litiasis renal izquierda. Ante estos hallazgos, la única respuesta posible es la 4. La pielonefritis xantogranulomatosa en una pielonefritis crónica a la cual se le añade una obstrucción incompleta o litiasis. El tratamiento suele requerir la nefrectomía.

20. Pregunta asociada a la imagen 20.

¿Cuál de las siguientes opciones responde mejor al patrón radiológico de la imagen?:

1. Patrón en panal.
2. Patrón destructivo.
3. Patrón miliar.
4. Patrón microquístico.

Respuesta correcta: 3.

Comentario:

La radiografía de tórax muestra un patrón radiológico

intersticial de perfil micronodular, típico de enfermedades intersticiales con granulomas diseminados (como silicosis o tuberculosis miliar). Para diferenciar si afecta predominantemente a bases o a vértices se suele recomendar tapar la zona media de la radiografía para poder comparar visualmente campos superiores con inferiores.

21. Pregunta asociada a la imagen 21.

Hombre de 71 años. Fumador de 2-3 cigarrillos al día hasta hace 7 años. Ha trabajado como empleado en empresa de embalaje, sin exposición a humos o polvo. Hipertensión arterial y cardiopatía hipertensiva. Hace 2 años fue diagnosticado de una fibrilación auricular paroxística y recibió tratamiento con amiodarona durante 18 meses a dosis de 200 mg/día y posteriormente 400 mg/día en los últimos 6 meses. Hace 5 meses presentó un cuadro de tos, fiebre y disnea. Se realizó una radiografía de tórax (imagen A) y recibió tratamiento antibiótico y esteroideo con mejoría. El control radiológico posterior fue normal. Acude a consulta por presentar astenia, fiebre y tos de 2 semanas de evolución. En la analítica destaca hemograma normal, proteína C reactiva 9,5 mg/dL (normal 0-1), VSG 39 mm (1ª hora). Se realiza una radiografía de tórax (imagen B) y se decide ingreso. Se realiza una broncoscopia con lavado broncoalveolar, con el siguiente recuento celular: Linfocitos 74% (cociente CD4/CD8 = 0,9), macrófagos 18%, neutrófilos 4%. La citología se informa con presencia de macrófagos espumosos. Se indica realizar una biopsia por videotoracoscope. Ante los hallazgos clínicos, radiológicos y analíticos con los que ya contamos podemos concluir:

1. El cuadro anatomopatológico más probable es una neumonía organizada.
2. Una neumonitis por amiodarona parece poco probable dado que el paciente ha tomado el fármaco durante 2 años.
3. El cociente linfocitario del lavado broncoalveolar sugiere un cuadro de sarcoidosis.
4. El cuadro sugiere una neumonía de tipo fibrótico.

Respuesta correcta: 1.

Comentario:

Pregunta interesante. Nos presentan a un paciente que esta tomando dosis altas de amiodarona desde hace meses, que tiene un cuadro de astenia, tos y fiebre, y un infiltrado radiológico migratorio (se modifica en radiografías seriadas). En el lavado broncoalveolar tiene macrófagos espumosos, que son altamente específicos de la toxicidad por amiodarona. La toxicidad por amiodarona puede dar distintos patrones clínicos y radiológicos, estando

reconocidos 7 patrones distintos. Uno de ellos es el de neumonía organizada, similar a la BONO (bronquiolitis obliterante con neumonía organizada) en tanto que da cuadro constitucional e infiltrados alveolares migratorios, pero diferente en cuanto al lavado broncoalveolar. La toxicidad por amiodarona puede aparecer en cualquier momento del tratamiento, tanto en pacientes que llevan una o dos semanas de tratamiento como en pacientes que llevan meses o años, por lo que no se puede excluir por llevar tanto tiempo tomándolo. Es más frecuente con dosis superiores a 400 mg al día sostenidas más de un mes. En cuanto a las otras dos opciones: la sarcoidosis cursa con cociente CD4/CD8 mayor de 3 en el lavado broncoalveolar, y las neumonitis fibrosantes tienen patrón radiológico intersticial, no alveolar como el que muestra la radiografía.

22. Pregunta asociada a la imagen 22.

Un hombre de 75 años es evaluado por historia de un año de tos y disnea. No tiene otros problemas médicos y toma medicaciones. Ha sido fumador de 40 paquetes-año. No tiene animales en casa. Ha trabajado en una sucursal bancaria. Al examen físico la presión arterial es de 135/75 mmHg, pulso 88 lpm, frecuencia respiratoria 24 rpm. SpO2 88% respirando aire ambiente. No tiene distensión yugular. La auscultación cardíaca es normal. A la auscultación pulmonar se oyen crepitantes bilaterales inspiratorios en bases. Tiene acropaquias (dedos en palillo de tambor) en manos. No tiene edemas en miembros inferiores. Se le realizan pruebas de función respiratoria que muestran descenso de FEV1 (57% del predicho), descenso de FVC (67% del predicho), cociente FEV1/FVC 0,91 y disminución de la DLCO (42% del predicho). Se realiza TC torácico que se muestra. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?:

1. Neumonitis descamativa.
2. EPOC con enfisema.
3. Cáncer de pulmón.
4. Fibrosis pulmonar idiopática.

Respuesta correcta: 4.

Comentario:

Pregunta asociada a imagen que se contesta muy bien sin haber mirado la imagen. Nos presentan a un paciente fumador con hipoxemia de reposo, que tiene crepitantes bibasales y acropaquias, datos típicos de fibrosis pulmonar. En la espirometría tenemos un índice de Tiffeneau de 0,91 que descarta obstrucción y por tanto EPOC, y una CVF disminuida que sugiere restricción. La DLCO está disminuida, dato típico de enfermedades intersticiales y del enfisema. Por tanto, en ausencia de imagen asociada este cuadro clínico es compatible con una fibrosis pulmonar idiopática. La imagen corrobora el diagnóstico clínico, dado que muestra un corte de TC con patrón destructivo de predominio basal y periférico, con patrón en panal y alguna bronquiectasia.

23. Pregunta asociada a la imagen 23.

Mujer de 42 años de edad que acude a urgencias por aumento de la disnea en las últimas semanas acompañando leve dolor torácico punzante que aumenta con los movimientos respiratorios. No ha presentado fiebre ni aumento de la tos. A la auscultación pulmonar se objetiva disminución del murmullo vesicular en base derecha. Se realiza la siguiente radiografía del tórax que demuestra la existencia de:

1. Tumor broncogénico.
2. Hernia de Bochdalek.
3. Absceso pulmonar.
4. Neumopericardio.

Respuesta correcta: 2.

Comentario:

Tenemos una radiografía de tórax que muestra un gran nivel hidroaéreo en mediastino. Es compatible con una hernia de Bochdalek. La hernia de Bochdalek es típica de niños y suele diagnosticarse en la infancia (asociada a malrotación e hipoplasia pulmonar, condiciona patología respiratoria desde el nacimiento), pero en ocasiones se diagnostica en adultos, muchas veces por problemas digestivos más que respiratorios. Se produce en la zona posterolateral del diafragma, es más frecuente en el lado izquierdo (el derecho esta "protegido" por la interposición del hígado).

24. Pregunta asociada a la imagen 24.

Tomografía Computarizada cerebral realizada con carácter de urgencia ante traumatismo craneoencefálico. ¿Cuál es su diagnóstico?:

1. Hematoma subdural agudo.
2. Hematoma epidural.
3. Lesión cortical (contusión cerebral).
4. Hemorragia intraventricular.

Respuesta correcta: 1.

Comentario:

El hematoma subdural corresponde a un sangrado extraxial entre el córtex cerebral y la duramadre en forma de semiluna en la TC basal. Se produce por rotura de vasos cortico-durales (más frecuentemente venas). En este caso hematoma subdural derecho.

25. Pregunta asociada a la imagen 25.

Paciente de 60 años con antecedentes personales de carcinoma de pulmón, presenta dorsalgia de dos semanas de evolución y dolor irradiado al brazo y mano derechos desde hace tres días. Se realiza RM de columna que se muestra en la imagen. Ante estos hallazgos clínicos y radiológicos indique la respuesta correcta:

1. Metástasis en el cordón medular con signos de expansión.

2. Metástasis vertebrales con fractura patológica que condiciona una compresión medular.
3. Vértebra en diábolo en el contexto de una osteoporosis.
4. La tomografía computarizada es la prueba de imagen de elección en esta patología.

Respuesta correcta: 2.

Comentario:

Recordad que en el MIR no nos suelen ofrecer datos irrelevantes. Si nos hablan de un paciente con un carcinoma de pulmón y dolor radicular, debemos sospechar una metástasis. Recordemos que los tumores que más frecuentemente producen metástasis óseas son los tumores de mama, pulmón, próstata, riñón y tiroides. Quedan por tanto descartadas las opciones 3 y 4. Si observamos las imágenes sagitales T1, T2 de la resonancia, veremos cómo la metástasis ha invadido los cuerpos vertebrales de T3 y T4, con una fractura patológica con desplazamiento del muro posterior del cuerpo vertebral hacia el canal raquídeo, en el nivel T3, y compresión del cordón medular.

26. Pregunta asociada a la imagen 26.

Niño de 6 años que presenta dolor inguinal derecho y cojera, de presentación insidiosa y de un mes de evolución. No refiere fiebre ni traumatismos. No infecciones previas. En la exploración se aprecia limitación a la abducción y rotación interna de la cadera derecha, marcha con discreta cojera sin dolor. Resto de exploración sin hallazgos patológicos. Se realiza la radiografía que presentamos. ¿Cuál es su diagnóstico?:

1. Enfermedad de Perthes.
2. Sinovitis transitoria de caderas.
3. Artritis séptica de cadera.
4. Se necesita realizar una artrocentesis para establecer el diagnóstico.

Respuesta correcta: 1.

Comentario:

Pregunta típica de enfermedad de Perthes, ya preguntada en muchas otras ocasiones: habitualmente varón de menos de 9 años con retraso de la edad ósea, cojera, leve dolor, limitación a las rotaciones y la abducción. En la radiografía se observa inicialmente una epífisis femoral derecha esclerótica y más pequeña, que posteriormente se va fragmentando (es la imagen que acompaña a esta pregunta), y finalmente se reosifica y remodela.

27. Pregunta asociada a la imagen 27.

Mujer de 50 años con lupus eritematoso sistémico que consulta por dolor en rodillas. En la radiografía radiografía anteroposterior de rodillas se aprecian signos compatibles con todas las enfermedades que a continuación se enumeran salvo una. Indíquela:

1. Artritis psoriásica.
2. Artrosis.
3. Osteonecrosis.
4. Enfermedad por depósito de pirofosfato cálcico (condrocalcinosis).

Respuesta correcta: 1.

Comentario:

Se trata de una radiografía anteroposterior de rodillas en la que se observan calcificaciones en el cartílago hialino compatibles con condrocalcinosis, pinzamiento de ambos compartimentos mediales como signo de artrosis y necrosis bilateral con fibrosis medular y formación de hueso nuevo en trabéculas muertas.

28. Pregunta asociada a la imagen 28.

Se realiza un meta-análisis de dos estudios que comparan un nuevo anticoagulante frente a acenocumarol. Los resultados se muestran en la imagen. Señale la respuesta correcta:

1. Se ha utilizado un modelo de efectos fijos, y es por ello que el estudio con menor número de pacientes tiene más peso en el metaanálisis.
2. Se ha utilizado un modelo de efectos fijos, aunque no es el más apropiado en este caso, ya que hay heterogeneidad significativa entre los estudios.
3. Se ha utilizado un modelo de efectos fijos, y el valor de P de heterogeneidad ($P=0,02$) indica que el nuevo anticoagulante es superior al acenocumarol.
4. El intervalo de confianza al 95% para el resultado combinado (total) (0,40-0,95) es más amplio que el que se hubiese obtenido usando un modelo de efectos aleatorios.

Respuesta correcta: 2.

Comentario:

Se trata de una pregunta de metanálisis en que debemos fijarnos, primero de todo, en el tipo de modelo que se utiliza, y para esto tenemos dos pistas. La primera es que se puede observar la palabra “fixed” en el gráfico de la imagen, y la segunda es que, como podéis ver, los estudios son muy diversos o “heterogéneos” en sus resultados, pero sin embargo parece que el único que realmente “pesa” es el de mayor tamaño muestral, lo cual nos dice que se está aplicando un modelo de efectos fijos. Lo siguiente que deberemos investigar es si existe o no heterogeneidad. Aunque gráficamente quede claro que sí que la hay, necesitamos un parámetro “estadístico-matemático” que así nos lo confirme. En la gráfica lo encontraremos en el apartado “heterogeneity”, donde vemos que la P es de 0,02, o sea, significativa. Por ello, sí que existe heterogeneidad. Por tanto, respuesta correcta es la número 2.

29. Pregunta asociada a la imagen 29.

Un ensayo clínico, publicado en New England Journal of Medicine, estudió el efecto de administrar un tratamiento anticoagulante “puente” subcutáneo con heparina de bajo peso molecular respecto de un placebo en pacientes con tratamiento anticoagulante crónico que estaban programados para una intervención quirúrgica, a los que se interrumpió el anticoagulante oral desde unos días antes de la cirugía hasta las 24 horas postoperatorias. Tanto la heparina como el placebo se administraron por vía subcutánea desde 3 días antes y hasta 24 horas antes de la intervención, y posteriormente, desde los días 5 a 10 postoperatorios. El análisis principal fue para contrastar si el tratamiento con placebo (No bridging) era inferior a la heparina (Bridging), considerando un margen de inferioridad del 1% para la diferencia en la aparición de tromboembolismo arterial. Considerando los datos de la tabla adjunta, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?:

1. Se observó una frecuencia significativamente menor de tromboembolismo arterial en el grupo que recibió tratamiento anticoagulante puente.
2. No se observaron diferencias significativas en la mortalidad entre los dos grupos.
3. La administración de tratamiento “puente” con heparina de bajo peso molecular se asoció a una mayor frecuencia de sangrados mayores y menores.
4. Se pudo concluir que el tratamiento con placebo no es inferior en cuanto a la frecuencia de tromboembolismo arterial que la utilización “puente” de heparinas de bajo peso molecular, descartando diferencias superiores a un 1%.

Respuesta correcta: 1.

Comentario:

Resulta un poco liosa la pregunta porque nos mezclan en un mismo estudio análisis de superioridad y de no-inferioridad, cuando siempre hemos dicho que un estudio o se hace con una finalidad o se hace con la otra, pero no se pueden hacer ambas cosas a la vez. Pero así es el MIR, y hay que ser, en ocasiones, flexible con el contenido de las preguntas. Asumiendo esto, vemos que la diferencia para el tromboembolismo, en cuanto análisis de superioridad, es claramente no significativa. Por tanto, no podemos hablar de que se observó una frecuencia significativamente menor con ninguno de los tratamientos, porque esa hipótesis, que es de superioridad, no se corresponde con los datos. La interpretación de los datos nos da la respuesta 4, aunque puede resultar ligeramente liosa por la frase “descartando diferencias superiores al 1%”. Dicho de esta manera parece que sería el límite de no-inferioridad que debemos asumir, aunque ni el enunciado ni la gráfica nos dan esta información.

30. Pregunta asociada a la imagen 30.

Una niña de 7 años ingresa en el hospital por presentar un cuadro de 72 horas de evolución de fiebre de hasta 38,5°C, malestar general y dificultad para la deglución. A la exploración presenta una erupción cutánea generalizada cuyas características se pueden apreciar en la imagen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Síndrome de la piel escaldada.
2. Síndrome de Stevens-Johnson.
3. Enfermedad mano-pie-boca atípica.
4. Penfigoide ampolloso.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En la imagen observamos un cuadro cutáneo agudo en forma de máculas eritematopurpúricas con despegamiento y formación de ampollas y abundantes costras en la mucosa oral. Se trata de un síndrome de Stevens-Johnson, que es un tipo de toxicodermia grave que afecta la piel y las mucosas, acompañado de mal estado general. Habitualmente el origen es farmacológico y puede afectar otros epitelios, lo que justificaría la disfgia de la paciente.

31. Mujer de 20 años con tumoración ovárica de 15 cm, sólido-quística, detectada por ecografía tras presentar síntomas abdominales inespecíficos. En el estudio histopatológico de la pieza correspondiente se encuentran dientes, pelos, zonas de epitelio intestinal, áreas de epitelio escamoso (15%) y bronquial, así como elementos neuroectodérmicos y embrionarios en varias de las preparaciones histológicas. En referencia a este caso, señale el diagnóstico correcto:

1. Teratocarcinoma.
2. Teratoma inmaduro.
3. Teratoma quístico maduro.
4. Disgerminoma.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La presencia de tejidos normales procedentes de las tres capas germinales (dientes, pelo, epitelio) en un tumor de ovario debe hacernos pensar en un teratoma. Sin embargo, si además este tumor presenta tejidos inmaduros (elementos neuroectodérmicos y embrionarios) el diagnóstico es de teratoma inmaduro (respuesta 2 correcta). El disgerminoma deriva directamente de la célula germinal, por lo que no presenta tejidos maduros, y el teratocarcinoma es un tumor con áreas de teratoma y áreas de carcinoma embrionario o coriocarcinoma.

32. Mujer de 59 años que presenta diarrea crónica acuosa de 4 meses de evolución. En la endoscopia, la mucosa no mostraba aspectos relevantes. En concreto, no se observaron úlceras o áreas friables. Se realizó biopsia del

colon transversal. En el estudio histopatológico se reconoció un área engrosada por debajo del epitelio de revestimiento superficial, que era más evidente mediante técnica de trícromico de Masson y que conllevaba atrofia y denudación epitelial. También se apreció un claro incremento en la densidad de linfocitos intraepiteliales. ¿El diagnóstico de la lesión intestinal es?:

1. Colitis ulcerosa crónica.
2. Colitis pseudomembranosa.
3. Colitis colágena.
4. Enfermedad de Crohn fibrosante.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de un caso prototípico de colitis colágena (una de las formas de colitis microscópica junto a la linfocítica). Es una mujer de unos 60 años (la patología es más frecuente en el sexo femenino y a esa edad tiene el pico de incidencia) y, sobre todo, nos hablan de una diarrea crónica acuosa + endoscopia rigurosamente normal (éste dato sólo nos descartaría las opciones 1, 2 y 4 que en la colonoscopia tendrían sus hallazgos típicos de inflamación, pseudomembranas y úlceras) + alteraciones histológicas compatibles (sobre todo, en este caso, la gruesa banda de colágeno subepitelial, que se tiñe específicamente con el trícromico de Masson). El tratamiento de elección es la budesonida oral con una buena respuesta en un gran porcentaje de pacientes.

33. Mujer de 67 años diagnosticada de un carcinoma ductal infiltrante de mama y sin historia familiar de neoplasia. ¿Qué estudios adicionales deben realizarse en el tumor por sus implicaciones clínico-terapéuticas?:

1. Estudio fenotípico completo mediante citometría de flujo.
2. Estudio de receptores hormonales y de HER2.
3. Estudio de receptores hormonales, E-cadherina y estudio de familiares de primer grado.
4. Estudio de BRCA 1-2 y estudio de familiares de primer grado.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En toda mujer con diagnóstico de cáncer de mama se estudia la inmunohistoquímica del tumor por su implicación clínico-terapéutica. En dicha inmunohistoquímica se incluyen: los receptores hormonales y la presencia de HER2NEU -también el estudio del KI67 aunque no lo incluya la respuesta- (respuesta 2 correcta). De esta forma podremos clasificar los tumores en luminales, HER 2 positivos o triple negativos; lo cual nos dará información sobre el pronóstico de la paciente (importancia clínica) y sobre el tratamiento que deberá estar incluido en su plan terapéutico (importancia terapéutica). No a todas las pacientes se les debe estudiar el BRCA. En este caso, dado que la paciente no es joven y que no tiene antecedentes familiares de cáncer de mama el estudio BRCA no está justificado.

34. ¿Cuál es la lesión anatomopatológica característica de la enfermedad de Creutzfeldt Jakob en el cerebro?:

1. Reacción inflamatoria perineuronal.
2. Cuerpos de inclusión en las neuronas.
3. Acúmulos de depósitos fibrilares en el intersticio.
4. Vacuolización del neuropilo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El examen microscópico cerebral en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob se caracteriza por la presencia de astrogliosis y placas amiloides así como por el aspecto microvacuolado de la sustancia gris.

35. ¿Cuál de los siguientes agonistas de receptores adrenérgicos tiene efecto hipotensor?:

1. Dopamina.
2. Clonidina.
3. Terbutalina.
4. Efedrina.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta teórica y que puede sacarse por descarte: la dopamina y la efedrina son drogas simpaticomiméticas (por lo que suben la presión arterial). La terbutalina es un broncodilatador (agonista beta2). Así, por descarte, nos queda la clonidina, que es un agonista alfa2 con efecto simpaticolítico a nivel central: por ello, baja la presión arterial.

36. Respecto a la hepatotoxicidad por paracetamol, señale la respuesta correcta:

1. Resulta agravada por el déficit de vitamina E.
2. La N-acetilsalicilina reduce la gravedad de la necrosis.
3. Se produce por la acumulación de un metabolito tóxico del glutatión.
4. El patrón de presentación más habitual es el colestásico.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta anulada, compleja que aborda los mecanismos que modifican la toxicidad por paracetamol, que son fundamentalmente tres: 1. Inducción del citocromo P450: este citocromo transforma al paracetamol en N-acetil-p-benzoquinonemina (NAPQI), un metabolito intermedio altamente reactivo y electrofilo. Este compuesto es capaz de unirse a moléculas del hepatocito, produciendo stress oxidativo y necrosis hepatocelular (hepatotoxicidad con patrón hepatocelular, no patrón colestásico, respuesta 4 incorrecta) 2. Depleción de glutatión: NAPQI en condiciones normales es conjugado rápidamente con glutatión, formando compuestos, que no son tóxicos (respuesta 3 incorrecta). Cuando las reservas de glutatión se depletan en

un 70%, NAPQI comienza a acumularse produciendo daño hepatocelular. Períodos de ayuno y desnutrición, condiciones frecuentes en el alcoholismo, pueden llevar a depleción de glutatión y aumento del riesgo de toxicidad por paracetamol 3. Factores genéticos. Los polimorfismos existentes en los diferentes citocromos pueden explicar diferencias en la susceptibilidad a la intoxicación. La pregunta es muy difícil de responder, dado que la opción 2 habría sido cierta si en vez de poner "N-acetilsalicilina" hubiera puesto "N-acetilcisteína" (que es el antídoto de la intoxicación por paracetamol). Al encontrar una respuesta así en el MIR lo más probable es que sea una errata y que el autor hubiera querido poner "N-acetilcisteína"; por dicho motivo, el Ministerio decidió anular esta pregunta. La respuesta 1 fue la inicialmente dada como correcta. La N-acetilcisteína es un precursor de glutatión que previene la toxicidad por paracetamol al limitar la acumulación de NAPQI. En etapas más tardías de la intoxicación, N-acetilcisteína es beneficiosa a través de mecanismos anti-inflamatorios y antioxidantes. La vitamina E, al tener propiedades antioxidantes, podría mejorar también la hepatotoxicidad (respuesta 1 correcta).

37. Entre los fármacos opiáceos, ¿cuál evitaría en un paciente con historia de predisposición a presentar convulsiones?:

1. Tramadol.
2. Hidroxicodona.
3. Fentanilo.
4. Morfina.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Se han comunicado convulsiones en pacientes tratados con tramadol a las dosis recomendadas (respuesta 1 correcta). Este riesgo puede aumentar si se excede el límite superior de la dosis diaria recomendada. Adicionalmente, tramadol puede incrementar el riesgo de que el paciente presente crisis epilépticas si está recibiendo otra medicación que reduzca el umbral convulsivo (ISRS...) Los pacientes epilépticos o aquellos susceptibles de presentar convulsiones solo deberán ser tratados como analgésico con paracetamol u otras alternativas terapéuticas. Con otros opiodes también han sido descritos casos puntuales de convulsiones, pero con mucha menor frecuencia que con tramadol (respuestas 2, 3 y 4 incorrectas).

38. Se considera que dos fármacos son bioequivalentes cuando:

1. Contienen el mismo principio activo, aunque cambien los excipientes.
2. Su vida media biológica, semivida o t_{1/2}, no difiere en más de un 5%.
3. Los procesos de biotransformación metabólica tienen lugar a través de las mismas isoformas enzimáticas.
4. Presentan una biodisponibilidad similar.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Recordad que un fármaco bioequivalente es aquél con un mismo principio activo (aunque los excipientes pueden cambiar) que demuestra una farmacocinética y biodisponibilidad similares (traducido en un IC del 90% del 80-125% de varios parámetros farmacocinéticos, dividiendo los valores del fármaco original entre los del genérico: concentración plasmática máxima, tiempo hasta alcanzar dicha concentración, y área bajo la curva -que representa la cantidad total de fármaco absorbida-). Así, en esta pregunta tanto la respuesta 1 como la 4 son correctas. El Ministerio dio como respuesta correcta la 4, si bien consideramos que es una pregunta impugnada por haber 2 opciones correctas.

39. La glucosa se metaboliza dentro de la célula beta para estimular la secreción de insulina. ¿Cuál de los siguientes elementos NO interviene en dicho proceso?:

1. Glucoquinasa.
2. Transportador de glucosa (GLUT).
3. Canal de calcio.
4. Enzima limitante de la insulino-secreción.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sobre fisiología pancreática difícil desde el punto de vista teórico pero acertable por técnica MIR. La glucosa es el regulador esencial de la secreción de insulina por la célula β . Cuando la glucemia supera un nivel umbral, la glucosa entra en la célula β a través del transportador GLUT2. La fosforilación de la glucosa por la glucoquinasa es el paso limitante que controla la velocidad de secreción de insulina. El metabolismo de la glucosa-6-fosfato genera ATP, que inhibe unos canales de potasio en la membrana celular, produciendo la despolarización de la membrana y abriendo secundariamente los canales de calcio. La entrada de calcio en el interior celular estimula la secreción de insulina. Así pues, las opciones 1, 2 y 3 son correctas. Si no conociéramos a fondo la fisiología de la célula β (lo que es razonable, ya que nunca se había preguntado previamente), la picardía nos ayudaría a acertar: se nos pregunta por cuál de los elementos NO interviene en la estimulación de la secreción de insulina. La enzima limitante de la insulino-secreción (que como tal, no existe) tendría, como su propio nombre indica, un efecto inhibitorio y no estimulador de la secreción.

40. Respecto de la vitamina B12 ¿qué opción considera correcta?:

1. Su principal fuente para el organismo es la ingesta de frutas y verduras.
2. Sus depósitos se localizan en el hígado.
3. Se conjuga en el íleon con el factor intrínseco.
4. Su déficit conduce a reducción de los niveles de homocisteína en plasma.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta acerca de la fisiología de la vitamina B12 que se está convirtiendo en un clásico en el MIR de los últimos años. Las fuentes principales de vitamina B12 son de origen (la carne, pescados y las vísceras) (opción 1 falsa). El factor intrínseco y la proteína ligadora de cobalamina se producen en el estómago. La vitamina B12 se une a la proteína ligadora de cobalamina en el estómago. Sin embargo, es en el duodeno donde, por acción de una lipasa pancreática, el complejo se escinde en dos produciéndose entonces la unión de la vitamina B12 al factor intrínseco (FI) (opción 3 falsa). Desde el duodeno la vitamina B12 unida al FI continúa su recorrido por el intestino delgado para ser finalmente absorbida en el íleon. El reservorio principal de la vitamina B12 está el hígado (opción 2 verdadera). La vitamina B12 actúa como coenzima en el metabolismo de la homocisteína. Por lo tanto, su déficit conduce a un aumento de los niveles de homocisteína (opción 4 falsa).

41. Con respecto al músculo esquelético, elija la opción correcta:

1. En reposo, el músculo solo tiene ATP suficiente para mantener la contracción durante unos segundos.
2. La creatina fosfato es una molécula con un potencial de transferencia de fosforilos bajo.
3. Durante un ejercicio intenso, la lactato deshidrogenasa oxida el piruvato en exceso a lactato.
4. La alanina es utilizada para transportar nitrógeno y esqueletos carbonados desde el hígado al músculo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El músculo tiene una reserva energética en la que destaca el ATP (adenosín trifosfato), la fosfocreatina, la glucosa y los ácidos grasos. Cuando el músculo está en reposo, su fuente energética principal (95%) son los ácidos grasos. Pero cuando comienza la actividad física el combustible cambia para poder atender la demanda que el ejercicio le exige. En los primeros momentos debe recurrir a los combustibles de disposición inmediata: el ATP y la fosfocreatina. El ATP de reserva solo puede suministrar energía en los primeros dos a cinco segundos posterior al inicio de la contracción por estar en concentraciones muy limitadas (respuesta 1 correcta). Pero, por ser el ATP el principal mediador en todos los procesos oxidativos, el músculo debe recurrir a la resíntesis de ATP a través de dos mecanismos: uno de acción rápida mediante la fosfocreatina durante los primeros 8 a 15 segundos tras iniciar la contracción y otra de acción más lenta como lo son los procesos en los que se genera energía a través de la oxidación de glucosa, ácidos grasos y eventualmente aminoácidos y cuerpos cetónicos. Estos procesos oxidativos pueden tener lugar en presencia de oxígeno (metabolismo aeróbico) o en ausencia del mismo (metabolismo anaeróbico). Al comienzo, después de agotar las reservas musculares del ATP y de fosfocreatina,

comienza el metabolismo anaeróbico de la glucosa con la posterior formación de ácido láctico. Una vez que se ha alcanzado los niveles adecuados de adaptación cardiovascular y respiratoria –aproximadamente 90 segundos después de iniciado el entrenamiento– comienza el metabolismo aeróbico de la glucosa el cual va a ser la principal fuente de energía en los próximos treinta minutos de ejercicio. Transcurrido este tiempo, seguiremos con un proceso oxidativo aeróbico pero utilizando los ácidos grasos de reserva como fuente de energía.

42. Amalia es una niña de 3 años que ha sido intervenida de tetralogía de Fallot. Presentó además una disfunción tímica en el periodo neonatal y una hipocalcemia así como una voz nasal junto a retraso psicomotor. ¿Qué prueba genética considera más adecuada para llegar a su diagnóstico etiológico?:

1. Estudio de delección 22q11 (síndrome de Di-George o Velo-cardio-facial).
2. Estudio de la expansión del gen FMR1, responsable del síndrome de X frágil.
3. Secuenciación de los genes relacionados con el HRAS (síndrome de Noonan).
4. Estudio genético de síndrome de Williams Beuren.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El síndrome de DiGeorge se produce por una malformación congénita que afecta al tercer y cuarto arcos faríngeos. La inmunodeficiencia es secundaria a la aplasia tímica. El defecto genético se localiza a nivel del cromosoma 22q11. Se asocia a malformaciones cardíacas, tetania por hipocalcemia (ausencia de paratiroides), y rasgos faciales toscos (micrognatia, hipertelorismo.). Al no tener timo, en los pacientes con síndrome de DiGeorge no pueden madurar los linfocitos T. La función inmunológica suele mejorar con la edad por hipertrofia de restos de timo ectópicos. En caso de no ser así, el tratamiento definitivo del síndrome de DiGeorge intenta suplir dicha carencia y puede realizarse mediante dos técnicas: trasplante de células de timo o trasplante de células hematopoyéticas de donante HLA idéntico.

43. Francisco es un niño afecto de fenilketonuria, enfermedad autosómica recesiva debida a mutaciones del gen de la fenilalanina hidroxilasa. ¿Qué posibilidades tienen sus padres de tener otro hijo afecto de dicha enfermedad?:

1. Un 50% independientemente del sexo de los hijos.
2. Un 25% independientemente del sexo de los hijos.
3. Un 50% de los niños y un 25% de las niñas.
4. Un 50% de las niñas y un 25 % de los niños.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La herencia autosómica recesiva se da cuando el alelo alterado es recesivo sobre el normal, por lo que con una sola copia del alelo alterado no se expresa la enfermedad. El alelo alterado tiene que heredarse tanto del padre como de la madre para que se exprese. Al ser autosómico, el gen se encuentra en uno de los 22 pares de cromosomas no sexuales, o autosomas, pudiendo afectar con igual probabilidad a hijos e hijas (respuesta 3 y 4 incorrectas). Lo más habituales es que los padres sean heterocigotos (portadores sanos). Los hijos de una pareja en la que ambos son portadores tienen una probabilidad del 50% de ser portadores de una copia del alelo alterado (no expresarán la enfermedad pero podrían transmitirla a sus descendientes), 25% de probabilidad de tener dos copias del alelo alterado y desarrollar la enfermedad autosómica recesiva (respuesta 2 correcta) y 25% de probabilidad de heredar dos copias del alelo normal y no desarrollar la enfermedad ni ser portador.

44. Indique la variante genética del HLA que expresa el 90 % de los pacientes celíacos:

1. DQ8.
2. DQ2.
3. B27.
4. B12.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La enfermedad celíaca tiene una predisposición genética conocida en algunas personas con determinados haplotipos HLA. Un 90-95% de los pacientes con enfermedad celíaca presentan un haplotipo HLA-DQ2, mientras que un 5% presentan un HLA DQ8. Un despreciable número de pacientes presentan otras variedades.

45. Señale la respuesta INCORRECTA respecto al edema angioneurótico hereditario de tipo I:

1. Se hereda siguiendo un patrón de herencia autosómico recesivo.
2. Se debe a una deficiencia cuantitativa de la proteína C1-inhibidor.
3. Se caracteriza por brotes repetitivos y autolimitados de angioedema, que pueden poner en riesgo la vida del paciente.
4. Es el déficit hereditario de complemento más frecuente.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El déficit de C1-inhibidor es el déficit genético del complemento más frecuente en nuestro medio y presenta una herencia autosómica dominante. Produce el síndrome angioneurótico familiar, que se caracteriza por ataques agudos y recurrentes de edema angioneurótico (edemas circunscritos y bien localizados, desencadenados por traumatismos o estrés). Se han descrito tres tipos: - Tipo I.

Disminución en la concentración sérica de C1-inhibidor por mutación en el gen de C1-inhibidor. - Tipo II. Mutaciones en el gen de C1-inhibidor que da lugar a concentraciones normales de C1-inhibidor pero no funcionante. - Tipo III. Secundario a mutaciones en el gen del factor XII de la coagulación. El diagnóstico se establece mediante la cuantificación de los niveles séricos circulantes y/o el estudio de la actividad funcional de C1-inhibidor. Esta pregunta sirve para repasar los conceptos clave de esta enfermedad.

46. ¿Cuál de los siguientes cambios genéticos es capaz de modificar la región variable del alelo que codifica para la cadena ligera de una inmunoglobulina después de que el linfocito B que la expresa reconozca un antígeno en un ganglio linfático?:

1. Recombinación somática.
2. Diversidad de unión por adición de nucleótidos N (no codificados).
3. Hipermutación somática.
4. Diversidad de unión por adición de nucleótidos P (palindrómicos).

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta difícil por cómo está formulada. Nos preguntan cuál es el proceso en el cual se modifica la región variable de una de las cadenas de la inmunoglobulina, una vez que este linfocito ya haya reconocido el antígeno. Recordad que inicialmente el linfocito B reordena sus genes de inmunoglobulinas (reordenamiento VDJ) y, posteriormente, al reconocer un antígeno, puede “perfeccionar” la afinidad de esta inmunoglobulina induciendo mutaciones en la región variable, que es lo que se conoce como hipermutación somática.

47. Un hombre de 58 años refería una historia de 3 semanas de evolución con lesiones cutáneas progresivas, medianamente dolorosas, en su brazo izquierdo. Había empezado como una lesión eritematosa en su pulgar izquierdo. Tenía unas estrías rojizas visibles como líneas de conexión entre las lesiones. El paciente no presentaba fiebre ni otros síntomas generales. Había estado trabajando en su jardín pero no recordaba haberse hecho ninguna herida. El diagnóstico etiológico se realizó por cultivo de una biopsia cutánea. ¿Cuál es el agente causal más probable de este proceso?:

1. Dermatitis por *Microsporum gypseum*.
2. Infección cutánea por *Staphylococcus aureus*.
3. Esporotricosis.
4. Infección cutánea por *Mycobacterium marinum*.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La esporotricosis es una micosis subcutánea que aparece

típicamente en jardineros, por inoculación de esporas tras un pinchazo accidental en manos o antebrazo. El cuadro clínico es bastante característico: en el lugar del pinchazo aparece una lesión ulcerada de evolución tórpida que se asocia a adenopatías y linfangitis regional, en la pregunta referida como “estrías rojizas visibles como líneas de conexión entre las lesiones”. El *Mycobacterium marinum*, que origina el granuloma de los acuarios, también puede originar un patrón esporotricoide pero nos indicaría contacto con aguas o peceras.

48. El germen que produce con mayor frecuencia bursitis séptica es:

1. *Streptococcus viridans*.
2. *Staphylococcus aureus*.
3. *Neisseria gonorrhoeae*.
4. *Streptococcus pneumoniae*.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El germen que con más frecuencia (>80%) se encuentra en los cultivos de bursitis sépticas es el *Staphylococcus aureus*. Los estreptococos de varias especies son los gérmenes que se han aislado en segundo lugar. Menos común es encontrar bursitis sépticas por *Staphylococcus coagulans* negativo, enterococo, *Escherichia coli*, *Pseudomonas* y anaerobios.

49. ¿Cuál es el reservorio de *Salmonella typhi* A en una persona portadora?:

1. Los divertículos del colon.
2. La vesícula biliar.
3. El intestino delgado.
4. El intestino grueso.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Recuerda que tras una fiebre tifoidea estas bacterias pueden persistir en la vía biliar hasta un año después del episodio agudo, sobre todo si hay alteración estructural de la vía biliar o litiasis, o si no se ha hecho tratamiento antibiótico correcto (ceftriaxona o quinolonas si la cepa es sensible).

50. En pacientes con enfermedades hematológicas, ocasionalmente puede producirse un cuadro de “cistitis hemorrágica”. Entre las múltiples etiologías de este proceso se incluyen algunos virus. ¿Cuál de los citados a continuación es el más frecuentemente implicado?:

1. Poliovirus BK.
2. Virus herpes simplex tipo 2.
3. Poxvirus.
4. Enterovirus 71.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta directa. En pacientes trasplantados de médula ósea es

típica la cistitis hemorrágica por dos virus: Poliomavirus BK y adenovirus, provocando situaciones con hematuria grave.

con terapia antibiótica según antibiograma durante 6 semanas.

51. Una de las siguientes afirmaciones referidas a los virus de la hepatitis NO es correcta. Indíquela:

1. En contraste con el VHB y VHC, la transmisión por sangre del VHA es poco común, porque la viremia es breve y de bajo título.
2. El VHE es un virus defectivo que usa el antígeno de superficie del VHB como su proteína de envoltura.
3. La polimerasa codificada por el VHB actúa como una transcriptasa inversa usando el RNAm vírico como molde para la síntesis de los genomas de DNA progenie.
4. La detección del HBsAg durante más de seis meses indica un estado del portador crónico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Respecto a la opción 1 recordar que la principal vía de transmisión del VHA es la enteral por lo que la viremia suele ser baja y de escaso título. La 2 es falsa ya que el virus defectivo que requiere del HBsAg es el VHD (hepatitis Delta). La 3 es cierta, la polimerasa del VHB tiene actividad transcriptasa inversa (por este motivo hay fármacos que son activos frente al VHB y al VIH como Lamivudina o Tenofovir). La 4 es cierta: es por la persistencia del HBsAg más de seis meses cómo se define que un paciente es portador crónico del VHB (sea HBe Ag negativo o positivo).

52. Paciente de 54 años que ingresa por fiebre termometrada de 38°C en los cinco días previos y disnea de reposo (NYHA IV) que apareció 6 horas antes de acudir al hospital. En urgencias la exploración es compatible con insuficiencia cardíaca y el ECG muestra bloqueo auriculoventricular completo con una frecuencia ventricular de escape de 45 lpm. Los signos de insuficiencia cardíaca son refractarios al tratamiento médico y la ecocardiografía transesofágica realizada muestra una válvula aórtica con orificio regurgitante efectivo de 0.5 cm². Los cultivos sanguíneos son positivos para Streptococcus gallolyticus. Indique la actitud más acertada:

1. Cirugía cardíaca de reemplazo valvular aórtico por prótesis mecánica con terapia antibiótica según antibiograma.
2. Terapia antibiótica según antibiograma e implantación de balón de contrapulsación intra-aórtico y marcapasos transitorio hasta 3 semanas, tras las cuales se implantará marcapasos definitivo.
3. Implantación de marcapasos transitorio, terapia antibiótica según antibiograma e implantación percutánea de prótesis valvular aórtica.
4. Implantación urgente de marcapasos definitivo

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla sobre el tratamiento de la endocarditis infecciosa, donde quizá la única duda puede estar en el reconocimiento de la endocarditis. La paciente presenta fiebre y hemocultivos seriados positivos para Streptococcus gallolyticus (el antiguo S. bovis), un microorganismo típico de endocarditis y solo con esto ya es una posible endocarditis infecciosa con los criterios de Duke en la mano (tiene uno mayor -los hemocultivos- y uno menor -la fiebre-). Aunque no dicen nada de vegetación por ningún sitio el hecho de que una paciente joven aparezca con un bloqueo AV en este contexto de fiebre y hemocultivos positivos hace sospechar que la paciente tiene un absceso paravalvular afectando al nodo AV que por lo que sea no se ha visualizado en el ecocardiograma, lo que sería otro criterio de endocarditis. En cualquier caso, con una (como mínimo) posible endocarditis la paciente presenta una insuficiencia cardíaca refractaria y eso es indicación de cirugía urgente (opción 1), además del probable absceso paravalvular, que sería otra indicación de cirugía, por lo que cualquier opción que no sea quirúrgica no hay ni que considerarla. Podría haber alguna duda con la opción 3, pero en una endocarditis activa no se puede poner una prótesis por vía endovascular y dejarla encima de otra que está infectada.

53. Mujer de 84 años que acude por pérdida de visión en el ojo izquierdo de 4 días de evolución acompañada de metamorfopsias. En la mácula se aprecian abundantes exudados duros, dos pequeñas hemorragias profundas y un desprendimiento de la retina neurosensorial localizado. En el ojo contralateral presenta abundantes drusas blandas. Ante este cuadro, ¿Cuál de los siguientes diagnósticos le parece más probable?:

1. Desprendimiento posterior de vítreo agudo.
2. Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) Exudativa.
3. Obstrucción de arteria central de la retina.
4. Neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad baja. El caso clínico es un paciente con una degeneración macular asociada a la edad (DMAE). La clave para contestar esta pregunta es reconocer el síntoma típico: las metamorfopsias y el signo típico del fondo de ojo: las drusas (en este caso en el ojo contralateral, recuerda que la DMAE es una enfermedad bilateral y asimétrica en la mayoría de los casos). Al tener una clínica de corta evolución (4 días) y un desprendimiento de retina neurosensorial localizado y hemorragias, se trata de una DMAE de tipo húmedo o exudativa. Recuerda que en el

mercado nacional tenemos actualmente tres opciones de tratamiento: ranibizumab, bevacizumab y aflibercept. En el desprendimiento de vítreo posterior los síntomas típicos son las miodesopsias y fotopsias. En la obstrucción de arteria central de la retina el signo típico del fondo de ojo es la mancha rojo cereza. En la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NOIA NA) en el fondo de ojo se observa un edema de papila, es decir el borde se ve borroso y se acompaña de hemorragias.

54. En un ensayo clínico realizado en mujeres posmenopáusicas con un nuevo bifosfonato frente a placebo, se obtiene como resultado una reducción del 20% de fracturas vertebrales radiológicas. ¿Cuál sería el NNT (número de pacientes que será necesario tratar) de esta intervención terapéutica en comparación con placebo?:

1. 80.
2. 5.
3. 20.
4. 90.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta clásica del MIR. Cálculo del NNT. Normalmente nos suelen dar los valores absolutos de cada grupo, y debemos nosotros hacer la resta, pero fijaos que en esta pregunta ya nos han dado la reducción absoluta del riesgo (RAR), además en porcentaje (20%), por lo que sólo nos queda dividir 100 entre este valor: $NNT = 100/RAR$ (expresada en porcentaje) = $100/20 = 5$.

55. Entre los elementos conceptuales que definen la Atención Primaria de Salud está el concepto de atención integral. ¿Cuál es su significado?:

1. Interrelación de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación e inserción social.
2. A lo largo de toda la vida de la persona (desde su nacimiento hasta su muerte).
3. Abordando las esferas física, psíquica y social.
4. Coordinando la atención en consulta y en domicilio, ya sean a demanda o programadas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La respuesta correcta es la 3. La 1 se refiere al concepto de medicina Integrada, la 2 de Longitudinal y la 4 de Continuada. Todas ellas características de la Medicina de Familia.

56. Señale la respuesta correcta respecto a los siguientes fármacos biológicos utilizados en el tratamiento de las enfermedades reumáticas:

1. Etanercept es un anticuerpo monoclonal quimérico contra el TNF.
2. Abatacept impide la maduración de linfocitos

B a células plasmáticas.

3. Anakinra es un antagonista recombinante de los receptores de IL-6.
4. Adalimumab es un anticuerpo contra el TNF completamente humano.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Etanercept es una proteína de fusión que bloquea el TNF. Abatacept es una proteína de fusión que actúa sobre la coestimulación de los linfocitos T. Anakinra es un antagonista de la IL-1 y adalimumab es un anticuerpo monoclonal humano que bloquea el TNF.

57. Respecto al adenoma pleomorfo, señale la respuesta correcta:

1. Es un tumor de las glándulas salivales que rara vez recidiva.
2. Afecta predominantemente a la glándula sublingual.
3. Se trata habitualmente mediante parotidectomía conservadora del nervio facial.
4. Se trata habitualmente mediante parotidectomía radical dada la posibilidad de recidiva.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El adenoma pleomorfo es el tumor benigno más frecuente de las glándulas salivares. Aparece más frecuentemente en la glándula parótida y su tratamiento es mediante parotidectomía superficial respetando el nervio facial. La parotidectomía total incluyendo la resección del nervio facial se reserva para el tratamiento de los tumores malignos.

58. Acude a la consulta un enfermo diagnosticado de esclerosis múltiple hace 6 meses. ¿Qué sintomatología NO esperaría encontrar?:

1. Diplopia.
2. Alteraciones auditivas.
3. Alteraciones urinarias.
4. Depresión.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La diplopia (típicamente causada por una oftalmoplejía internuclear) es un síntoma característico en la esclerosis múltiple. Las alteraciones urinarias (por afectación medular) y los síntomas depresivos (sobre todo en las primeras visitas tras el diagnóstico) son infrecuentes, pero entran dentro del abanico sintomático. A pesar de que el troncoencéfalo es una localización típica de las lesiones desmielinizantes, es raro que estos pacientes desarrollen alteraciones auditivas.

59. El Síndrome HELLP se define por un cuadro de:

1. Hipertensión arterial, proteinuria, edemas generalizados y aumento de peso por retención hídrica.

2. Anemia hemolítica microangiopática, disfunción hepática y trombocitopenia que puede progresar a coagulación intravascular diseminada, en gestantes con hipertensión arterial.
3. Anemia hemolítica, hipertensión arterial o elevación de la presión sistólica previa en 20 mm de Hg, proteinuria > 30 mg/dL en orina de 24 horas, elevación de transaminasas hepáticas y bajo nivel de conciencia.
4. Hipertensión arterial en gestantes de más de 20 semanas acompañada de anemia hemolítica, trombocitopenia, dolor epigástrico agudo y bajo nivel de conciencia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El síndrome de HELLP es el acrónimo de “Hemólisis”, “Liver” y “Low Platelets”. Se trata de un síndrome caracterizado por la presencia de anemia hemolítica microangiopática, alteración de las transaminasas por disfunción hepática y disminución de las plaquetas, que aparece en mujeres embarazadas con preeclampsia, siendo un criterio de gravedad de la misma cuando aparece. Dado que es el resultado de la presencia de trombos hepáticos e intravasculares secundarios a la liberación de tromboplastina placentaria se trata de un cuadro clínico grave que puede progresar a coagulación intravascular diseminada (respuesta 2 correcta).

60. ¿Cuál de los siguientes grupos de fármacos utilizados en el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata ha demostrado una disminución del tamaño de la glándula, así como la disminución del riesgo de desarrollar una retención aguda de orina?:

1. Inhibidores de la 5-alfa reductasa (5ARIs).
2. Inhibidores de la fosfodiesterasa E5 (PDE5).
3. Antagonistas de los receptores alfa adrenérgicos.
4. Antiangiogénicos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El tratamiento de la HBP esta basado en dos grupos de fármacos: alfabloqueantes cuya misión es relajar el cuello vesical y los inhibidores de la 5 alfareductasa (5ARI en ingles), que al inhibir este enzima evitan la conversión de testosterona en dihidrotestosterona. Con ello provocan una disminución del tamaño de la próstata, modificando la historia natural de la enfermedad en lo referente a episodios de retención urinaria y necesidad de cirugía a largo plazo.

61. ¿Cuál de las siguientes causas de disfunción eréctil reacciona con mayor sensibilidad a la inyección intracavernosa de drogas vasoactivas?:

1. Venosa.
2. Arterial.

3. Neurógena.
4. Hormonal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta impugnable sobre la terapéutica de la disfunción eréctil. Las inyecciones intracavernosas constituyen la segunda línea de tratamiento de esta patología. Las tasas de respuesta a la prostaglandina local son muy altas, hasta del 94% en patología cardiovascular y diabetes (respuesta 2) y son especialmente útiles en pacientes con neuropatías como post prostatectomía radical (respuesta 3), aunque no superan la eficacia de las anteriores. Clásicamente es el tratamiento de estos pacientes por su escasa o nula respuesta a la terapia oral, motivo por el cual el ministerio da esa respuesta como cierta.

62. Si consideramos el estado de respondedor a la vacunación frente Hepatitis B la presencia de HBsIgG >5mUI/mL en vez de >10mUI/mL:

1. Aumenta el área bajo la curva (AUC) del test diagnóstico de estado de respondedor a la vacuna frente Hepatitis B.
2. Aumenta la exactitud global del test diagnóstico de estado de respondedor a la vacuna frente Hepatitis B.
3. Aumentan los falsos negativos.
4. Aumenta la razón de verosimilitud positiva.

Respuesta correcta: 0

Comentario:

Pregunta confusa sobre un tema muy preguntado. Las respuestas 1 y 2 son falsas porque, cuando se modifica el punto de corte para definir enfermedad a partir de una variable, los aumentos conseguidos en sensibilidad o especificidad se contrarrestan por los descensos conseguidos en la especificidad o sensibilidad, respectivamente. Como resultado, la valide global de la prueba (área bajo la curva de una curva ROC) no se modifica. Hay otra dificultad añadida en la pregunta, y es que nos hablan de vacunas, y en general asociamos tener más anticuerpos de la vacuna a estar más “sano”. Pero ¡cuidado!, en la validación de una prueba diagnóstica, dar positivo para la vacunación deberíamos considerarlo como “enfermo”. Por tanto, cuanto mayor sea el título de anticuerpos, más “enfermo” debemos considerar ese punto de corte. Así, en el enunciado llevan el punto de corte hacia más “sano” (porque disminuimos la concentración de anticuerpo exigida para el diagnóstico), así que aumenta la sensibilidad. Acordaos de que una sensibilidad alta se asociaba a una baja tasa de falsos negativos. Por tanto, respuesta 3 falsa. Finalmente, razón de verosimilitud positiva (RVP) = sensibilidad / tasa de falsos positivos. Al elegir un punto de corte más “sano”, aumentará la sensibilidad del test, por lo que teóricamente aumentará la RVP (la respuesta 4 era la que hay que marcar y la respuesta inicialmente dada por válida por el Ministerio); el problema es que, a la vez que aumenta la sensibilidad, disminuye la especificidad, y con ello aumenta la tasa de falsos positivos. Mediante razonamientos matemáticos complejos se puede comprobar cómo realmen-

te la RVP disminuye. Por dicho motivo, al no haber ninguna opción correcta, la pregunta finalmente fue anulada.

63. Mujer de 64 años que acude a su consulta refiriendo sangrado genital de varios meses de evolución. Niega tratamiento hormonal sustitutivo y anticoagulación. Aporta citología cervicovaginal normal. Exploración física general y genital sin hallazgos de interés. IMC de 38 Kg/m². Indique la actitud más correcta:

1. Prescribir progesterona cíclica.
2. Biopsia endometrial.
3. Biopsias de cérvix al azar.
4. Valoración hormonal con FSH, LH y estradiol.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Mujer postmenopáusica que sangra: antes de cualquier tratamiento lo primero es descartar cáncer de endometrio mediante biopsia endometrial -respuesta 2 correcta-. Además en el caso clínico dan datos que descartan otras causas de sangrado: citología normal para que no penséis en patología cervical, exploración genital normal para descartar sangrado de genitales externos, no toma terapia hormonal sustitutiva ni anticoagulación, fármacos que podrían provocar un sangrado genital. Y la señora es obesa, un factor de riesgo para cáncer de endometrio.

64. Una mujer se presenta en la consulta con su hija de 3 años porque le ha detectado ligero desarrollo mamario desde hace 3 meses sin tomar medicación alguna ni objetivarse antecedentes relevantes en la historia. Efectivamente, el examen físico muestra un estadio Tanner IV, sin crecimiento del vello púbico o axilar. Los genitales externos son normales. La ecografía revela un pequeño útero y la radiología una edad ósea de 3 años. ¿Qué actitud se debería adoptar?:

1. Seguimiento cada 3-4 meses, ya que se trata de una condición temporal que a menudo se resuelve sola.
2. Biopsia mamaria.
3. Mamografía.
4. Administración de análogos GnRh.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Se presenta un caso clínico correspondiente a una telarquia prematura, que corresponde a un desarrollo mamario uni o bilateral antes de los 8 años de vida, sin otros signos de pubertad precoz. De etiología desconocida, la mayoría de ocasiones ocurre en los primeros años de vida y tiende a la regresión espontánea. Como se ha mencionado, no se acompaña de aumento de velocidad de crecimiento, cambios en la edad ósea, pubarquia o axilaria u otros signos

de pubertad precoz. No precisa tratamiento, por lo que se recomienda seguimiento periódico hasta resolución.

65. Un paciente ex fumador, diagnosticado previamente de EPOC acude a revisión. En la exploración física se detecta la existencia de hipocratismo digital de aparición reciente. ¿Cuál es la explicación más aceptable para este hallazgo en el contexto clínico que se describe?:

1. Carcinoma pulmonar.
2. Bronquiectasias.
3. Fibrosis pulmonar.
4. Cardiopatía cianótica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta MIR repetida casi exacta en el año 2010. Ante un paciente fumador que desarrolla acropaquias es obligado descartar cáncer pulmonar. La variante este año ha sido que no han mencionado acropaquias sino el término clásico/arcaico “dedos hipocráticos” (o hipocratismo digital).

66. Un paciente conocido por su mal carácter y actitud poco amable acudió a su consulta del centro de atención primaria hace unos días por un cuadro compatible con una bronquitis aguda. Tras la correspondiente evaluación, usted prescribió amoxicilina-clavulánico. El paciente acude de nuevo al segundo día por falta de mejora. A la exploración, no encuentra datos que hagan replantear el diagnóstico pero evidencia un exantema maculopapuloso difuso y observa que en la historia del paciente constaba el antecedente de alergia a la penicilina, que no había apreciado en la visita anterior. ¿Cuál cree que es la actitud más adecuada?:

1. Comentarle al paciente que el tratamiento no parece haber sido efectivo y cambiar el antibiótico, evitando más comentarios que puedan comprometerle. Ofrecerle un nuevo control en pocos días.
2. Comentarle al paciente que el tratamiento de la bronquitis puede ser fundamentalmente sintomático y que los antibióticos no necesariamente son efectivos por lo que, dada la evolución, lo más aconsejable es suspender la amoxicilina-clavulánico e iniciar tratamiento sintomático, con nuevo control en pocos días.
3. Comentar que la presencia del exantema puede ser un efecto adverso de la medicación pues la amoxicilina-clavulánico, que no es lo mismo que la penicilina, puede en ocasiones tener reacciones cruzadas con la misma y que es mejor suspender toda medicación y ver evolución. Ofrecerle un nuevo control en pocos días.

4. Comentar que la presencia del exantema puede ser un efecto adverso de la medicación pues la amoxicilina-clavulánico forma parte de la familia de las penicilinas y que usted, en la anterior visita no se percató de que el paciente era alérgico a la misma. Suspenderla en consecuencia, pedir excusas, proponer un tratamiento sintomático y ofrecerle un nuevo control en pocos días.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Siempre que se cometa un error humano por una acción no deliberada se debe rectificar lo antes posible y pedir disculpas al paciente sin ocultar el error. En este caso el despiste del médico al no fijarse en las alarmas del paciente ha provocado un efecto adverso evitable.

67. **Paciente de 46 años de edad, hipertenso y sin otros antecedentes patológicos de interés. Acude a consulta por presentar una tumoración anterior paraesternal izquierda no dolorosa de dos meses de evolución y sin otro síntoma añadido. A la exploración física se aprecia una masa dura de 4,5 x 4 cm, no dolorosa, sin retracción de la piel y adherida a planos profundos. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?:**

1. Al tratarse de una masa anterior no dolorosa, se debe considerar un tumor benigno.
2. Como primera medida debe descartarse un tumor condroide dado que son los más frecuentes en esta localización.
3. No está indicada la realización de una biopsia por el peligro de diseminación local del tumor.
4. Es preferible mantener una actitud conservadora, evaluando la evolución y posible crecimiento de la tumoración.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta difícil por tratarse de un tema novedoso en el MIR, los tumores de pared torácica. Ante una tumoración de pared torácica anterior, hay que recordar que el diagnóstico más habitual es tumor de origen condroide. Lo más probable es un osteocondroma, tumor benigno. La segunda posibilidad es displasia fibrosa. Menos probable es condrosarcoma. Dado que no se puede descartar un origen maligno (opción 1 incorrecta), es preciso hacer una biopsia (opción 4 incorrecta), que no tiene riesgo aumentado de diseminación local en caso de condrosarcoma (opción 3 incorrecta) pero sí en otros tumores, por lo que debe realizarse siempre en el mismo centro que posteriormente vaya a hacer la cirugía por si hay que hacer una exéresis en bloque de la pared torácica.

68. **Señale qué característica de la dirección de batida del nistagmo es propia de un síndrome vestibular periférico agudo no posicional:**

1. Con fijación visual y en posición primaria de la mirada cambia o alterna la dirección de manera espontánea y periódicamente.
2. Con fijación visual cambia de dirección al mirar a uno u otro lado.
3. Con fijación visual y en posición primaria de la mirada es vertical hacia abajo puro, sin componente horizontal.
4. Tanto con fijación visual como al anularla es unidireccional.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El nistagmo es el movimiento involuntario del ojo que puede aparecer tanto en patologías vestibulares periféricas como centrales. Un nistagmo cuyo origen es un déficit vestibular periférico siempre será unidireccional y horizontal. Este nistagmo se verá claramente disminuido al fijar la vista o lo que es lo mismo, aumentará con la inhibición de la fijación visual, pero nunca cambiará de dirección.

69. **Juan, residente de segundo año, atiende en urgencias a Sofía, una muchacha de 15 años que, al parecer, se ha desmayado en la escuela sin llegar a perder la conciencia. La paciente cuenta que estaba pendiente de realizar un examen, lo que le causaba mucha ansiedad. Por el interrogatorio, parece entreverse una situación de cierto acoso por parte de sus compañeros y la posibilidad de que sufra un trastorno alimentario. Las constantes vitales y exploración neurológica son normales. Juan mantiene a Sofía en observación a la espera de que sus padres acudan al servicio echando, periódicamente, una ojeada a cómo se encuentra la paciente. Tras el susto inicial, la paciente parece encontrarse cada vez más animada y es muy simpática. En una ocasión, Juan la encuentra chateando activamente con su móvil. Juan le indica que sería mejor que dejase el móvil y descansase y para tranquilizarla, le cuenta que él también utiliza mucho las redes sociales desde la facultad. Sofía pide perdón por desconocer que tenía que tener el móvil apagado, y tras apagarlo, le pregunta si podrá hacerle una solicitud de amistad en Facebook. ¿Cuál cree que es la mejor respuesta de Juan?:**

1. Decirle que haga la solicitud de amistad y que la aceptará, pues está seguro de que en su página no hay elementos inapropiados para una chica de la edad de Sofía.
2. Dado que considera a Sofía una paciente vulnerable y le preocupa que pueda interpretar mal un rechazo, aceptar que haga la solicitud pero solamente permitirle el acceso a determinados contenidos de su página.
3. Contestarle que es importante mantener unos ciertos límites profesionales entre pacientes

y facultativos y que, desafortunadamente, si hace la petición, no podrá aceptarla, por lo que mejor que no la haga.

4. Decirle que haga la petición pero sin intención de aceptarla.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Esta pregunta se responde con sentido común; aunque debamos mantener una relación empática con los pacientes tenemos que poner límites en nuestra relación con ellos y agregar a un paciente a cualquier red social, por muy bien que nos caiga, es pasar esos límites.

70. Respecto a la sedación terminal, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Está indicada en pacientes que se encuentran cerca de su fallecimiento.
2. Debe emplearse para aliviar síntomas refractarios a los tratamientos convencionales.
3. No está indicada cuando lo solicita el paciente en situación terminal aduciendo motivos existenciales.
4. Debe emplearse aún si se sospecha que va a ser la responsable de acortar la vida del paciente.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La sedación paliativa está indicada en pacientes que se encuentran cerca de su fallecimiento para aliviar uno o más síntomas refractarios. Para iniciarla siempre se requiere el consentimiento explícito, implícito o delegado por parte del paciente. Lo puede pedir el enfermo, aduciendo incluso motivos existenciales y no se considerará eutanasia aunque pueda acortarle la vida.

71. Una paciente de 65 años debutó dos años antes con una apraxia del habla y evolutivamente ha desarrollado un parkinsonismo rígido-acinético de predominio en hemicuerpo derecho con mioclonías sobreimpuestas y fenómeno de mano alienígena o miembro extraño. ¿Qué diagnóstico considera más probable?:

1. Enfermedad de Parkinson.
2. Degeneración corticobasal.
3. Enfermedad de Alzheimer.
4. Enfermedad de Huntington.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La degeneración corticobasal es un trastorno neurodegenerativo caracterizado por un parkinsonismo asimétrico y afectación cortical (apraxia, fenómeno del miembro alien.). La enfermedad de Parkinson no cursa con deterioro cognitivo inicialmente, del mismo modo que no hay síntomas motores al comienzo de la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Huntington son típicos los movimientos coreicos con trastorno del ánimo y de la

conducta.

72. Un paciente acude a urgencias por presentar una eritrodermia con fiebre y malestar general. En la exploración se aprecia en las uñas la presencia de piqueteado ungueal y unas zonas amarillentas distales en mancha de aceite. ¿Cuál es la enfermedad primaria que ha originado el cuadro?:

1. Linfoma cutáneo.
2. Dermatitis atópica.
3. Psoriasis.
4. Ictiosis.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Todas las opciones podrían presentarse clínicamente como una eritrodermia, y si no nos dieran más datos no podríamos contestar la pregunta. Sin embargo, las alteraciones ungueales, con el piqueteado ungueal y la “mancha de aceite” hacen que nos decantemos por psoriasis como la enfermedad primaria que presenta el paciente.

73. ¿Cuál es la causa más frecuente de síndrome vertiginoso?:

1. Enfermedad de Ménière.
2. Neurinoma del acústico.
3. Vértigo posicional paroxístico.
4. Neuronitis vestibular viral.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El VPPB es el vértigo periférico más frecuente, seguido de la neuritis vestibular de la enfermedad de Meniere.

74. Un hombre con miopía magna, de 47 años, intervenido de cataratas hace 2 años, acude urgencias refiriendo una pérdida profunda e indolora de visión en su ojo derecho. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos puede provocar esta sintomatología?:

1. Endoftalmitis postquirúrgica.
2. Desprendimiento de retina.
3. Degeneración macular asociada a la edad, forma húmeda.
4. Desprendimiento posterior de vítreo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad media-baja. Aunque en la pregunta no se mencionan los síntomas característicos del desprendimiento de retina regmatógeno (miodesopsias, fotopsias y visión de telón), la pérdida profunda e indolora de visión nos indica que estamos ante un desprendimiento de retina. Los factores de riesgo que aparecen en la pregunta son la miopía magna y el estar intervenido de catarata. Recuerda que también son

la edad avanzada y los traumatismos oculares. Uno puede pensar en un primer momento que estamos ante un caso de endoftalmitis porque nos indican que está operado de catarata, pero recuerda han pasado 2 años desde la cirugía (por lo que la probabilidad es muy baja) y las endoftalmitis producen ojo rojo DOLOROSO. Si el paciente tuviese una membrana neovascular coroidea asociada a la miopía (que es similar a la degeneración macular asociada a la edad pero en pacientes más jóvenes y miopes magños), en la pregunta nos hablarían de metamorfopsias y escotoma central.

75. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones es MENOS probable en la nefritis túbulo-intersticial?:

1. Proteinuria superior a 3,5 g en 24 horas.
2. Diabetes insípida nefrógena.
3. Insuficiencia renal progresiva.
4. Acidosis tubular renal.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Debido al ataque crónico leucocitario sobre el túbulo y el intersticio renal en las nefropatías tubulointersticiales, se produce una incapacidad de la nefrona para llevar su normal de filtrado y reabsorción de solutos. Por tanto, es característica la aparición de: - Síndrome pierde sal (por incapacidad de reabsorber sodio) e isostenuria (orinas de baja densidad por incapacidad para concentrar la orina al perder el mecanismo multiplicador de contracorriente). Asimismo puede existir una insensibilidad distal a la acción de la ADH, apareciendo diabetes insípida nefrogénica (respuesta 2 verdadera) - Acidosis metabólica con anion gap normal y orinas alcalinas, debido a la incapacidad para reabsorber bicarbonato (respuesta 4 verdadera). Acidosis tubular tipo IV por hipoaldosteronismo-hiporreninémico. - Datos de afectación tubulointersticial: leucocituria o piuria, proteinuria de bajo peso molecular (de diferente composición a la de origen glomerular, siendo habitualmente < 3.5 g/24h) (respuesta 1 falsa, y por tanto CORRECTA) - Aparición de insuficiencia renal progresiva por fibrosis intersticial y atrofia tubular (respuesta 3 verdadera).

76. Señale cuál de la siguientes es una característica de la ataxia cerebelosa:

1. Defecto de la sensibilidad propioceptiva.
2. Dismetría.
3. El desequilibrio empeora cuando el enfermo cierra los ojos (signo de Romberg +).
4. Rigidez.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La dismetría es ipsilateral al lado de la lesión cerebelosa. Otras características de este síndrome son disartria, hipotonía, nistagmo multidireccional, y disidiadocinesia.

77. Mariano es un señor de 53 años de edad que acude

a su consulta refiriendo sentir un gran malestar desde hace ya unos años. Relaciona el malestar con una conducta que encuentra absurda pero que es incapaz de evitar. Esta conducta que lleva a cabo siempre al llegar a su casa de vuelta del trabajo consiste en accionar el pomo del baño del piso superior de la vivienda antes de hacer cualquier otra cosa, incluso antes de saludar a su familia. Algunas veces ha intentado resistirse a hacerlo pero solo ha conseguido angustiarse y demorar la conducta unos minutos. Este comportamiento que Mariano realiza de un modo incoercible y automático es lo que se denomina:

1. Trastorno obsesivo-compulsivo.
2. Obsesión.
3. Impulsión.
4. Compulsión.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de enunciado ambiguo. Nos preguntan cómo se llama el "comportamiento" que tiene Mariano. Mariano presenta un trastorno obsesivo-compulsivo (opción 1), dado que tiene de forma crónica una obsesión que le lleva compulsivamente a realizar una determinada acción, con afectación afectiva. Pero el "comportamiento" que realiza (accionar el pomo de la puerta del baño), dentro de su cuadro clínico, recibe el nombre de compulsión (opción 4 correcta). En esta pregunta se debe tener precaución con el lenguaje que emplea el autor de la pregunta al formularla para no marcar la opción 1: no nos preguntan por el trastorno que tiene Mariano, sino por el nombre del comportamiento que realiza. Una compulsión es un acto motor o mental, voluntario y estereotipado, que el sujeto vive como absurdo pero no puede evitar por la angustia que supone su evitación.

78. ¿Cuál de las siguientes características NO es típica de la personalidad obsesiva?:

1. Generosidad.
2. Perfeccionismo.
3. Rigidez.
4. Escrupulosidad.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Respuesta correcta 1. Pregunta acerca de un trastorno de la personalidad no preguntado habitualmente en el MIR pero de baja dificultad, el trastorno obsesivo o anacástico de la personalidad; sus características son perfeccionismo, meticulosidad, rigidez e inflexibilidad, terquedad y avaricia. Recordad que lo importante es formarse una imagen general del tipo de personalidad, sobre todo de aquellos poco preguntados.

79. **Hombre de 35 años de edad sufre una quemadura eléctrica de alto voltaje (3000 voltios) por contacto directo con cable con su mano izquierda. Al ingreso presenta contractura en flexión de la mano, palidez de los dedos y ausencia de pulso radial y cubital a la palpación. ¿Cuál es la medida invasiva de urgencia a realizar?:**

1. Bloqueo axilar con catéter.
2. Escarotomía descompresiva.
3. Monitorización de presión intracompartimental.
4. Escarectomía.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de una quemadura eléctrica, algo poco frecuente y nos cuentan un síndrome de compresión nerviosa. Sin embargo, lo único que hay que recordar en este caso es que ante una escara que produce compresión, el tratamiento debe ser la escarotomía para descompresión de la zona.

80. **¿Cuál de los siguientes sistemas de prescripción terapéutica le parece el más adecuado para evitar errores en el tratamiento del paciente hospitalizado?:**

1. Informar directamente a la enfermera de más confianza.
2. Escribir de puño y letra todos los pormenores del tratamiento.
3. Dictar el tratamiento a la secretaria para que lo pase a la enfermera.
4. Cumplimentar el registro de prescripción electrónica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Siempre que se disponga de prescripción electrónica se debe utilizar, es mucha más segura en cuanto a errores de prescripción que la manual; detecta errores de dosis, alergias medicamentosas, duplicidad de fármacos, etc.

81. **La utilización de la técnica estadística de la regresión múltiple permite:**

1. Determinar los valores mínimos de la variable dependiente.
2. Establecer qué variables independientes influyen en la variable dependiente.
3. Determinar la importancia de la variable dependiente en la población.
4. Establecer la relación simultánea entre un gran número de variables predictoras.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La respuesta nos da la definición perfecta de regresión: establecer qué variables INDEPENDIENTES influyen en

nuestra variable DEPENDIENTE. Recordad además que los modelos de regresión nos permitirán establecer CUÁNTO influyen dichas variables independientes. Quizá os ha hecho dudar la número 4, pero acordaros que el sentido de la regresión no es estudiar la relación entre las variables predictoras o independientes, sino estudiar su relación con la variable resultado o dependiente.

82. **Mujer de 68 años, con antecedentes de 2 episodios depresivos mayores a lo largo de su vida, que consulta por síntomas de tristeza, decaimiento, anhedonia, astenia y anorexia compatibles con un nuevo episodio depresivo. Se pautan 10 mg de escitalopram y se evalúa 2 semanas después. En esta revisión la paciente refiere estar muy bien, se despierta temprano muy hiperactiva y con muchas ganas de hacer cosas, dice tener mucha energía y está más habladora de lo que en ella es habitual. No refiere estar irritable y es capaz de dormir 6 horas continuamente. Ante esta situación, ¿qué pensaría que tiene la paciente?:**

1. Trastorno bipolar tipo I.
2. Hipomanía inducida por fármacos.
3. Respuesta normal al escitalopram.
4. Demencia frontal.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta de tipo caso clínico del tema más importante de la asignatura (por ser el que mayor número de preguntas acumula en los últimos 10 años), trastornos del estado de ánimo. Respuesta correcta la 2, ya que nos presentan un caso de una mujer con trastorno depresivo mayor recurrente, en quien tras un nuevo episodio depresivo, se pauta escitalopram (antidepresivo ISRS, primera elección) y presenta posteriormente clínica del otro polo afectivo sugerente de hipomanía (sin conocer concretamente el tiempo de evolución de los síntomas). Descartamos la respuesta 1 (trastorno bipolar tipo I) porque no se trata de un cuadro maníaco (clínica psicótica congruente, duración de más de una semana o gravedad que requiera hospitalización); tampoco es el cuadro típico de una demencia frontal (respuesta 4), principalmente por la presentación aguda y la ausencia de signos de deterioro cognitivo; y respecto a la respuesta 3 (respuesta normal al escitalopram), la clave está en que se refiere que existe un cambio respecto a cómo es la paciente habitualmente ("está más habladora de lo habitual").

83. **Señalar cuáles de los siguientes síntomas de la esquizofrenia constituye un factor de mal pronóstico:**

1. Pródromo breve.
2. Ausencia de síntomas depresivos.
3. Inicio de 25 a 30 años.
4. Ausencia de síntomas obsesivos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta que trata un tema recurrente en el MIR, los factores pronósticos de la esquizofrenia. (OJO: no debe confundirse con las preguntas de factores de riesgo de suicidio en la esquizofrenia). La respuesta correcta es la 2, ya que los síntomas afectivos presentes o antecedentes son un factor de buen pronóstico, por lo que su ausencia constituye mal pronóstico.

84. Un hombre de 80 años es llevado a urgencias por la policía al encontrarle por la noche, en la calle, a varios bloques de su domicilio, algo perdido. Dice al médico de urgencias “me encuentro bien, estaba paseando y me he perdido”. La revisión por sistemas, es anodina. Al preguntarle por medicaciones, no recuerda. En su historial constan glipizida, atenolol y acenocumarol. Ha estado 3 veces en urgencias en los últimos 3 meses por “mareo”, dolor lumbar y un INR de 5,0. Refiere independencia en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. No hay evidencia de familiares o amigos cercanos. Varias referencias del trabajo social del área indican que rechaza ayudas o visitas médicas o de enfermería. En la exploración física, únicamente destaca temperatura de 37,7°C, IMC de 16 Kg/m², PA 160/90 mmHg, frecuencia cardíaca 90 lpm y saturación de oxígeno de 99%. Tiene pérdida global de masa muscular. Está vestido con la bata de casa y huele a orina. Rechaza contestar a las preguntas del Mini-Mental. En las pruebas de laboratorio destacan leucocitos 13.000/microL, glucemia 300 mg/dL, hemoglobina A1c 11%, INR 0,9. Orina: más de 50 leucocitos/ campo y nitritos +. Urocultivo: >100.000 colonias de bacilos gram-negativos. Es ingresado en el hospital, recibe antibióticos, insulina y se reinicia acenocumarol con buena evolución. Está estable y quiere irse a su domicilio. La enfermera de planta refiere que es incapaz de autoadministrarse la insulina. ¿Cuál de los siguientes es el próximo paso para determinar la seguridad del paciente en su domicilio?:

1. Referir a Atención Primaria y trabajo social del área para determinar la seguridad en el domicilio.
2. Evaluación formal de la capacidad para tomar decisiones concernientes a su salud.
3. Evaluación para descartar demencia.
4. Evaluación para descartar depresión.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Ante un paciente anciano frágil tenemos que hacer una valoración geriátrica global donde se evalúen todas las esferas (funcional, mental, social y biomédica). En este caso, nos tenemos que fijar especialmente en valorar su deterioro

cognitivo y sobre todo su capacidad de decisión sobre su propia salud ya que en los últimos meses ha precisado de atención sanitaria en varias ocasiones probablemente por falta de autocuidado. El paciente necesita medicación que requiere de cierta capacidad cognitiva para tomarlo correctamente sin errores (acenocumarol y probablemente insulina), así que antes de darle de alta tenemos que determinar cuál será el destino más adecuado para la seguridad del paciente.

85. Entre las características de la comunicación con la familia, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Escuchar activamente.
2. Evitar utilizar el lenguaje técnico.
3. Reprimir la expresión de sentimientos.
4. Graduar la información negativa.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Todas son correctas y se deben de llevar a cabo en una entrevista con la familia del paciente excepto la 4: no está prohibido que el profesional sanitario se muestre afectado o empático con la situación. Se tiene que conseguir el nivel de empatía con el objetivo de que la familia se sienta más comprendida.

86. Paciente de 34 años que jugando a tenis recibe el impacto de la bola a nivel de la órbita izquierda. A la exploración presenta importante hematoma palpebral, hiposfagma, diplopia a la visión superior con limitación de la versión superior del globo ocular. ¿Qué sospecharía?:

1. Fractura de la pared inferior del suelo de la órbita con atrapamiento del músculo recto inferior.
2. Fractura del arco cigomático.
3. Fractura de la pared superior de la órbita con atrapamiento del músculo recto superior.
4. Fractura dentoalveolar.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad media. El enunciado es el típico caso de fractura orbitaria por traumatismo contuso, denominada en estallido o blow-out. Son debidas a un golpe con un objeto pequeño (puño o pelota de tenis) que empuja al globo ocular hacia dentro, aumentando la presión orbitaria y fracturando las paredes más débiles, normalmente el suelo orbitario (acompañado o no de la pared medial). Se acompaña de hematoma palpebral (que suele ser unilateral), hipostesia infraorbitaria, enoftalmos y diplopía (por atrapamiento del recto inferior y/o oblicuo inferior). Si uno no recuerda las fracturas blow-out, puede responder a la pregunta descartando opciones según la clínica. El paciente tiene una diplopía vertical, así que lo primero que se debe pensar es en la afectación de los músculos que actúan en el eje vertical.

De las opciones, sólo dos nos hablan del atrapamiento de dos músculos. Por lo que podemos descartar el resto. Cuando se atrapa el músculo recto superior, el paciente no podrá mirar hacia inferior, por lo que es en la infraversión cuando verá doble. Mientras, que si se atrapa el músculo recto inferior, el paciente tendrá diplopía a la supravversión, como nos dicen en el enunciado.

87. ¿Cuál de las siguientes vacunas está contraindicada en pacientes inmunodeprimidos?:

1. Varicela.
2. Hepatitis B.
3. Gripe.
4. Neumocócica (polisacáridos).

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La vacuna de la varicela se compone de virus vivos atenuados, por lo que está contraindicada en el paciente inmunodeprimido. Pregunta muy sencilla al ser un concepto muy repetido en la historia del MIR.

88. Un hombre de 88 años viene a consulta porque se ha caído 3 veces en los últimos 6 meses. Ninguna de las caídas se acompañaba de “mareo” o síncope. Una caída ocurrió mientras caminaba por el jardín, en las otras tropezaba dentro de la casa. Sus antecedentes médicos incluyen hipertensión arterial sin cambios posturales en la presión arterial, gota, artrosis y depresión. Toma 5 medicinas regularmente. ¿Cuál de las siguientes es la que más probablemente contribuya a las caídas en este paciente?:

1. Alopurinol.
2. Hidroclorotiazida.
3. Lisinopril.
4. Paroxetina.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La paroxetina, antidepresivo ISRS, tiene una ligera actividad anticolinérgica, produciendo sequedad de boca, estreñimiento, sedación y visión borrosa, aumentando así el riesgo de caída en pacientes vulnerables (ancianos, en quienes son más frecuentes estos efectos). De cara al MIR, debéis de saber que el efecto anticolinérgico de cualquier medicación es muy mal tolerado por el paciente anciano y debe de evitarse siempre que se pueda.

89. Una embarazada de 10 semanas de gestación, acude a urgencias hospitalarias por presentar una presión arterial de 160/105 mmHg. Buen estado general, solo leve cefalea, motivo por el que se tomó la presión arterial. Tras 4 horas de 26 reposo presenta cifras de 150/95 mmHg. Se le realiza un hemograma que es normal y una proteinuria que es negativa. ¿Qué tipo de

hipertensión presenta?:

1. Preeclampsia moderada.
2. Hipertensión inducida por el embarazo.
3. Hipertensión crónica.
4. Eclampsia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Una gestante con tensión arterial sistólica mayor o igual a 140 mmHg y/o diastólica mayor o igual a 90 mmHg que aparece antes de la semana 20 de gestación (sin ser un gemelar, hídrops o mola) es una hipertensión crónica -respuesta 3 correcta-. La hipertensión gestacional es aquella que aparece a partir de la semana 20 de gestación; la preeclampsia también aparece a partir de la semana 20 de gestación y, además de presentar hipertensión, se acompaña de proteinuria mayor o igual a 300 mg en orina de 24 horas. Cuando una preeclampsia se asocia a convulsiones, entonces es una eclampsia.

90. ¿Cuál es el germen que se aísla con frecuencia en las secreciones y costras de las rinitis atróficas?:

1. Actinomyces israelii.
2. Klebsiella ozaenae.
3. Moraxella catharralis.
4. Streptococo pneumoniae.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de una pregunta directa sobre el germen aislado en las rinitis crónica atrófica. Cuando las costras que se forman en este tipo de rinitis crónica tienen mal olor (cacosmia) el nombre que adquiere es el de ocrea y el germen más comúnmente aislado es Klebsiella.

91. Respecto a la toma de decisiones al final de la vida señale la respuesta INCORRECTA:

1. La negativa a intervenciones para conservar la vida del paciente puede considerarse suicidio o incluso asesinato.
2. La administración de antibióticos o la infusión de suero debe evitarse en estas situaciones.
3. Deben suspenderse aquellas actividades que se demuestren que no son útiles para el paciente.
4. Los médicos son los responsables de firmar la orden de no reanimación explicando los motivos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En esta pregunta se habla del concepto de limitación del esfuerzo terapéutico, también conocido como LET. Se trata de la no iniciación (RCP) o la retirada de medidas terapéuticas (antibióticos, suero, pruebas complementarias invasivas) porque el profesional sanitario considera que en esa situación en concreto son fútiles y sólo consiguen alargar

la vida del paciente sin proporcionarle mejora en la calidad de vida. La LET es un acto de buena praxis médica y no se considera suicidio ni asesinato (respuesta 1 FALSA). El concepto es diferente del de suicidio médicamente asistido: actuación de un profesional sanitario mediante la que proporciona, a petición expresa de su paciente capaz, los medios intelectuales o materiales imprescindibles para que pueda terminar con su vida suicidándose de forma efectiva cuando lo desee.

92. ¿Cuál de los siguientes NO se considera factor de riesgo de carcinoma de la vesícula biliar?:

1. Litiasis biliar.
2. Alcoholismo crónico.
3. Vesícula en porcelana.
4. Pólipo vesicular de 15 mm.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta poco esperada en el MIR ya que se trata de un tumor poco frecuente (aunque con alto potencial de malignidad). Podría ser una pregunta impugnada. Los principales factores de riesgo típicos relacionados con el desarrollo de carcinoma de vesícula biliar (CVB) que debemos recordar son: la presencia de colelitiasis (litiasis > 1 cm) que es el factor más importante; colangiocarcinoma; vesícula de porcelana (en algunas fuentes aún sigue constando que es controvertido); antecedente familiar de primer grado de cáncer de vesícula; síndrome de Lynch; enfermedad inflamatoria intestinal; colangitis esclerosante primaria; anomalías congénitas de los conductos biliares; displasia de la vía biliar intrahepática; adenomiomatosis segmentaria en pacientes > 60 años y portador crónico de Salmonella Typhi o Paratyphi. No obstante, en un metaanálisis reciente consta los pacientes con consumo enólico severo tiene aumentado el riesgo de cáncer de vesícula. Por ello y porque la vesícula de porcelana sigue siendo un factor de riesgo controvertido debería ser anulada.

93. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones sobre el tratamiento coadyuvante tras la cirugía del cáncer de mama es correcta?:

1. El uso de tamoxifeno depende del estado ganglionar.
2. El tamoxifeno se debe de iniciar a la vez que la quimioterapia.
3. El inhibidor de aromatasa es efectivo con función ovárica activa.
4. La monoterapia con tamoxifeno es útil en pre y postmenopáusicas.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El uso de tamoxifeno forma parte de la hormonoterapia en el cáncer de mama, por lo que no depende del estado ganglionar, sino de la presencia de receptores hormonales en el tumor

(respuesta 1 falsa). Su inicio no tiene porqué ser simultáneo a la quimioterapia, pudiendo darse antes, durante o después de la misma (lo más habitual es que sea después) -respuesta 2 falsa-. La hormonoterapia de elección en premenopáusicas es el tamoxifeno y en postmenopáusicas los inhibidores de la aromatasa; sin embargo una opción válida sería dar tamoxifeno en postmenopáusicas, puesto que es útil tanto en pre- como en postmenopáusicas (respuesta 4 correcta), mientras que para poder utilizar inhibidores de la aromatasa en premenopáusicas lo deberíamos asociar a inhibición de la función ovárica (bien quirúrgica quitando los ovarios o bien dando análogos de GnRH), puesto que el inhibidor de la aromatasa con función ovárica activa no es útil -respuesta 3 incorrecta-.

94. ¿Cuál es el pilar fundamental en el tratamiento del cáncer de ovario?:

1. La cirugía diagnóstica y citorreductora reglada.
2. Quimioterapia sistémica.
3. Radioterapia.
4. Administración de terapia biológica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El pilar de tratamiento en el cáncer de ovario es la cirugía (respuesta 1 correcta), ya que el factor pronóstico más importante del cáncer de ovario es el tejido tumoral residual que se deja tras la misma. De esta forma, en una paciente en la que se consiga cirugía óptima mejorará radicalmente el pronóstico de su enfermedad. El tratamiento adyuvante por excelencia del cáncer de ovario es la quimioterapia, que va a ser necesaria en la mayoría de las pacientes; sin embargo, su efectividad estará condicionada por la cirugía que se haya realizado. La radioterapia es muy poco útil en el tratamiento del cáncer de ovario, salvo en el disgerminoma. La terapia biológica se administra bien de manera coadyuvante a la quimioterapia estándar cuando no se consigue adecuada respuesta a la misma, bien como tratamiento de mantenimiento tras la quimioterapia en los casos en los que sí se ha respondido.

95. La determinación en una mujer de 70 años de hematocrito 32 %, Hb 9,6 g/dL, VCM 85 fL (70-99), hierro 25 microg/dL (37-145) y ferritina 350 ng/mL (15-150), es más sugestivo de:

1. Pérdida de sangre reciente por aparato digestivo.
2. Malabsorción intestinal.
3. Polimialgia reumática.
4. Polimialgia reumática. Talasemia menor.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Caso clínico de anemia de trastorno crónico. Mujer de 70 años (postmenopáusica) con anemia (Hb <12), normocítica (VCM entre 80-100) con hierro sérico bajo (<50) y ferritina elevada (>200). Este tipo de anemia se asocia a enfermedades

inflamatorias o infecciosas de carácter crónico como por ejemplo la polimialgia reumática (opción 3 verdadera). En cualquier caso, esta pregunta se puede contestar por descarte. La anemia ferropénica secundaria a la pérdida de sangre y la talasemia menor son anemias microcíticas (VCM <80). Además en las anemias ferropénicas los depósitos de hierro están bajos (ferritina <20). Las anemias secundarias a malabsorción intestinal forman parte del grupo de anemias carenciales, es decir, por malabsorción de hierro (anemia microcítica) o de vitamina B12/ácido fólico (anemias macrocíticas).

96. La tricoleucemia (leucemia de células peludas) presenta como rasgos característicos clínicobiológicos:

1. Linfocitosis en sangre periférica superior a 50.000 linfocitos /microL.
2. Marcadores de línea linfocítica T.
3. Eritrodermia generalizada exfoliativa, placas y tumores cutáneos.
4. Pancitopenia y esplenomegalia.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La tricoleucemia es una neoplasia hematológica de estirpe B (opción 2 falsa). El cuadro clínico típico se caracteriza por la presencia de pancitopenia (opción 1 falsa) y esplenomegalia (opción 4 verdadera). A diferencia de otros síndromes linfoproliferativos las adenopatías con escasas. Habitualmente se asocian a trastornos inmunológicos como vasculitis (siendo típica la panarteritis nodosa) y las infecciones (neumonías por Legionella) (opción 3 falsa). El aspirado de médula ósea suele ser seco por lo que hay que realizar una biopsia para el diagnóstico. El tratamiento de primera elección es la cladribina (análogo de las purinas).

97. ¿Cuál de las siguientes variables es la mejor para guiar la resucitación e indica la resolución del shock en un politraumatizado?:

1. Normalización de lactato.
2. Normalización de la presión arterial.
3. Normalización de la frecuencia cardíaca.
4. Normalización de la diuresis.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta difícil por aparecer un concepto que no se había preguntado antes. El lactato es un producto del metabolismo anaerobio, y se puede utilizar como marcador de disponibilidad de oxígeno por los tejidos periféricos en pacientes críticos. Tradicionalmente se ha considerado la normalización de la presión sistólica, la frecuencia cardíaca y la diuresis como marcadores de éxito en la resucitación. Sin embargo, se ha visto que hay una alta incidencia de shock "compensado", con estos marcadores normales pero con alteraciones en la oxigenación de órganos periféricos. El mejor indicador de completa resolución de esta situación

es la normalización de los niveles de lactato sérico, además del déficit de bases y el pH gástrico.

98. En una paciente con artritis reumatoide en tratamiento con metotrexate, prednisona e indometacina que presenta de forma aguda edemas y aumento de la creatinina plasmática con un sedimento de orina poco expresivo y proteinuria inferior a 100 mg/24h la causa más probable es:

1. Amiloidosis renal.
2. Glomerulonefritis secundaria a la artritis reumatoide.
3. Insuficiencia renal por antiinflamatorios no esteroideos.
4. Nefritis intersticial por metotrexate.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pese al antecedente de artritis reumatoide, no debemos confundirnos: nos presentan un paciente con clínica de fracaso renal agudo, con sedimento urinario inactivo y con proteinuria fisiológica (< 100 mg/día se considera normal). Por ello, lo más probable es que sea secundaria a la toma de AINES (respuesta 3 CORRECTA). Del resto de opciones: - La amiloidosis renal cursa con proteinuria en rango nefrótico (> 3.5 g/1.72m²/24h) (respuesta 1 falsa). - La GN secundaria a AR daría datos de síndrome nefrítico con HTA, proteinuria y hematuria, teniendo nuestro enfermo un sedimento inactivo (respuesta 2 falsa). - La nefritis intersticial por metotrexate daría síndrome tubular con FRA, proteinuria de origen tubular, leucocituria con cilindros leucocitarios y ocasionalmente hematuria (respuesta 4 falsa).

99. Paciente con diagnóstico de VIH sin antecedentes neurológicos previos que es derivado al servicio de Urgencias por episodio de crisis convulsiva. ¿Cuál es la etiología MENOS probable?:

1. Leucoencefalopatía multifocal progresiva.
2. Meningitis criptocócica.
3. Encefalopatía VIH.
4. Linfoma primario del SNC.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta difícil ya que la etiología de las crisis comiciales en el paciente VIH varía según las series consultadas. En las series clásicas las causas más frecuentes de crisis comicial de debut en el paciente VIH son la toxoplasmosis y la encefalopatía VIH, siendo la más infrecuente de todas la LEMP (opción 1).

100. La diabetes mellitus tipo 1 del niño se caracteriza por todo lo siguiente EXCEPTO:

1. La alteración poligénica y los factores ambientales conducen a la destrucción

- autoinmune de los islotes del páncreas.
- 2. Precisa administración diaria de insulina exógena.
- 3. Los pacientes tienen requerimientos nutricionales diferentes a los de la población general.
- 4. Las complicaciones a largo plazo se relacionan con la hiperglucemia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La DM tipo 1 ocurre por la destrucción de las células β en los islotes pancreáticos, generalmente por un mecanismo autoinmune, sobre un sustrato genético. Existe un déficit de insulina desde el diagnóstico, por lo que precisa de la administración de insulina desde el inicio. El mal control glucémico produce complicaciones micro y macrovasculares a largo plazo. Aunque la dieta es un pilar fundamental en el tratamiento, las recomendaciones nutricionales no son diferentes a la de la población general (opción 3 correcta).

101. Dentro de la epidemiología y factores de riesgo en el carcinoma de pene. ¿Cuál es la respuesta FALSA?:

- 1. El 95% de los casos de tumores malignos de pene son carcinomas escamosos.
- 2. Las parejas femeninas de pacientes varones con cáncer de pene no tienen una incidencia mayor de cáncer de cérvix.
- 3. La afectación por el virus del papiloma humano (HPV) en sus subtipos 16 y 18, incrementa el riesgo de cáncer de pene.
- 4. La vacunación para el HPV de los niños varones es una recomendación en el actual calendario.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta real de MIR. La vacuna frente al Virus del papiloma humano no está incluida en el calendario vacunal actual para varones, aunque cada vez se recomienda más por las diferentes sociedades científicas por su posible acción para prevenir distintos subtipos de lesiones genitales y anales. Opción 4 falsa, siendo el resto de afirmaciones correctas, aunque la opción 2 suscitó numerosas dudas en su momento.

102. Lactante de 5 meses de edad alimentado con lactancia materna exclusiva hasta la actualidad que por motivo de trabajo materno se le introduce biberón con fórmula de inicio y hace unos días se le adiciona con cereales con y sin gluten. Como antecedentes familiares destaca madre de 28 años asmática, padre de 32 años sano y hermano de 5 años afecto de enfermedad celíaca y dermatitis atópica. Como antecedentes personales, embarazo sin incidencias y parto mediante cesárea habiéndosele ofrecido biberón con fórmula de inicio el primer día de vida en la maternidad. Desde hace unos días comienza con distensión abdominal, deposiciones diarreicas, rechazo a las tomas, eritema peribucal con

duración más prolongada en el tiempo tras la ingesta del biberón y últimamente vómitos tras su ingesta, tolerando bien el pecho materno. ¿Cuál es su diagnóstico más probable?:

- 1. Enfermedad celíaca.
- 2. Gastroenteritis aguda.
- 3. Alergia a las proteínas de la leche de vaca.
- 4. Alergia a los biberones.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata del caso clínico de un lactante alimentado con lactancia materna exclusiva hasta la actualidad. Se ofrecen además datos de atopia familiar y enfermedad celíaca, pero por “despistar”. En el momento de la incorporación de la fórmula de inicio(aunque fijos en el contacto inicial el primer día de vida), el lactante desarrolla un cuadro típico de intolerancia digestiva inespecífica, con distensión abdominal y alteración del ritmo intestinal, siendo compatible con cuadro de alergia a proteínas de leche de vaca(APLV). Su tratamiento pasa por realizar una dieta exenta de proteínas de leche de vaca. Se puede volver a intentar la reintroducción de las proteínas de leche de vaca pasados unos meses.

103. Las reclamaciones de los pacientes o de sus familiares que se reciben en las Unidades de Atención al Usuario son un indicador de calidad, pero ¿qué componente de la calidad miden?:

- 1. La calidad de la atención de la Unidad de Atención al Usuario.
- 2. La calidad extrínseca o percibida.
- 3. La calidad del tratamiento de los pacientes en términos de adherencia a las guías de Buena Práctica Clínica.
- 4. La calidad intrínseca o científico-técnica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Existen dos tipos de calidad: - Calidad intrínseca o científico-técnica: se refiere a la capacidad de resolver el problema de salud mediante los conocimientos y la tecnología, es decir, la posibilidad de realizar un correcto diagnóstico y aplicar una terapéutica conveniente. Es el componente más valorado por los profesionales sanitarios y debe estar asesorada por la evidencia disponible sobre la mejor práctica, obtenida a partir de instrumentos como la medicina basada en la evidencia, la evaluación de tecnologías sanitarias y guías de práctica clínica. - Calidad extrínseca o percibida: corresponde a la satisfacción del usuario respecto al servicio recibido. Es el componente humano que integra el trato recibido por el enfermo y sus familiares. La calidad percibida es el componente más valorado por los pacientes, ya que es el que perciben y para el que disponen de referencias comparativas.

104. De las siguientes enfermedades evitables con vacunas, ¿cuál es la que ha sido posible erradicar en todo el mundo?:

1. La poliomielitis paralítica.
2. La difteria.
3. La viruela.
4. El sarampión.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta que casi podemos decir que es de cultura general. La viruela es la única enfermedad infecciosa que ha sido posible erradicar en el mundo. Otras infecciones candidatas a la erradicación en la actualidad son la poliomielitis, la dracunculiasis o el pian.

105. Realizamos la determinación de antígeno prostático específico (PSA) para diagnosticar carcinoma de próstata en adolescentes y en ancianos sanos, sin hiperplasia benigna de próstata:

1. La sensibilidad del PSA en los adolescentes será mayor que en los ancianos.
2. La especificidad del PSA en los adolescentes será menor que en los ancianos.
3. No cambiará la validez interna del PSA en adolescentes o ancianos sanos.
4. El valor predictivo positivo del PSA en los adolescentes será mayor que en los ancianos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En el fondo esta pregunta presenta de manera algo más compleja un concepto preguntado hasta la saciedad: la validez interna de un test NO depende de la prevalencia de la enfermedad en la población (al final, comparar ancianos y adolescentes se traduce en prevalencias distintas de la enfermedad prostática). Por tanto sensibilidad y especificidad son constantes e iguales en ancianos y jóvenes. Lo que sí que cambian son los valores predictivos. En este caso, en adolescentes, con una menor prevalencia, su VPP será menor (podéis llevar el razonamiento al extremo: si la prevalencia en adolescentes es del 0%, el VPP será del 0%; en ancianos, con un 100% de prevalencia, un sujeto que diera positivo en el test tendría una probabilidad de ser enfermo -VPP- del 100%).

106. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con la infección por el virus del papiloma humano?:

1. Sólo el 20% de las mujeres sexualmente activas se infectará por este virus.
2. La mayoría de las mujeres infectadas desarrollarán displasia cervical o cáncer.
3. No se ha demostrado que otros cofactores como el tabaco o una respuesta inmunitaria alterada estén relacionados con el desarrollo de displasia.
4. El virus es transitorio en la mayoría de las mujeres.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En mujeres sexualmente activas se han objetivado tasas de prevalencia de HPV de hasta el 30% (respuesta 1 falsa); sin embargo, la mayoría de esas pacientes no van a desarrollar displasia (respuesta 2 falsa), sino que eliminarán la infección a través de su propio sistema inmune, de tal forma que la mayoría de esas infecciones serán transitorias (respuesta 4 correcta). Esto es porque el HPV es causa necesaria pero no suficiente para producir displasia cervical. Existen ciertos cofactores que “ayudan” al HPV en su proceso carcinogénico, entre los cuales se incluyen el tabaco y la inmunosupresión (respuesta 3 falsa).

107. Mujer de 27 años remitida a consulta de ginecología para su valoración refiriendo dispareunia desde hace unos 8 meses, junto con disquecia y rectorragia ocasional coincidiendo con la menstruación desde hace 3-4 meses. También refiere dismenorrea desde hace años que controla bien con Ibuprofeno. Lleva intentando quedarse embarazada unos 16 meses sin haberlo conseguido aún. En la exploración ginecológica tan solo se aprecia dolor al presionar fondo de saco vaginal posterior. ¿Qué prueba considera usted que le permitiría llegar al diagnóstico de certeza de su patología?:

1. Ecografía transvaginal.
2. Laparoscopia diagnóstica.
3. Resonancia magnética.
4. Colonoscopia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Caso clínico típico de endometriosis: mujer con dismenorrea, dispareunia, disquecia, esterilidad, y dolor en la exploración ginecológica. Lo habitual es que con el caso clínico y la ecografía ginecológica hagamos un diagnóstico de sospecha de endometriosis. La RMN es otra prueba de imagen que puede ayudarnos con el diagnóstico. Sin embargo el diagnóstico de CERTEZA sólo lo obtendremos operando a la paciente y obteniendo muestras de esa endometriosis que se estudien en anatomía patológica. Por lo que el diagnóstico de certeza nos lo dará la cirugía (laparoscopia en este caso) -respuesta 2 correcta-.

108. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación a la vacunación y el embarazo?:

1. El embarazo de la madre es una contraindicación para administrar la vacuna contra la varicela a su hijo.
2. Las vacunas inactivadas suponen un riesgo para el feto.
3. Están recomendadas las vacunas vivas atenuadas.
4. Ante una exposición de riesgo, la embarazada puede recibir inmunoglobulinas inespecíficas.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Efectivamente, ante una exposición de riesgo, existe la posibilidad de conferir inmunidad temporal al paciente no inmunizado mediante la administración de inmunoglobulinas. Por ejemplo, en una gestante seronegativa y expuesta al virus varicela-zóster, está indicado administrar gammaglobulina inespecífica o específica dentro de las 96 horas posteriores a la exposición.

109. Una mujer de 22 años de edad acude a su consulta con un moratón en el pómul derecho y alrededor del ojo del mismo lado. La paciente evita su mirada pero le dice que es muy torpe y de nuevo se ha caído por las escaleras. Usted se plantea la posibilidad de que la paciente sufra violencia doméstica. La paciente no menciona nada en la entrevista clínica aunque refiere algunas molestias abdominales que atribuye a gases. ¿Qué debe hacer o decir a continuación?:

1. Toma nota de este hallazgo para ver si la paciente lo trae en la próxima visita o presenta otros hallazgos que sugiera malos tratos.
2. Le hace la siguiente pregunta: Usted no está siendo golpeada, ¿verdad?.
3. Le pregunta: ¿Alguna vez ha sido golpeada, abofeteada, pateada, o agredida físicamente de cualquier manera por alguien?.
4. Solicita una consulta al psiquiatra para ayudar a determinar si se es una superviviente de la violencia doméstica.

Respuesta correcta: 0**Comentario:**

Esta pregunta fue anulada. Ante un caso de sospecha de violencia doméstica se tiene que crear un clima de confianza y se debe preguntar de forma activa y respetuosa a la víctima para que se exprese con libertad. La respuesta 2 y 3 no serían formas adecuadas de aproximarse a la paciente. Siempre que se pueda se tiene que intentar formular preguntas abiertas e ir llegando al objetivo propuesto, que es saber si realmente está en alguna fase del ciclo de la violencia. Recordad habitualmente que el maltrato físico es el final de todo un proceso en el que primero hay una fase de acumulación de tensión, se produce la agresión y después habitualmente hay una reconciliación y minimización de los hechos. La respuesta 1 no es del todo falsa ya que si la paciente no reconoce el maltrato y el profesional consideró que no hay riesgo vital para la paciente si vuelve cerca del agresor, se puede dejar anotado en la historia clínica y hacer un seguimiento en posteriores visitas. En el caso de que la paciente reconozca el maltrato y pida ayuda, tenemos que notificar el parte de lesiones al juzgado de guardia y aconsejar a la paciente que contacte con el Servicio de Atención a la Mujer más cercano con el objetivo de que reciba atención psicológica, legal y si hace falta policial.

110. Chico de 18 años con dolor mamario y nódulo

retroareolar en la palpación. ¿Cuál es la causa más frecuente?:

1. Carcinoma de mama.
2. Mastitis periductal.
3. Papiloma intraductal.
4. Ginecomastia puberal.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

La causa más frecuente de nódulo retroareolar doloroso en un varón de 18 años es la ginecomastia puberal persistente – respuesta 4 correcta-. Tanto el cáncer de mama como el papiloma intraductal son excepcionales en varones jóvenes y en el caso del papiloma intraductal suele presentar secreción sanguinolenta por el pezón. La mastitis periductal es típica de mujeres con lactancia materna, siendo también una entidad rara en un varón joven.

111. Recibe usted a un paciente ingresado a su cargo en el hospital desde el Servicio de Urgencias la noche anterior. En la reunión de primera hora la enfermera le informa que está intranquilo. ¿Cuál de las siguientes actitudes debe evitar?:

1. Leer el informe de Urgencias y solicitar las pruebas urgentes que estime conveniente y que deban realizarse en ayunas.
2. Modificar el tratamiento según la impresión de la enfermera y los signos vitales disponibles en la gráfica.
3. Realizar la historia clínica, anamnesis, exploración física, registrar todo ello en el sistema de documentación clínica del hospital, dejando constancia de la impresión diagnóstica y del plan.
4. Informar al paciente y a la persona que entiende de su caso de las perspectivas del ingreso.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Es un error muy grave modificar el tratamiento sin entrevistar ni explorar al paciente solo viendo las constantes vitales y hablando con otro personal sanitario. Siempre se tiene que hacer una valoración antes de hacer cambios en el tratamiento. La respuesta 1: solicitar pruebas urgentes sin ver el paciente tampoco se debería de hacer a no ser que se tratara de una situación excepcional; aunque otro compañero haya valorado el paciente la noche anterior, antes de pedir pruebas se tiene que visitar.

112. Un hombre de 41 años acude a Urgencias por un cuadro de tres días de evolución de tumefacción y dolor en la rodilla derecha, con impotencia funcional y febrícula. Dos semanas antes había tenido un cuadro de diarrea autolimitada. En la exploración existe derrame articular, por lo que se procede a realizar una artrocentesis y se obtienen 50 cc de líquido de color turbio,

con viscosidad disminuida y los siguientes parámetros analíticos: leucocitos 40.000/microL (85% de neutrófilos), glucosa 40 mg/dL, ausencia de cristales, tinción de Gram: no se observan microorganismos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre este paciente es INCORRECTA?:

1. Se debe iniciar tratamiento con cloxacilina y ceftriaxona en espera del resultado del cultivo del líquido.
2. Es aconsejable realizar artrocentesis diarias para aliviar los síntomas y evitar la destrucción articular.
3. Si el cultivo es negativo, es probable que se trate de una artritis reactiva.
4. La negatividad de la tinción de Gram descarta que se trate de una artritis séptica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Este paciente ha tenido un cuadro de diarrea y posteriormente comenzó con una monoartritis aguda y febrícula. El líquido articular de la artrocentesis es bastante límite entre inflamatorio e infeccioso, por lo que, aunque el Gram inicial sea negativo, cubriremos empíricamente con antibióticos de amplio espectro ante la sospecha de artritis séptica, dado que el resultado negativo en esta tinción no descarta por completo el diagnóstico. Haremos artrocentesis seriadas y si el cultivo es negativo apoyaría más el diagnóstico de artritis reactiva.

113. Paciente de 57 años, diagnosticado de adenocarcinoma de colon estadio T3N1M0. Fue tratado con resección seguida de quimioterapia postoperatoria FOLFOX (fluorouracilo, leucovorín y oxaliplatino) durante seis meses. En un control rutinario, dos años después, se detecta elevación de antígeno carcinoembrionario (CEA) a 30 ng/mL (previo menor de 2 ng/mL). No tiene síntomas, el examen físico es anodino, la radiografía de tórax es normal. En la TC se aprecia una masa de 3 cm en el lóbulo hepático derecho, que capta en PET. No se observan otras alteraciones en TC ni en PET. ¿Qué actitud le parece más correcta?:

1. Quimioterapia con FOLFIRI (fluorouracilo, leucovorin e irinotecán) más bevacizumab.
2. Monoquimioterapia con capecitabina.
3. Valoración por cirugía de resección de la lesión hepática.
4. Radioterapia hepática.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos presentan un paciente de 57 años con antecedentes de cáncer colorrectal T3N1M0 tratado mediante resección quirúrgica y que después recibió quimioterapia adyuvante.

Durante su control rutinario dos años después, se objetiva un dato importante: una elevación de CEA en la analítica acompañada de la visualización en pruebas de imagen de una nueva lesión hepática única situada en el lóbulo derecho, que en este contexto, nos ha de hacer pensar en una metástasis tardía. Debemos recordar por un lado que en la actualidad la quimioterapia está indicada sólo en pacientes con ganglios positivos o metástasis a distancia (estadios III y IV). Por otro lado, en las metástasis seleccionadas (pulmonares aisladas o hasta tres metástasis hepáticas pequeñas), puede estar indicada la cirugía. Uniendo ambos conceptos y resumiendo, tenemos a un paciente con una ÚNICA metástasis hepática sin otras alteraciones en el TC o el PET, esto es a priori, AUSENCIA de recidiva colorrectal o afectación ganglionar, por lo que estaría indicada la metastasectomía hepática (respuesta 3 correcta, respuesta 1 y 2 incorrectas). La radioterapia hepática no se usa en la práctica clínica actual (respuesta 4 incorrecta).

114. ¿En cuál de las siguientes presentaciones fetales estaría indicada siempre la realización de cesárea?:

1. Occipito iliaca transversa.
2. Nalgas completas.
3. Mento posterior.
4. Una cesárea anterior.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Son indicación directa de cesárea por malpresentación/malposición: la cara mentoposterior (respuesta 3 correcta), la frente, la situación transversa y las nalgas incompletas. La occipito transversa es la posición en la que entran la mayoría de los fetos en el estrecho superior, y no es indicación de cesárea. El antecedente de una cesárea anterior no es contraindicación de parto vaginal. Y la presentación de nalgas puras o nalgas completas bien apoyadas, si bien es controvertido y en muchos hospitales de España no se realizan estos partos, no es contraindicación "absoluta" de parto vaginal.

115. En un estudio farmacoeconómico que comparó dos fármacos antibióticos en el tratamiento de la neumonía, fueron incluidos los costes de la medicación, de las pruebas complementarias y analíticas, de hospitalización, de los efectos adversos de la medicación, del transporte al hospital y de la pérdida de productividad de los pacientes. ¿Cuál fue la perspectiva del estudio?:

1. Perspectiva hospitalaria.
2. Perspectiva del Sistema Nacional de Salud.
3. Perspectiva extrahospitalaria.
4. Perspectiva de la sociedad.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En los estudios farmacoeconómicos la perspectiva va a

definir el punto de vista desde donde se realiza el estudio. Dependiendo de la perspectiva escogida será necesario incluir unos costes u otros. Siempre que sea posible debería elegirse la perspectiva de la sociedad en global, ya que es la que incluye todo tipo de costes. -Perspectiva hospitalaria: incluye costes directos hospitalarios (gastos de médicos, investigadores, pacientes, farmacéuticos, dirección hospitalaria). -Perspectiva extrahospitalaria: incluye costes directos extrahospitalarios (ayudas de hogar, traslados en ambulancias...) y costes de administración y aseguradoras. -Perspectiva de la sociedad: incluye tanto costes directos como indirectos (falta de productividad del paciente enfermo).

116. El virus de la hepatitis C se ha descrito como uno de los factores implicados en la etiopatogenia de los siguientes procesos, EXCEPTO en uno:

1. Crioglobulinemia mixta.
2. Porfiria cutánea tarda.
3. Liquen plano.
4. Psoriasis pustulosa generalizada de von Zumbusch.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En ningún tipo de psoriasis se ha descrito el virus de la hepatitis C como implicado en su etiología. Todas las demás pueden estar relacionadas con este virus.

117. Acude a su consulta un hombre de 80 años de edad para valoración de una colecistectomía programa por laparoscopia. Presenta antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento desde hace 10 años. Niega enfermedad cardíaca ni pulmonar. No presenta dolor torácico. Tiene una vida activa y diariamente acude al gimnasio en donde alterna natación y caminar por la cinta al menos una hora. Tratamiento habitual: nebivolol 5 mg cada 24 horas e hidroclorotiazida 12,5 mg al día. Exploración física: peso 73 kgs; talla 179 cms; presión arterial 138/80 mmHg; frecuencia cardíaca 60 latidos/minuto. No se auscultan soplos. ¿Cuál de los siguientes es el planteamiento preoperatorio más adecuado?:

1. Realizar una prueba de esfuerzo.
2. Realizar una ecocardiografía.
3. Realizar una gammagrafía con talio y dipiridamol.
4. Realizar electrocardiograma.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La elección de los exámenes complementarios en la consulta preanestésica no debe ser sistemática, sino que debe ser valorada por el anestesta en función del paciente (anamnesis y exploración física) y de la intervención. Las tres pruebas complementarias básicas son: Analítica: No se precisa en cirugía menor y sin patología asociada. Hemograma,

glucosa, creatinina y coagulación: realizarlo en toda cirugía mayor. Test de embarazo: pacientes en edad fértil con duda de su estado. ECG: Mayores de 45 años: siempre, excepto si se dispone de ECG previo de hace menos de 1 año y desde entonces no ha presentado semiología cardíológica. Menores de 45 años: realizarlo sólo si hay cardiopatía conocida o sospechada (factores de riesgo cardiovascular), DM severa, hipertiroidismo o EPOC severo. Radiografía de tórax: Realizarla en: - Mayores de 60 años con cirugía mayor. - Patología respiratoria avanzada, neoplasias y fumadores severos con independencia de la edad. - Valorar en obesidad mórbida. El resto de pruebas complementarias cardíológicas (ecocardiografía, prueba de esfuerzo.) sólo se pedirán si el paciente tiene alguna comorbilidad cardíaca que lo justifique. Para elegir las pruebas que deben pedirse existen algoritmos de evaluación de pruebas complementarias del paciente con riesgo cardiovascular. El paciente de nuestra pregunta es hipertenso desde hace 10 años, con frecuencia cardíaca normal, auscultación normal, sin obesidad y realiza ejercicio con normalidad, por lo que el riesgo cardiovascular es bajo y no sospechamos comorbilidades cardíológicas. Por ello, sólo sería necesario realizarle ECG.

118. Mujer de 78 años con antecedentes de diabetes tipo 2 en tratamiento con antidiabéticos orales, HTA en tratamiento con beta-bloqueantes e inhibidores de la ECA, e insuficiencia cardíaca congestiva grado 1 de la NYHA, con FEVI del 48%, y actualmente asintomática. Estado funcional: ECOG 0. Historia de 2 años de evolución de pequeños bultos en el cuello. Biopsia de adenopatía cervical: linfoma folicular grado 2. Estudio de extensión: Hb 12 gr/dL, Leucocitos 6.900/microL (Neutrófilos 60%, Linfocitos 27%, Monocitos 6%, Eosinófilos 4%, Basófilos 4%) Plaquetas 220.000/microL. MO: infiltrada por Linfoma folicular. Creatinina 1,5 mg/dL, LDH 235 U/L, Beta2 microglobulina 2,1 microg/mL. TAC: adenopatías menores de 3 cm en territorios cervical, axilar, retroperitoneo, ilíacos e inguinales; hígado y bazo normales. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más apropiado?:

1. Rituximab-CHOP (Ciclofosfamida, Adriamicina, Vincristina, Prednisona).
2. Rituximab-CVP (Ciclofosfamida, Vincristina, Prednisona).
3. No tratar y vigilar (esperar y ver).
4. Rituximab-Bendamustina.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Mujer anciana con numerosas comorbilidades y con diagnóstico de linfoma folicular. El linfoma folicular es una neoplasia de linfocitos B de bajo grado que habitualmente cursa con pocos síntomas y suele diagnosticarse en estadios avanzados (en este caso concreto describen adenopatías diseminadas e invasión de la médula ósea). En los síndromes linfoproliferativos de bajo grado la instauración de un

tratamiento depende de la clínica que presente el paciente. En este caso dejan claro que la paciente está totalmente asintomática, incluso incluyen el estado funcional de la paciente (ECOG 0). En esta situación no está indicado iniciar ningún tipo de tratamiento debiéndose realizar un seguimiento estrecho: observar y esperar (opción 3 verdadera).

119. Ante un paciente de 8 años de edad que acude por presentar desde hace 3 días lesiones pustulosas superficiales, erosiones y costras amarillentas alrededor de la boca pensaremos en:

1. Eritema exudativo multiforme.
2. Impétigo contagioso.
3. Acné infantil.
4. Psoriasis pustuloso.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El impétigo contagioso es una infección típicamente de la infancia que está causada habitualmente por el *S. aureus* o estreptococos del grupo A. La clínica se caracteriza por presentar costras melicéricas alrededor de los orificios naturales de la cara.

120. Un hombre de 37 años presenta un cuadro de artritis de las metacarpofalángicas de ambas manos y una pleuritis derecha. En la exploración se aprecia eritema malar bilateral. Se detectan anticuerpos antinucleares positivos (título 1/640), con anticuerpos anti-DNA nativo también positivos; anti-Sm negativos. ¿Cuál sería el tratamiento inicial de elección de este paciente?:

1. Glucocorticoides a altas dosis.
2. Glucocorticoides y micofenolato.
3. Antiinflamatorios no esteroideos y antipalúdicos.
4. El cuadro probablemente será autolimitado y no precisa tratamiento.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de una paciente con LES con afectación cutánea, articular y serositis. El tratamiento de primera elección en este paciente sería AINEs, antipalúdicos, y también estarían indicado corticoides a dosis bajas (pero esta última opción no se ofrece en la pregunta del MIR). Los corticoides a altas dosis en el LES están indicados para manifestaciones más graves como nefritis lúpica, neurolupus o manifestaciones hematológicas graves como la anemia hemolítica autoinmune. Inmunosupresores como ciclofosfamida o micofenolato también se reservan para manifestaciones más severas como la nefropatía renal.

121. Un paciente de 72 años acude a consulta con pérdida de memoria progresiva y dificultad para encontrar las palabras de un año de

evolución. ¿Cuál es la exploración más útil para caracterizar el tipo de déficit cognitivo que presenta?:

1. Evaluación neuropsicológica.
2. Resonancia magnética cerebral.
3. Tomografía de Emisión de Positrones.
4. Electroencefalograma.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Ante la sospecha de cualquier demencia, se ha de realizar una evaluación neuropsicológica completa con el objetivo de caracterizar los dominios cognitivos afectados (memoria, lenguaje...) y orientar así el diagnóstico clínico.

122. Encontrándose de guardia médica en el Servicio de Urgencias de su hospital, tiene que atender a un paciente de 64 años de edad con insuficiencia respiratoria aguda. Su estado clínico es crítico, con baja saturación de oxígeno e inestabilidad hemodinámica. Se realiza Rx urgente de tórax que muestra atelectasia de 2/3 del pulmón derecho. Se procede a intubación orotraqueal y ventilación en modo asistido, con FiO2 de 1,0. En una gasometría arterial practicada posteriormente obtenemos estos valores: pH 7,23; PaO2 60 mmHg y PaCO2 30 mmHg. ¿Cuál es la causa de la hipoxemia?:

1. Cortocircuito.
2. Hipoventilación.
3. Baja presión de O2 inspirado.
4. Enfermedad neuromuscular.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta clásica en el MIR. Algoritmo de la hipoxemia. Clínicamente, nos describen a un paciente con atelectasia masiva y con hipoxemia refractaria a oxigenoterapia que precisa de intubación orotraqueal. Omitiendo la información clínica, tenemos a un paciente con hipoxemia intensa (tras intubar, PaO2 de 60 mmHg con una FiO2 de 100%), sin hipercapnia, obviamente con gradiente alveoloarterial muy aumentado, que no corrige con oxígeno a alto flujo (mantiene PaO2 de 60 con FiO2 de 100%), lo que se corresponde con un "efecto shunt" o "cortocircuito". Todo un clásico. Anecdóticamente esta es la primera pregunta en la que se usa oxígeno al 100% (al haber intubado al paciente) en vez de "alto flujo >=40%", que es históricamente lo mas habitual.

123. Acude a la consulta un hombre de 67 años, exfumador, con el diagnóstico de EPOC grave (índice multidimensional BODE 5, FEV1 38%, índice de masa corporal 23, índice de disnea según la escala mMRC 3, distancia recorrida en la prueba de los 6 minutos marcha 260 m) que ha tenido 3 ingresos hospitalarios por exacerbación de su EPOC en los últimos 7 meses. Además

presenta antecedentes de HTA, cardiopatía isquémica con IAM hace 5 años y claudicación intermitente. En la exploración clínica destaca una disminución del murmullo vesicular con sibilancias espiratorias en ambos campos pulmonares y una saturación en la oximetría del 88%. ¿Cuál de las siguientes estrategias terapéuticas NO sería recomendable para este paciente?:

1. Ajuste del tratamiento inhalado con broncodilatadores de larga duración combinando anticolinérgicos y beta-2 adrenérgicos con glucocorticoides inhalados.
2. Iniciar pauta de glucocorticoides orales durante 6 meses para el control de las exacerbaciones.
3. Comprobar que el paciente realiza correctamente la técnica inhalatoria.
4. Iniciar pauta de oxigenoterapia crónica domiciliaria.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Compleja pregunta de manejo crónico de EPOC. Nos dan un paciente EPOC grado III grupo D: al tener FEV1 <50% es grado III de obstrucción, por reagudizaciones frecuentes es un paciente de alto riesgo (C o D), y al tener disnea grado mayor que 1 mMRC es paciente muy sintomático, por tanto grupo D. Con eso ya podemos establecer el tratamiento farmacológico, que sería el correspondiente a un grupo D de GOLD: beta agonistas de acción corta de rescate, y un tratamiento pautado de base. A día de hoy se recomienda tratamiento escalonado: primero anticolinérgico, después añadir beta-agonista de acción prolongada si no se controla, después añadir corticoides inhalados si no se controla. Por lo que la opción 1 no es recomendable para cualquier EPOC grado D. Pero dado el pésimo control sintomático y gran número de agudizaciones, en este paciente sería válido empezar un tratamiento de choque y desescalar cuando esté mejor controlado (opción 1 correcta con reservas). No está indicado añadir corticoides orales en una situación estable (sí que lo estaría en una agudización, pero no de forma tan prolongada sino tan solo unos días, se recomiendan pautas cortas de 5 días), luego la opción 2 es francamente incorrecta. Siempre que haya un deterioro clínico hay que comprobar que la técnica inhalatoria sea correcta antes de establecer modificaciones terapéuticas. Además, como el paciente tiene saturación de base de 88% tiene indicación de oxigenoterapia crónica domiciliaria; recuerda que está indicada en pacientes no fumadores, estables clínicamente, con tratamiento farmacológico correcto (opción 4 correcta con reservas, no tiene un tratamiento correcto), y que tengan hipoxemia grave, o bien PaO₂ <55 mmHg (o saturación <89%, como este caso) o bien PaO₂ 55-60 (o saturación = 89% justa) en presencia de complicaciones tipo hipertensión pulmonar, poliglobulia, etc.

124. Una chica de 20 años acude a urgencias porque ha notado tras levantarse, al mirarse al espejo,

debilidad en toda la mitad derecha de la cara (incluida la frente, cerrar el párpado y para sonreír). Se acompaña de disgeusia, con sensación de sabor metálico de los alimentos así como de hiperacusia y dolor mastoideo ipsilateral. En la exploración no se evidencia déficit de la fuerza ni déficits sensitivos en extremidades ni alteraciones del habla ni lenguaje. En este caso, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es la correcta?:

1. El diagnóstico más probable es una placa desmielinizante en hemiprotuberancia contralateral, la exploración complementaria más necesaria sería una resonancia magnética craneal.
2. Los corticoides vía oral son de elección en el tratamiento de la paciente.
3. Debe ser considerada la fibrinólisis endovenosa si el tiempo de evolución es menor a 3 h.
4. Lo más probable es que el cuadro sea irreversible.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos presentan un caso clínico de una paciente que presenta una parálisis facial periférica. Para llegar a este diagnóstico es fundamental observar que se encuentra afectada la musculatura de la frente. Para descartar el raro e hipotético caso de una afectación nuclear, nos inciden en la ausencia de síntomas neurológicos centrales. Los síntomas más comúnmente asociados a la parálisis son la algiacusia (por afectación del nervio estapedial) y la disgeusia (alteraciones del gusto por afectación del nervio cuerda del tímpano) además de un cierto dolor mastoideo ocasionalmente. La etiología más común es la idiopática (la infección vírica es la teoría más comúnmente aceptada), se trata con corticoterapia y el pronóstico es bueno (70-80% de recuperación).

125. Una mujer de 59 años con antecedentes personales de cáncer de mama intervenida hace 8 meses y osteoporosis, sufre una caída y tiene una fractura de cuello de fémur derecho. Es intervenida quirúrgicamente y permanece ingresada en reposo con escayola durante 10 días. A la semana siguiente de su alta nota de forma súbita falta de aire que la lleva a consultar a su médico de cabecera que nota que su pantorrilla derecha tiene edema y dolor a la palpación. ¿Qué elementos clínicos NO serían importantes a la hora de determinar que tiene un riesgo clínico alto de padecer una tromboembolia pulmonar?:

1. El antecedente de cáncer de mama.
2. La historia de osteoporosis.
3. El antecedente de haber estado más de 3 días en reposo.
4. La presencia de edema unilateral de la pantorrilla derecha.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Nos preguntan por los datos que aumentan la sospecha de enfermedad tromboembólica, que son dos cosas: la clínica del paciente y los factores de riesgo de enfermedad tromboembólica. Los factores de alto riesgo se pueden agrupar en tres grandes grupos de patologías: patologías que condicionan inmovilismo (como fracturas de MMII o cirugías mayores), patologías hematológicas que alteran la coagulación (típicamente Factor V de Leyden o mutación 20210 de la protrombina) y patologías médicas procoagulantes, como puede ser un cáncer activo, un síndrome nefrótico, un síndrome antifosfolípido, o una infección o pancreatitis graves. La osteoporosis no es un factor de riesgo tromboembólico (no condiciona inmovilismo ni procoagulabilidad, pero ojo que favorece las fracturas de cadera). Por otra parte hay que valorar las características clínicas. La presencia de síntomas de TVP aumenta enormemente la probabilidad de TEP. La presencia de hallazgos exploratorios (por ejemplo, un desdoblamiento fijo del R2) o electrocardiográficos (por ejemplo el patrón S1Q3T3) típicos de TEP también aumentan la probabilidad de TEP.

126. Chico de 20 años, que consulta por dolor lumbosacro de ritmo inflamatorio de 4 meses de evolución. También talalgia bilateral y rigidez matutina de 1 hora. En los últimos 2 meses aparición de cuadros diarreicos con pérdida de 4 kg de peso. ¿Cuál es la aproximación diagnóstica más correcta?:

1. Dada la edad del paciente, lo más probable es que padezca lumbalgia inespecífica y una tendinitis en los pies. Si persisten las diarreas realizaría estudio digestivo.
2. Realizaría estudio digestivo para descartar patología tumoral. El dolor lumbar puede ser debido a patología visceral.
3. El cuadro clínico es muy sugestivo de espondiloartritis. Habría que descartar enfermedad inflamatoria intestinal.
4. Solicitaría RNM lumbar para descartar hernia discal y si persiste diarrea, estudio digestivo.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Se trata de un paciente <45 años con lumbalgia inflamatoria de más de 3 meses de evolución con talalgia (entesitis aquílea vs fascitis plantar), con un cuadro de pérdida de peso y diarreas. Todo esto es sugestivo de una espondiloartritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. Por tanto, hay que hacer un estudio dirigido para dicho diagnóstico. Si se pidiera una RMN lumbosacra en este paciente sería para descartar una sacroileitis y no para descartar una hernia discal.

127. Un paciente de 25 años, durante un partido de tenis, tiene dolor intenso en el cuello y en el ojo

izquierdo. La mañana siguiente se despierta con sensación de inestabilidad de la marcha y tiene ptosis palpebral del ojo izquierdo y anisocoria, siendo la pupila izquierda más pequeña que la derecha. El paciente mantiene buena agudeza visual. ¿Dónde localizaría con más probabilidad la lesión?:

1. III par craneal.
2. Quiasma óptico.
3. Ganglio cervical superior.
4. Bulbo raquídeo.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Ante un síndrome de Horner (ptosis, miosis...) en un paciente joven tras antecedente traumático o de manipulación cervical (aceptemos "jugar al tenis" como ejemplo), hay que pensar en una disección carotídea (que cursaría con déficits focales del territorio carotídeo izquierdo, es decir, afasia, hemiparesia y hemihipoestesia derechas, hemianopsia derecha, etc.) o vertebral, siendo ésta última, junto a la disección de la PICA, causas del infarto bulbar lateral o síndrome de Wallenberg. La presencia de vértigo e inestabilidad de la marcha hace pensar más que se trate de esta última entidad.

128. Paciente de 45 años en estudio por posible meningitis, con fiebre, cefalea y vómitos de 2 días de evolución. Le realizan una RM cerebral y una punción lumbar. Veinte horas después, al levantarse para ir al baño, se queja de cefalea intensa, muy marcada al incorporarse pero que desaparece al tumbarse. Ya no presenta fiebre ni vómitos. No puede caminar. ¿Cuál es con más probabilidad el origen de esta cefalea?:

1. La meningitis sigue siendo la causa fundamental de su cefalea, pues es el mismo tipo de cefalea que al inicio de los síntomas.
2. Es una cefalea post-punción lumbar.
3. Hay que buscar una causa diferente a esta cefalea, pues no es típica del síndrome postpunción lumbar ni de la meningitis.
4. Lo más probable es que no fuera una meningitis viral, sino una hemorragia subaracnoidea. Por este motivo, la cefalea inicial desaparece casi completamente al tumbarse.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Ante una cefalea con características ortostáticas (desaparece con el decúbito y aparece con la sedestación/bipedestación) y el antecedente reciente de punción lumbar, hay que pensar en una cefalea post-punción lumbar (por hipotensión endocraneal) como primera posibilidad. El curso suele ser benigno con analgesia, reposo, cafeína e hidratación. Si con

esto no es suficiente, se puede realizar un parche hemático epidural, que es altamente efectivo.

129. Acude a una revisión programada encontrándose asintomático un hombre de 50 años diagnosticado de poliangéitis con granulomatosis 10 años antes y sin tratamiento desde hace 5. La radiografía de tórax, análisis de sangre y sedimento de orina son normales salvo unos anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo (ANCA) positivos a título 1/320, con especificidad antiproteínasa 3, que previamente se habían negativizado. ¿Cuál es la actitud terapéutica más aconsejable?:

1. Iniciar tratamiento con corticoides.
2. Iniciar tratamiento con ciclofosfamida.
3. Iniciar tratamiento con micofenolato de mofetilo.
4. Vigilancia expectante.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En la poliangéitis granulomatosa ANCA positiva está descrito que los c-ANCA, además de ser herramientas diagnósticas, monitorizan la actividad de la enfermedad. Pero eso no quiere decir que haya que tomar decisiones terapéuticas únicamente en función del título de estos anticuerpos. En un paciente que esté asintomático y con pruebas complementarias normales, en el que sólo se observe una elevación de c-ANCA que previamente se habían negativizado, no hay que intensificar el tratamiento. Hay que hacer una vigilancia clínica estrecha porque dicha elevación puede ser el preámbulo de un brote de la enfermedad.

130. Señale la respuesta INCORRECTA respecto al Síndrome Hemolítico Urémico (SHU):

1. El cuadro se caracteriza por la triada de anemia hemolítica microangiopática no inmune, trombocitopenia y fracaso renal agudo.
2. En algunos casos, dicho síndrome es la consecuencia de una disregulación de la vía alternativa del sistema del complemento.
3. Se acompaña de anemia hemolítica con test de Coombs positivo.
4. Los niveles altos de lactato deshidrogenasa (LDH) e indetectables de haptoglobina junto con la presencia de esquistocitos, confirman la presencia de hemólisis intravascular.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Todos los síndromes de microangiopatía trombótica cursan con una triada común de trombopenia por consumo, anemia hemolítica microangiopática y fracaso renal agudo (en ocasiones con datos de síndrome nefrítico) (respuesta 1 verdadera). La anemia se produce como consecuencia de la fragmentación física de los hematíes en el interior

de los capilares trombosados, por lo que encontraremos fragmentos eritrocitarios (esquistocitos) así como elevación de LDH y descenso de haptoglobina al ser una hemólisis intravascular (respuesta 4 verdadera); el Coombs será típicamente negativo, ya que la destrucción obedece a un fenómeno mecánico y no inmunológico (respuesta 3 falsa, y por tanto CORRECTA). Las principales entidades causantes de microangiopatía trombótica son el SHU típico (infección por E. coli enterohemorrágico capaz de producir toxina Shiga), el SHU atípico (causado por defectos en proteínas reguladoras del complemento, produciéndose una activación incontrolada del mismo) (respuesta 2 verdadera) y la PTT (déficit de actividad de ADAMTS 13), aunque se puede encontrar en otros cuadros (preeclampsia, crisis renal esclerodérmica, CID, síndrome antifosfolípido.).

131. Ante una gasometría extraída respirando aire ambiente a nivel del mar con pH 7,44, PaO₂ 55 mmHg y PaCO₂ 33 mmHg, ¿cuál de los siguientes diagnósticos es MENOS probable?:

1. Insuficiencia cardíaca.
2. Neumotórax.
3. Sobredosis de benzodiacepinas.
4. Intoxicación por monóxido de carbono.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sobre un tema clásico en el MIR, algoritmo de la hipoxemia. Nos dan a un paciente con hipoxemia y con hipocapnia, es decir con datos de hiperventilación. Con esos datos podemos descartar hipoventilación como mecanismo causal. La intoxicación por benzodiacepinas provoca hipoxemia por hipoventilación debida a la depresión del centro respiratorio, luego nunca será compatible con una gasometría como la descrita. En cambio, una insuficiencia cardíaca o un neumotórax pueden tener hiperventilación compensadora. Se podría argumentar que una intoxicación por monóxido de carbono no provoca hipoxemia pues la insuficiencia respiratoria se debe a pérdida de hemoglobina circulante eficaz, y que por tanto no es compatible. Pero una intoxicación por monóxido deriva de respirar un aire enriquecido en CO y por tanto empobrecido en O₂, por lo que en una intoxicación muy grave puede haber un aire muy enrarecido en oxígeno por el exceso de CO, y por tanto aparecer un hipoxemia por hipoxia ambiental, que cursa también con PaCO₂ no elevada.

132. Hombre de 55 años que consulta por disfonía. En la anamnesis refiere llevar un mes con astenia y pérdida de peso no cuantificada. La radiografía de tórax presenta un aumento de densidad en lóbulo superior izquierdo y ocupación de la ventana aorto-pulmonar. La broncoscopia constata una parálisis de la cuerda vocal izquierda, sin imagen endoscópica sugestiva de neoplasia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Neoplasia pulmonar.
2. Sarcoidosis.
3. Silicosis.
4. Tuberculosis.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos dan un paciente con disfonía y cuadro constitucional, que en la exploración ORL no tiene afectación directa de cuerda vocal (no es un cáncer de laringe) pero sí una parálisis unilateral, lo que es diagnóstico de parálisis recurrente. Esto sugiere como diagnóstico más probable una neoplasia pulmonar, que al infiltrar nervio recurrente ya será considerada T4. La radiografía nos da efectivamente una imagen de aumento de densidad en lóbulo superior izquierdo, que podría ser la propia masa o bien neumonitis obstructiva (no queda claro con la descripción del enunciado).

133. Acude a la consulta una mujer de 30 años de edad refiriendo en los tres últimos meses ansiedad, pérdida de unos 6 kg de peso y sensación de "nerviosismo". En la exploración física destaca taquicardia, hiperreflexia y ausencia de bocio. En la analítica realizada los valores de la TSH son < 0.01 microU/mL, la T4 está elevada y los niveles de tiroglobulina descendidos. Al realizarle una gammagrafía se detecta una ausencia de captación en la región tiroidea. ¿Cuál le parece el diagnóstico más probable?:

1. Tirototoxicosis facticia.
2. Hipertiroidismo por Enfermedad de Graves.
3. Teratoma de ovario (estruma ovárico).
4. Tiroiditis subaguda.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Caso clínico típico de tirototoxicosis facticia, poco preguntado en el MIR, pero que se responde con los conceptos básicos estudiados. La TSH suprimida y LT4 elevadas nos confirman la tirototoxicosis. La ausencia de bocio y de captación gammagráfica descartan la enfermedad de Graves; y la tiroglobulina disminuida descarta una tiroiditis (TG normal/elevada y frecuentemente bocio). Si bien el struma ovarii (secreción ectópica de T4 por teratoma ovárico) puede cursar con TG normal o baja, es una causa extremadamente rara y poco probable.

134. Uno de los siguientes fármacos NO se utiliza en el tratamiento de la hepatitis crónica B:

1. Entecavir.
2. Adefovir.
3. Tenofovir.
4. Sofosbuvir.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El entecavir, el adefovir y el tenofovir (respuestas 1, 2 y 3 respectivamente) son fármacos antivirales orales que

son análogos de nucleósidos/nucleótidos que suprimen la replicación del VHB inhibiendo la polimerasa y por tanto no consiguen eliminar el virus por completo por lo que han de administrarse de forma indefinida (a diferencia del Interferon alfa pegilado que en algunas ocasiones consigue la remisión completa del VHB mediante estimulación de la respuesta inflamatoria mediada por linfocitos T). El Sofosbuvir es un antiviral oral de acción directa usado en el tratamiento de la hepatitis crónica por VHC. Es un inhibidor de la polimerasa NS5B y es importante recordar que muchas veces se combina con Ledipasvir (Sofosbuvir-Ledipasvir). Respuesta 4 correcta.

135. Respecto al tratamiento inmunosupresor actual utilizado en el trasplante renal es cierto todo EXCEPTO:

1. El tacrolimus se usa menos que la ciclosporina porque asocia mayor riesgo de diabetes.
2. El micofenolato mofetil inhibe la síntesis de purinas y puede producir diarrea.
3. Los esteroides son coadyuvantes de otros inmunosupresores, bloquean transcripción de interleucinas y se suelen usar en el rechazo agudo.
4. Sirolimus suele usarse en combinación con otros y puede causar hiperlipidemia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La terapia inmunosupresora de mantenimiento del trasplante renal se basa en la combinación de CORTICOIDES + ANTICALCINEURÍNICOS (ciclosporina o tacrolimus) + INMUNOSUPRESOR (azatioprina, micofenolato mofetil o sirolimus). Respecto a dichos fármacos: - Los esteroides se usan a dosis altas en la fase aguda, debiéndose posteriormente reducir su dosis hasta la mínima posible por sus efectos adversos (hipercortisolismo, yatrogénico, infecciones, etc.) (respuesta 3 verdadera). - Ciclosporina y tacrolimus son anticalcineurínicos (inhiben la calcineurina, sustancia relacionada con la activación linfocitaria); ambos son potencialmente nefrotóxicos (deben monitorizarse estrechamente sus niveles); la ciclosporina puede causar hirsutismo e HTA, mientras que el tacrolimus es un fármaco diabético, pero los dos son fármacos ampliamente empleados (respuesta 1 falsa, por tanto CORRECTA). - La azatioprina es un inhibidor de las purinas; su principal efecto adverso es el desarrollo de citopenias (sobre todo en pacientes con déficit de la enzima TMPT). - El micofenolato de mofetil actúa inhibiendo la síntesis de las purinas (concretamente la guanosina); su efecto adverso más importante es a nivel gastrointestinal (sobre todo causa causando diarrea) (respuesta 2 verdadera). - El sirolimus es un inhibidor de la mTOR, siendo su principal efecto secundario el desarrollo de hiperlipidemia (respuesta 4 verdadera).

136. La complicación más frecuente de una fractura de olecranon intervenida y tratada con osteosíntesis tipo cerclaje/tirante (Obenque) es:

1. Neuritis nervio cubital.
2. Osificación heterotópica.
3. Molestias derivadas del material de síntesis implantado.
4. Limitación de la flexión del codo.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta compleja sobre las complicaciones del tratamiento de las fracturas de olécranon. Es un tema que nunca había sido preguntado. El cerclaje en ocho u obenque es el tratamiento de elección para las fracturas de olécranon (también de las transversas de rótula). La complicación más frecuente son las molestias derivadas del material de osteosíntesis. Esto es así porque el material implantado está muy cercano a la piel y en el momento que el paciente comienza a realizar una vida normal cuando la fractura ha consolidado produce molestias. El tratamiento se basa en la extracción del material de osteosíntesis.

137. Un niño de 13 años presenta dolor dorsal de varios meses de evolución, sólo a la bipedestación y a la marcha. ¿Qué diagnóstico debemos de pensar?:

1. Enfermedad de Scheuermann.
2. Escoliosis torácica.
3. Tumor maligno del cuerpo vertebral.
4. Se trata de una sobrecarga mecánica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta compleja por la ambigüedad del enunciado y totalmente impugnado. Describen a un paciente que consulta por dolor de tipo mecánico (bipedestación y marcha) en la región dorsal de varios meses de evolución; no describen ningún tipo de deformidad, no presenta clínica neurológica asociada ni ningún dato de gravedad que pueda sugerir un tumor. Ante estos datos el único cuadro compatible es una dorsalgia por sobrecarga mecánica. Sin embargo, el Ministerio dio por buena la opción 3; para pensar en una enfermedad de Scheuermann deberían darnos algún dato adicional en la exploración física como es la cifosis, y por ello consideramos la pregunta impugnada. La cifosis de Scheuermann es una deformidad estructural de la columna torácica o toracolumbar, que aparece justo antes de la pubertad, tras la osificación de los platillos vertebrales, y empeora durante el crecimiento en la etapa adolescente hasta alcanzar la madurez esquelética. La deformidad puede ser por lo tanto progresiva y hacerse sintomática durante el crecimiento.

138. Hombre de 25 años sin antecedentes de interés que acude a urgencias con fiebre, cefalea, mialgias, náuseas, vómitos, dolor abdominal, ictericia e inyección conjuntival, 2 semanas después de haber viajado a Tailandia para participar en una regata en agua dulce. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Malaria.
2. Esquistosomiasis.
3. Leptospirosis.
4. Rabia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sobre una fiebre del viajero no habitual. Este paciente con fiebre, mialgias, vómitos, dolor abdominal podría perfectamente tener una malaria, pero hay que fijarse en un dato clave en esta pregunta, que es la inyección conjuntival, que es el dato típico y característico de la leptospirosis. Fijaros en que nos recalcan el antecedente de participación en una regata de agua dulce, ya que el contagio suele ocurrir por contacto con aguas contaminadas con orina de roedores (que son el reservorio de Leptospira). La otra posibilidad sería una esquistosomiasis, que también se adquiere por contacto con agua dulce, pero no nos dan ni el antecedente de que el paciente haya sufrido "prurito del bañista" (producido por la entrada de las microcercarias de Schistosoma a través de la piel) y además el periodo de incubación de la fiebre de Katayama (el cuadro clínico de esquistosomiasis aguda) suele tener un periodo de incubación más prolongado que en este caso (entre 3 y 6 semanas). Por último, para pensar en la rabia nos tendrían que dar un antecedente de mordedura por algún animal portador.

139. Un hombre de 32 años natural de Camerún consulta por fiebre tos y dolor en hemitórax izquierdo de 1 mes de evolución. Tomó durante 1 semana amoxicilina-clavulánico sin mejoría de los síntomas. Se le realiza un análisis donde destaca una cifra de leucocitos de 8000/microL y una hemoglobina de 12,8 g/dL. En la radiografía de tórax se observa un derrame pleural izquierdo loculado que ocupa un tercio del hemitórax. Una toracentesis muestra un líquido amarillento con las siguientes características: hematíes 2000/?L, leucocitos 2500/?L con 90% de linfocitos, proteínas 4,9 g/dL, lactato deshidrogenasa 550 U/L, glucosa 67 mg/dL y ausencia de células malignas en el estudio citológico. ¿Cuál de las siguientes pruebas sería más útil para diagnosticar la causa del derrame pleural?:

1. Una tomografía computarizada (TC) torácica.
2. Medición del pH del líquido pleural.
3. Medición de la adenosina desaminasa del líquido pleural.
4. Prueba de la tuberculina.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Derrame pleural de un mes de evolución en un paciente africano que ha tenido fiebre y tos. Solo con eso ya deberíamos estar pensando en tuberculosis. Pero además nos dan el análisis del líquido, que es un exudado de predominio linfocitario. La causa más frecuente en el mundo para un líquido de estas características es la tuberculosis. Y nos preguntan qué exploración complementaria nos puede

ayudar más al diagnóstico, por tanto será aquella que más nos ayude a confirmar/descartar una tuberculosis pleural. La respuesta es el ADA (adenosin deaminasa), enzima que de forma característica está elevada en los derrames tuberculosos y que se caracteriza por su altísima sensibilidad, si bien no tan buena especificidad (o dicho de otra manera, muy alto valor predictivo negativo). En cualquier caso, con un antecedente epidemiológico compatible y un líquido compatible con ADA elevado en este paciente hay pocas dudas para hacer un diagnóstico de presunción de tuberculosis pleural y tratarlo. En un paciente joven el TC torácico no nos aportará demasiado ya que no esperamos encontrarnos una neoplasia (opción 1 falsa). El pH será útil y probablemente será bajo (como es de esperar en un exudado que lleva tiempo) pero no nos orientará mucho (opción 2 falsa) y la prueba de la tuberculina puede ser útil pero este paciente puede tenerla falsamente negativa (puede ser que aún no se haya positivizado en el transcurso de esta probable primoinfección tuberculosa) y su negatividad no nos descarta la tuberculosis pleural, que es lo más importante a descartar en este paciente (opción 4 falsa).

140. La aparición de fiebre elevada de 39°C en un lactante de 10 meses que cede bruscamente después de 3-5 días, seguido de un exantema morbiliforme cefalocaudal con enantema constituido por pápulas rojizas en paladar, y que se resuelve en una semana, asociado a buen estado general, suele estar producido por:

1. Parvovirus B19.
2. Herpes virus tipo 6.
3. Virus Coxsackie A16.
4. Primoinfección por virus de Epstein-Barr.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Se trata de un caso clínico de exantema súbito, que se caracteriza por la aparición de fiebre durante 3 días seguido de un exantema con afectación de mucosa. Se debe a la infección por el virus VHH 6-7.

141. Indique la situación clínica que, en relación con la infección por virus de la hepatitis B, presenta un paciente de 5 años procedente de Nigeria, con exploración física normal y con la siguiente serología frente a hepatitis B: HBsAg + / ANTI-HBs - / HBeAg - / ANTI-HBe + / ANTI-HBc IgM - / ANTI-HBc IgG + / DNA VHB +:

1. Infección aguda.
2. Infección crónica.
3. Paciente vacunado.
4. Portador asintomático.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Por los datos sociodemográficos (niño y Nigeria) ya podemos pensar que la hepatitis crónica es de transmisión vertical. La serología nos dice que es portador (HBsAg+) crónico(

antiHBcIgG+) que presenta seroconversión o bien mutante precore. Tanto en la seroconversión como el mutante precore tienen HBeAg- y antiHBe+ y son los valores de DNA o las transaminasas los que lo diferencian. Tras la seroconversión, los niveles de ADN VHB son bajos, inferiores a 2.000 UI/ml y los mutante precore tiene unos valores mucho más altos. Aquí solo nos dice que el DNA es positivo y no constan las transaminasas, por lo que no sabemos si es un paciente con seroconversión o mutante precore pero en cualquier caso la opción correcta es la 2 infección crónica que ya lo sabíamos con solo HBsAg+ y antiHBcIgG+. El término portador asintomático no existe ni sustituye al término portado inactivo y que probablemente lo han puesto como trampa. Ser portador sólo indica tener la infección ya sea aguda y crónica; asintomático solo vendría a decir que es anictérica.

142. Respecto a la enfermedad del injerto contra huésped (EICH) post-trasplante de progenitores hemopoéticos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?:

1. El proceso fisiopatológico de la EICH tiene su origen en las células T del donante.
2. La profilaxis de la EICH consiste en tratamiento inmunosupresor, frecuentemente ciclosporina asociada a metotrexate, y el tratamiento de la EICH establecida consiste en corticoterapia.
3. La eliminación de los linfocitos del donante del injerto mejora el implante de los progenitores. La eliminación de los linfocitos del donante del injerto mejora el implante de los progenitores.
4. En la mayoría de los pacientes diagnosticados EICH crónica, ésta llega a desaparecer pudiendo interrumpir el tratamiento inmunosupresor sin que la enfermedad recidive.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La enfermedad injerto contra huésped (EICH) acontece tras el trasplante ALOGÉNICO de progenitores hematopoyéticos. Ocurre cuando las células T del donante atacan al tejido del receptor (opción 1 verdadera). La EICH aguda generalmente ocurre en los primeros 100 días posteriores al trasplante y sus órganos diana fundamentales son la piel, el hígado y el intestino. La EICH crónica se manifiesta como una afección multisistémica que puede aparecer a continuación de la forma aguda, después de la resolución de la misma o bien surgir de novo. Su clínica y sus alteraciones anatomopatológicas se asemejan a diversas enfermedades autoinmunes como la esclerodermia o el lupus. Las pautas más habituales para la profilaxis de la EICH aguda se basan en la combinación de un inhibidor de la calcineurina (ciclosporina A o tacrolimus) con metotrexate. El tratamiento de la EICH establecida se basa en la administración de fármacos inmunosupresores adicionales, añadidos a los que el paciente estuviera tomado como profilaxis, como por ejemplo la metilprednisolona (opción 2 verdadera). La enfermedad de injerto contra huésped puede ser en gran medida evitada si se utiliza médula ósea de la cual se ha eliminado la mayor parte de los linfocitos T. Sin embargo, este tipo de trasplantes presentan la

desventaja de un efecto injerto contra tumor disminuido, un mayor riesgo de falla del trasplante, una mayor probabilidad de reaparición del cáncer, además de una inmunodeficiencia general, lo que resulta en un paciente más susceptible a infecciones virales, bacterianas y fúngicas (opción 3 falsa). Una vez transcurrido el año desde el trasplante la mayoría de los receptores habrán producido linfocitos T nuevos compatibles con las células del donante, en este periodo se reduce la necesidad del tratamiento inmunosupresor (opción 4 verdadera).

143. Una mujer de 25 años se presenta en el servicio de Urgencias por presentar en los últimos días equimosis y petequias en extremidades inferiores, así como gingivorragia. En el hemograma presenta los siguientes datos: Hb 13 g/dL, leucocitos 8.500/microL con fórmula leucocitaria normal y plaquetas 9.000/mm³. La determinación de los tiempos de coagulación es normal. ¿Cuál de las siguientes pruebas diagnósticas NO es preciso realizar?:

1. Mutación JAK-2.
2. Aspirado de médula ósea.
3. Anticuerpos antinucleares.
4. Frotis de sangre periférica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Mujer joven con sangrado de piel y mucosas y trombopenia aislada. Cuadro clínico típico de la púrpura trombocitopénica idiopática (PTI). Esta pregunta se contesta por descarte. La mutación del JAK2 es típica de síndromes mieloproliferativos crónicos que cursan con niveles de hemoglobina elevados, leucocitosis y lo más importante para poder contestar a esta pregunta, trombocitosis.

144. Ante un paciente de 65 años sin antecedentes de interés que acude a la urgencia de un hospital, con fiebre de 39 °C, síndrome meníngeo y signos de gravedad (coma, PA 80/60 mmHg, mal perfundido), ¿cuál de las siguientes actuaciones considera más correcta en este momento?:

1. Extraer hemocultivos, perfundir suero salino y administrar tratamiento con dexametasona, ceftriaxona, vancomicina y ampicilina intravenosos y después hacer TAC craneal y punción lumbar si no hay contraindicación y reevaluar el tratamiento tras el TAC.
2. Hacer TAC con la urgencia que se pueda, fondo de ojo, posterior cultivo del LCR y tratamiento antibiótico dirigido según los datos del GRAM del LCR.
3. Poner antitérmico iv, iniciar tratamiento con dopamina iv a dosis alfa y cuando esté estable hemodinámicamente, hacer TAC craneal, punción lumbar e iniciar tratamiento antibiótico guiado según los datos analíticos

del LCR.

4. Iniciar tratamiento con ceftazidima + aciclovir + vancomicina intravenosos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla y directa. Nos presentan un paciente con fiebre y síndrome meníngeo que podemos decir que está casi en shock séptico. La sospecha de meningitis bacteriana aguda es clara y nos preguntan por la mejor secuencia de actuación. En esta situación de extrema gravedad lo prioritario es salvar la vida del paciente y por lo tanto cualquier opción que no sea administrar tratamiento antibiótico empírico se descarta (opciones 2 y 3 falsas), ya que evidentemente en este paciente la punción lumbar se va a demorar (primero habrá que remontar su presión arterial, colocar vía central, etc.). El tratamiento empírico adecuado en una persona >50 años es ceftriaxona ó cefotaxima asociada a vancomicina y ampicilina (opción 1 correcta). Con ceftazidima y aciclovir no cubrimos adecuadamente ni el neumococo (causa más frecuente de meningitis bacteriana aguda en mayores de 20-35 años) ni Listeria, por lo tanto esta opción es falsa.

145. Usted valora a un paciente de 66 años con dolor inguinal acentuado con la bipedestación prolongada algunos días al mes. Una radiografía simple de caderas muestra estrechamiento del espacio articular femoro-acetabular, esclerosis y osteofitos. ¿Cuál es su actitud?:

1. Hago el diagnóstico de coxartrosis y envío al traumatólogo para colocar una prótesis de cadera.
2. Inicio tratamiento con opioides débiles que han demostrado evidencia en detener la progresión de la enfermedad.
3. Instauro tratamiento con paracetamol, explico que la evolución es muy variable y la indicación quirúrgica depende de la funcionalidad y control del dolor.
4. Por las características radiológicas descritas, necesito una RMN de cadera antes de tomar una decisión terapéutica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de un paciente con una clínica y radiografía de coxartrosis. La medida que se debe tomar en primer lugar es el tratamiento analgésico con paracetamol y/o metamizol. Si precisara, se podrían pautar también opioides débiles como tramadol. Si el dolor persiste y repercute en su funcionalidad diaria, estaría indicado en ese momento remitir a Traumatología para plantear intervención quirúrgica.

146. Niño de 12 meses de edad, que en los exámenes de salud practicados desde el nacimiento presenta testículo derecho en conducto inguinal que no es posible descender hasta el escroto. Señale la respuesta CORRECTA:

1. El diagnóstico más probable es el de testículo retráctil.
2. Se ha de esperar hasta los dos años de edad a que ocurra descenso espontáneo del mismo.
3. La gonadotropina coriónica humana es el tratamiento de primera elección.
4. La indicación de orquidopexia no debe diferirse.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta controvertida. Se trata de un caso clínico con testículo en canal inguinal desde el nacimiento. La AEP (Sociedad Española de Pediatría) recomienda en sus opciones de tratamiento la orquidopexia laparoscópica como tratamiento de 1ª elección. Aunque existe posibilidad de administración de HCG buscando un efecto LH para determinar el descenso del testículo, las tasas de éxito son muy discutidas. Por ello, el adecuado desarrollo de técnicas endoscópicas, los avances en la anestesiología y un menor impacto psicológico en los padres y los niños, ha condicionado a la mayoría de los expertos a recomendar la intervención quirúrgica antes de los 18 meses de edad, pero no antes de los 6 por la posibilidad de descenso espontáneo. Cuando se acompaña de una hernia inguinal, podría incluso adelantarse la edad de la cirugía.

147. Señale la afirmación FALSA respecto de la sarcoidosis:

1. La presencia de infiltrados parenquimatosos sin afectación hiliar en la sarcoidosis pulmonar indican un estadio III.
2. El método más sensible para detectar enfermedad pulmonar intersticial en la sarcoidosis es la medición de la capacidad de difusión del CO (DLCO).
3. Un aumento del número de linfocitos totales en el lavado broncoalveolar (BAL) así como un cociente CD4/CD8 inferior a 3.5 en el BAL es altamente sugestivo de sarcoidosis.
4. La elevación de la enzima de conversión de angiotensina en sangre por encima de 2 veces su valor normal es congruente con el diagnóstico de sarcoidosis, si bien su sensibilidad y especificidad son bajas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta conceptual sobre la sarcoidosis. La sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria intersticial multisistémica que afecta al pulmón en el 90% de los pacientes. Lo más frecuente es afectación solo ganglionar, y se denomina estadio I cuando tan solo hay adenopatías. Cuando hay afectación intersticial se puede evidenciar patrón intersticial en la radiografía, con (estadio II) o sin (estadio III) adenopatías asociadas; su dato más precoz y por tanto más sensible es la afectación de la difusión del CO que refleja la afectación del intersticio. El dato característico es la presencia de un lavado broncoalveolar rico en linfocitos, con un cociente CD4/

CD8 aumentado, superior a 3 (por ello, opción 3 incorrecta). Clásicamente se aproximaba el diagnóstico con la elevación de la ECA (enzima convertidora de angiotensina), pero dicha elevación es poco sensible (hay sarcoidosis sin ella) y poco específica (se puede ver también en otras patologías granulomatosas) así que no se recomienda a día de hoy.

148. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto a la estadificación del cáncer de páncreas?:

1. La estadificación local puede realizarse con RM y TC.
2. La invasión tumoral arterial es un criterio de irresecabilidad.
3. La infiltración focal de la vena mesentérica superior no es una contraindicación a la cirugía.
4. La biopsia preoperatoria de los tumores pancreáticos es habitualmente necesaria para decidir el tratamiento quirúrgico.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La primera opción es cierta: las técnicas de elección para el estadiaje son TAC y RMN. También se incluye la ecoendoscopia. La invasión arterial tumoral puede ser criterio de irresecabilidad o convertir a un tumor en borderline-resecable en función de los vasos afectados y los grados que afecte al vaso. Los CRITERIOS DE IRRESECABILIDAD son METÁSTASIS A DISTANCIA (incluye adenopatías no regionales); AFECTACIÓN ARTERIAL: Contacto >180° con arteria mesentérica superior, contacto >180° con tronco celiaco, contacto con primera rama yeyunal de la arteria mesentérica superior, contacto con la aorta; AFECTACIÓN VENOSA: Oclusión (trombosis/tumor) o contacto de la vena mesentérica superior o vena porta irreconstruible. Con esto se deduce que la opción 2 la deberían haber especificado más pues dependiendo del grado de contacto con la arteria y el tipo de arteria sería resecable o no. Además, la respuesta 3 también debería especificarse un poco más aunque ya remarcan afectación FOCAL de la v. mesentérica superior, con tan solo esa información no podemos deducir si es una infiltración reconstruible o no. Por ello esta pregunta podría ser impugnable y anulable. Por último, no hay que hacer biopsia ante un tumor que va ser operado, sino que la biopsia se realiza en un paciente con metástasis que va a ir a quimioterapia. Por ello, la 4 es falsa y es la que dieron como correcta.

149. En la microangiopatía trombótica familiar por alteración de la vía alterna del complemento, esperaríamos encontrar todas las siguientes características, EXCEPTO:

1. Trombocitosis.
2. Insuficiencia renal con microtrombos en capilares glomerulares en la biopsia renal.
3. Hipertensión arterial.
4. Hematuria y proteinuria no nefróticas.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Todos los síndromes de microangiopatía trombótica cursan con una triada común de trombopenia por consumo (respuesta 1 falsa, por tanto CORRECTA), anemia hemolítica microangiopática (con Coombs negativo y con presencia de esquistocitos en el frotis) y fracaso renal agudo (en ocasiones por la inflamación glomerular inducida por la isquemia aparecen datos de síndrome nefrítico con HTA, hematuria y proteinuria).

150. Una mujer de 24 años, primigesta, sufre un aborto espontáneo a las 7 semanas de gestación. El estudio anatomopatológico de los restos abortivos indica enfermedad molar. Le debemos informar que:

1. El riesgo de una nueva gestación molar en un futuro embarazo es del 50%.
2. No debe quedar embarazada hasta realizar controles periódicos y haber pasado un año con niveles de beta-HCG negativos.
3. No es necesario realizar controles posteriores si la evacuación del tejido trofoblástico fue completa.
4. Es necesario que se realice controles periódicos ya que en el 40 % de los casos desarrollará una neoplasia trofoblástica gestacional.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

A toda paciente tratada de mola hidatiforme, tras realizarse un legrado por aspiración, debe hacerse un control de b-HCG durante un año (a todas se les debe realizar extirpación completa del tejido trofoblástico mediante legrado por aspiración). Así, debemos asegurarnos de que la paciente no vuelve a quedar embarazada durante el siguiente año, pues el embarazo elevaría los niveles de beta-HCG y no permitiría un buen control de los mismos -respuesta 2 correcta-.

151. Un hombre de 60 años de edad con colitis ulcerosa extensa de 15 años de evolución y en remisión clínica los últimos 3 años, acude a nuestra consulta para informarse sobre el riesgo de cáncer colorrectal y sobre la posibilidad de participar en programas de prevención. Es correcto informarle que:

1. La colitis ulcerosa solo se asocia a un incremento en el riesgo de cáncer colorrectal en fumadores.
2. En su caso, dado que está en remisión de larga duración, se considera adecuado el cribado aconsejado a la población general.
3. En casos como el suyo se considera adecuado someterse a colonoscopias periódicas con toma de múltiples biopsias escalonadas a lo largo de

todo el colon.

4. En casos como el suyo se considera adecuado el cribado mediante estudios periódicos de sangre oculta en heces pero con una frecuencia superior a la utilizada en el cribado de la población general.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El cribado de cáncer colorrectal (CCR) está indicado a partir de los 8 años del debut en un paciente con colitis ulcerosa (este paciente debutó hace 15 años). El riesgo de CCR viene determinado por los factores de riesgo siguientes (opción 1 falsa): colitis extensa, pseudopólipos, actividad endoscópica o histológica y antecedentes familiares de CCR y presencia de CEP asociada. La remisión clínica no exime del cribado aunque sí que es un factor de buen pronóstico. La técnica de cribado de elección es la colonoscopia con cromosondoscopia y biopsias dirigidas aunque esta opción no constaba en el MIR y solo constaba lo que se hacía anteriormente que es la colonoscopia con biopsias escalonadas al azar (opción 3 es la más correcta pero no perfecta). La opción 4 es incorrecta pues el cribado con test de sangre oculta en heces solo está indicado en población general asintomática sin antecedentes familiares de cáncer ni enfermedad inflamatoria.

152. En relación al trasplante hepático, señale de las siguientes la respuesta CORRECTA:

1. La indicación de trasplante hepático más frecuente en la actualidad es la cirrosis por infección del virus B (VHB).
2. Las metástasis hepáticas por cáncer de colon constituyen una indicación aprobada para trasplante hepático.
3. El sistema MELD es un modelo pronóstico que permite la priorización para el trasplante hepático de los enfermos en lista.
4. El trasplante hepático sería la mejor opción de tratamiento para un paciente de 45 años con un hepatocarcinoma difuso.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La causa más frecuente de TH en adultos en nuestro medio es el VHC (respuesta 1 incorrecta). Entre las contraindicaciones absolutas más importantes que debemos recordar, está el diagnóstico de cualquier neoplasia previa en menos de 2-5 años o con alta probabilidad de recidiva (excepto para el cáncer de piel no melanoma) por lo que las metástasis del cáncer de colon no suponen una indicación actual. Las únicas metástasis que pueden ser candidatas a valorar un TH son los tumores neuroendocrinos carcinoides, siempre que se erradique el tumor primario y las metástasis sólo afecten al hígado (respuesta 2 incorrecta). Por otro lado, de forma general, los pacientes con hepatocarcinoma difuso (refiriéndose a tumor que supere a Milán) recibirán

tratamiento mediante quimiembolización y los que presenten afectación extrahepática (adenopatías, metástasis o invasión vascular) serán tratados con Sorafenib, por lo que la respuesta 4 es incorrecta. El sistema de puntuación MELD clasifica a los pacientes en función de su gravedad y sirve para asignar un puesto en la lista de espera de TH (respuesta 3 correcta). Sobre el MELD, es importante recordar que a partir de un MELD > 15 se debe valorar el TH, que su puntuación varía entre 6 y 40 puntos y que para su determinación se utilizan variables objetivas: creatinina sérica, bilirrubina e INR.

153. Mujer de 73 años de edad que ingresa por cuadro de disnea progresiva hasta hacerse de reposo, ortopnea y aumento de 4 kg de peso. En la exploración física se aprecia presión arterial de 150/84 mm Hg, frecuencia cardíaca 100 latidos/minuto, aumento de la presión venosa yugular, crepitantes en ambas bases y edemas maleolares. Tratamiento habitual: enalapril 5 mg cada 12 horas, furosemida 80 mg al día. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado en este momento?:

1. Administrar furosemida por vía intravenosa.
2. Aumentar dosis de enalapril según tolerancia y administrar furosemida por vía intravenosa.
3. Iniciar un beta-bloqueante.
4. Añadir tratamiento con amlodipino.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos exponen un caso clínico muy claro de descompensación grave de insuficiencia cardíaca, que requiere ingreso hospitalario, aunque sin llegar al extremo del edema agudo de pulmón. La clave para responder la pregunta es recordar que los beta-bloqueantes están contraindicados en insuficiencia cardíaca aguda grave por su efecto inotrope negativo. Por lo demás, deberemos administrar furosemida i.v. para aliviar la congestión, y aumentar la dosis de enalapril, dado que la paciente está hipertensa (posible causa de descompensación de la insuficiencia cardíaca), y además debemos llegar a la máxima dosis que tolere la paciente para mejorar el pronóstico. En ninguna respuesta nos dan la opción de poner nitroglicerina intravenosa; no se trata de un caso florido de edema agudo de pulmón, pero quizá podría haber sido interesante administrarla al menos en las horas iniciales, hasta estabilizar el cuadro clínico.

154. Una paciente de 70 años ingresa en UCI tras sufrir IAM anterior tratado mediante angioplastia coronaria y colocación de stent en la arteria descendente anterior. 4 días después presenta bruscamente hipotensión que obliga a aporte vigoroso de volumen, inicio de drogas vasoactivas, intubación orotraqueal y conexión a la ventilación mecánica. A la exploración física destaca un soplo no presente previamente. Ante la sospecha de complicación mecánica del infarto, se realiza ecocardiografía transtorácica que muestra derrame pericárdico. Señale la Respuesta CORRECTA:

1. La mortalidad con tratamiento médico es del 20%.
2. En caso de rotura de pared libre hay salto oximétrico en el ventrículo derecho en el cateterismo de Swan-Ganz.
3. En caso de rotura de pared libre no hay frémito palpable.
4. Las complicaciones mecánicas suelen aparecer en el primer día postinfarto.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Caso clínico de una rotura de pared libre cardíaca, la complicación mecánica más grave del IAM. Las complicaciones mecánicas suelen aparecer tras las primeras 24h del infarto, cuando el paciente ya está en situación estable, y cursan con una inestabilización brusca. En el caso que nos presentan, el ecocardiograma (prueba de elección ante la sospecha de complicación mecánica) muestra derrame pericárdico, y eso es diagnóstico de rotura de pared libre. El caso clínico, no obstante, daba igual para contestar la pregunta, dado que las opciones son teóricas. La mortalidad de la rotura de pared libre supera el 90%, independientemente del tratamiento. El salto oximétrico se da en la rotura de septo interventricular (CIV), no en la rotura de pared libre. Por último, la correcta es la 3. Como hay taponamiento cardíaco, al palpar la punta del corazón no notamos frémito porque el derrame pericárdico “amortigua” el latido de la punta.

155. Una mujer de 35 años consulta por un nódulo tiroideo derecho detectado incidentalmente una mañana al observarse en el espejo un bulto en la cara anterior del cuello. Tras los estudios pertinentes se decide intervenir quirúrgicamente a la paciente realizándose una tiroidectomía total con vaciamiento del componente ganglionar central, siendo el informe del patólogo de nódulo tiroideo de 2,3 cm ocupado en su totalidad por un carcinoma papilar de tiroides, variante células altas, sin infiltración vascular pero sí capsular. Las concentraciones de tiroglobulina 24 h después de la tiroidectomía son de 14 ng/mL. ¿Cuál sería el siguiente paso que usted daría en esta paciente?:

1. Remitir de nuevo a la paciente al cirujano para que realice un vaciamiento ganglionar laterocervical derecho.
2. Iniciar tratamiento con una dosis de levotiroxina supresora de TSH y citarla a revisión 6 meses después con una nueva determinación analítica de tiroglobulina y una ecografía cervical.
3. Solicitar un PET-TAC para ver si hay afectación ganglionar.
4. Demorar el inicio del tratamiento sustitutivo supresor de TSH con levotiroxina y remitir la paciente al servicio de Medicina Nuclear para la administración de una dosis ablativa de 100 mCi de I131.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

El tratamiento de los carcinomas diferenciados del epitelio folicular (neoplasias papilares y foliculares) incluye cirugía (tiroidectomía total +/- linfadenectomía); ablación con radioyodo; y levotiroxina a dosis supresoras. Si bien la ablación con radioyodo puede evitarse en los pacientes con bajo riesgo de recidiva, la variante de células altas, la persistencia de tiroglobulina postcirugía, y la invasión capsular son factores de mal pronóstico. Entre las opciones de la pregunta, la T4 a dosis supresoras sin radioyodo (opción 2) es incompleta, y por tanto falsa. Para que la ablación con radioyodo sea efectiva, debe realizarse con niveles elevados de TSH (aumenta la captación del yodo radioactivo), por lo que habitualmente se retrasa el inicio de la levotiroxina hasta la realización de la ablación (opción 4 correcta).

156. Un paciente con gastroenteritis por Salmonella, acude a la consulta. El paciente está deshidratado. ¿Qué tratamiento le darías, sabiendo que, previamente, el paciente no tenía ninguna enfermedad?:

1. Amoxicilina endovenosa.
2. Ciprofloxacino oral.
3. Ceftriaxona intramuscular.
4. Hidratación oral o endovenosa.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Pregunta fácil y directa sobre el tratamiento de una gastroenteritis en paciente adulto sano inmunocompetente: rehidratación. No está indicado el antibiótico, que sí está indicado en algunos casos por el riesgo de infección complicada o metastásica: neonatos (<3 meses), personas >50 años (por el riesgo de placa de ateroma o aneurisma), trasplantados, síndromes linfoproliferativos, infección VIH, prótesis articulares, prótesis vasculares, artropatías, o drepanocitosis.

157. Un chico de 22 años de edad con hiposmia presenta falta de desarrollo de caracteres sexuales secundarios e infertilidad. Volumen testicular de 4 mL bilateral. Analíticamente, FSH 1,2 U/L (vn 5-15); LH 0,6 U/L (vn 3-15); testosterona 100 ng/dL (vn 300-1200), prolactina normal. Señale el tratamiento que le propondrá para conseguir fertilidad:

1. Bomba de infusión de GnRH.
2. Administración intramuscular mensual de triptorelina.
3. Administración intramuscular de FSH y LH una vez por semana.
4. Tratamiento con bromocriptina.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta polémica por existir dos opciones potencialmente

correctas. El tratamiento del varón con hipogonadismo secundario (hipogonadotropo) se basa en el uso de testosterona. Además, si el paciente tiene deseo genésico, debe estimularse la espermatogénesis testicular. Para ello hay dos opciones: administración de gonadotropinas o de GnRH. En los pacientes con hipogonadismo hipotalámico como el síndrome de Kallman, la administración de GnRH es más fisiológica y consigue mejores resultados. Además, las gonadotropinas (FSH/LH o hCG) se deben administrar tres veces por semana.

158. Mientras realiza la anamnesis a un paciente que consulta por dolor torácico en un Servicio de Urgencias, éste pierde la conciencia, usted le estimula y no responde, le abre la vía aérea y comprueba que el paciente no respira y no le encuentra el pulso carotídeo. Tras pedir ayuda, ¿cuál es la siguiente maniobra que debería realizar?:

1. Compresiones torácicas.
2. Golpe precordial.
3. Ventilaciones de rescate.
4. Intubación oro-traqueal.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta fácil sobre resucitación cardiopulmonar. Tras comprobar que el paciente no responde, se abre la vía aérea y se observa si respira. Si respira, se le coloca en posición de seguridad y se pide ayuda. Si no respira, se pide ayuda (y un desfibrilador) y se comienza con RCP básica con prioridad de las compresiones respecto al las ventilaciones.

159. El médico de guardia solicita al banco de sangre hemoderivados para un paciente politraumatizado del grupo A+. Si no se dispusiera de este, ¿cuál de los siguientes sería el tratamiento alternativo más correcto?:

1. Concentrado de hematíes del grupo AB+ y plasma AB.
2. Concentrado de hematíes del grupo B+ y plasma AB.
3. Concentrado de hematíes del grupo 0+ y plasma AB.
4. Concentrado de hematíes del grupo B+ y plasma B.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta de respuesta inmediata si recuerdas que el donante universal de concentrados de HEMATÍES es el grupo 0 y el donante universal de PLASMA es el grupo AB (opción 3 correcta).

160. Paciente de 35 años que, debido a hematemesis por ulcus, recibe una transfusión de 2 concentrados de hematíes. A los 5-10 minutos

de iniciarse la transfusión comienza con fiebre, escalofríos, hipotensión y dolor en región lumbar. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable?:

1. Contaminación bacteriana de la sangre.
2. Reacción febril secundaria a la transfusión.
3. Reacción febril por el plasma que contamina los hematíes.
4. Reacción transfusional hemolítica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Caso clínico típico de una reacción transfusional hemolítica aguda (opción 4 verdadera): cuadro de comienzo brusco, a los pocos minutos del inicio de la trasfusión y con poco volumen. Cursa con calor, fiebre, escalofríos, vómitos, dolor retroesternal y lumbar, hipotensión y disnea. Es secundaria a incompatibilidad ABO: presencia de anticuerpos en el plasma del receptor frente a los antígenos de los eritrocitos trasfundidos que desencadenan una hemólisis intravascular. En esta situación se debe interrumpir inmediatamente la trasfusión, comprobar que no existe un error de identificación entre la bolsa y el paciente e instaurar un tratamiento de soporte con el objetivo de prevenir el fracaso renal y la hipotensión.

161. Mujer de 46 años con antecedentes de valvulopatía reumática, que precisa sustitución valvular mitral por una prótesis mecánica. La evolución postoperatoria inicial es favorable. Sin embargo, tras comenzar tratamiento con acenocumarol desarrolla un cuadro de necrosis cutánea afectando región abdominal y extremidades. ¿Cuál de las siguientes alteraciones justificaría este cuadro?:

1. Deficiencia de antitrombina.
2. Factor V Leiden.
3. Hiperhomocisteinemia.
4. Deficiencia de proteína C.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La necrosis cutánea inducida por acenocumarol es una complicación grave y poco común de la terapia anticoagulante. Se asocia a trastornos de hipercoagulabilidad como el déficit de proteína C y/o S (opción 4 correcta). La fisiopatología no está del todo clara pero se postula que al iniciar tratamiento con acenocumarol en un paciente con déficit de proteína C y/o S se produce un desequilibrio en la cascada de la coagulación con un descenso rápido del factor VII y de la proteína C. De este modo se promueve la trombosis de la microvasculatura cutánea y la necrosis. El tratamiento de este cuadro es fundamentalmente de soporte

e incluye la suspensión inmediata del acenocumarol y el uso de plasma fresco congelado, vitamina K y anticoagulación con heparina no fraccionada o de bajo peso molecular.

162. Un paciente consulta por latido vascular cervical prominente. Al auscultarle se escucha un soplo diastólico de alta frecuencia. ¿Cuál es la causa?:

1. Ductus persistente.
2. Disfunción músculo papilar.
3. Estenosis mitral.
4. Insuficiencia aórtica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla sobre la semiología de las valvulopatías. El paciente tiene soplo diastólico y pulso prominente (pulso “hiperdinámico”), lo cual es compatible, de las cardiopatías que nos presentan, con una insuficiencia aórtica. El ductus arterioso persistente daría soplo continuo “en maquinaria”; la disfunción de músculo papilar produce insuficiencia mitral, que tendría a la auscultación un soplo sistólico; por último, la estenosis mitral tiene un soplo diastólico pero de baja frecuencia (se ausculta mejor con la campana del fonendoscopio), y el pulso no es hiperdinámico.

163. ¿Cuál de las siguientes técnicas de endoscopia digestiva, está asociada a mayor riesgo de complicaciones mayores?:

1. Ecoendoscopia digestiva alta diagnóstica.
2. Esclerosis de varices esofágicas.
3. Colonoscopia diagnóstica en paciente con dolícolon.
4. Polipectomía de pólipo en colon descendente de morfología sésil.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Las técnicas que se asocian a menos complicaciones son las diagnósticas y por ello ya podemos descartar la ecoendoscopia y la colonoscopia diagnóstica. De entre las técnicas endoscópicas terapéuticas (opción 2 y 4) la que tiene más complicaciones es la esclerosis de las varices. La polipectomía puede complicarse en forma de hemorragia (<5%) o perforación (1/1000) especialmente si los pólipos son de gran tamaño y planos y situados en el colon derecho. Aunque esta pregunta podría ser impugnada porque no consta el tamaño del pólipo, dado que nos dicen que es sésil y en colon izquierdo podemos deducir que el riesgo es bajo. En cambio, la escleroterapia de las varices esofágicas ha sido sustituida por la ligadura con bandas como terapéutica de la hemorragia por varices por su elevado riesgo de complicaciones y menor eficacia. La esclerosis de varices

tiene una tasa de complicación de 35%-78% (ulceración, hemorragia, estenosis, perforación), con una mortalidad de 1%-5%; así que la opción correcta es la 2.

164. ¿Cuál de los siguientes síntomas asociados con la hipertensión arterial tiene peor pronóstico?:

1. Pérdida brusca de fuerza de pierna y brazo derechos de 10 minutos de duración.
2. Epistaxis de 30 minutos de duración.
3. Cefalea nual vespertina.
4. Taquicardia y temblor.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta que se puede contestar con un poco de sentido común. Nos ponen presentaciones clínicas posibles de un paciente hipertenso. La opción 4 es muy inespecífica y podría estar en contexto con una crisis hipertensiva, pero también con una crisis de ansiedad. La opción 3 es una de las manifestaciones clínicas habituales de la hipertensión arterial mal controlada (cefalea). La opción 2 también puede ser indicativa de crisis hipertensiva, o de hipertensión arterial con mal control. Y, por último, la opción 1 indica que el paciente está teniendo un ictus (o al menos un AIT) y por tanto es la que implica un peor pronóstico.

165. Una chica de 18 años sufre una pérdida de conciencia al regresar a su domicilio tras una noche de fiesta sin dormir. Ha notado un breve mareo, la han visto pálida y se ha caído. Ha tenido convulsiones durante unos 10 segundos y se ha orinado. Se recupera en menos de un minuto, orientada y consciente de la situación. Vomita. Cuenta que el año anterior tuvo un cuadro similar. ¿Si usted la atendiera en urgencias, cuál le parece la actitud más adecuada?:

1. Pensar en síncope vasovagal y dar el alta.
2. Solicitar un TAC craneal e iniciar tratamiento antiepiléptico.
3. Solicitar analítica y remitirla a consulta del neurólogo.
4. Pensar en intoxicación etílica aguda, hacer TAC craneal y punción lumbar y administrar tiamina IV.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos presentan un caso clínico típico de síncope vasovagal. Paciente joven que, tras una situación típica (depresión de sueño; otras serían después de comer, en ambientes con aglomeraciones y mucho calor, con la micción, con la tos...), tiene un síncope precedido por pródromos (sensación de mareo) y recuperación rápida posterior. En este caso, si la exploración física es normal y el ECG también es normal (no nos dan la opción de hacer un ECG), se puede diagnosticar de síncope vasovagal (cuyo diagnóstico es clínico) y dar de alta con recomendaciones para evitar los síncope (tumbarse

y poner las piernas en alto si nota los pródromos, y evitar las situaciones desencadenantes si es que las hay).

166. La existencia de hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina es típica en los pacientes con:

1. Poliposis adenomatosa familiar.
2. Síndrome de Peutz-Jeghers.
3. Síndrome de Cronkhite-Canada.
4. Síndrome de Cowden.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sobre las manifestaciones extraintestinales de los síndrome polipósicos. Recordad que el más frecuente de ellos es la poliposis adenomatosa familiar (y sus variantes fenotípicas síndrome de Gardner y de Turcot) donde es típico la hipertrofia del epitelio pigmentario de la retina en el fondo de ojo. Las opciones 2 y 4 son síndromes más raros que se caracterizan por poliposis de tipo hamartomatosos. La opción 3 es el único síndrome polipósico esporádico / no hereditario (a diferencia de los otros tres) y así fue preguntado previamente en el MIR.

167. Un hombre de 67 años, diagnosticado de cirrosis hepática y bebedor activo, ingresa por cuadro de distensión abdominal progresiva con malestar difuso, de dos semanas de evolución. No refiere fiebre ni otros síntomas. A la exploración destaca matidez cambiante a la percusión abdominal, con ausencia de edemas. Se realiza una paracentesis diagnóstica, encontrando un líquido ligeramente turbio, con 2300 células/mL, de las cuales 30% son linfocitos, 60% polimorfonucleares y 10% hematíes. ¿Cuál es la primera medida terapéutica que pautaría en este paciente de forma inmediata?:

1. Restricción de sal y líquidos.
2. Tratamiento diurético con espironolactona oral.
3. Tratamiento con una cefalosporina de tercera generación.
4. Paracentesis evacuadora.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se trata de un paciente con cirrosis hepática que presenta una descompensación en forma de ascitis (distensión abdominal y matidez cambiante a la exploración física) que además está infectada ya que tiene más de 250 PMN (líquido turbio, leucocitos de 2300 con 60% PMN). En la peritonitis bacteriana espontánea (PBE) el control de la ascitis es secundario pues los diuréticos y las paracentesis de grandes volúmenes pueden provocar insuficiencia renal si ya tiene PBE. Así, en este paciente lo más importante es iniciar ceftriaxona i.v. También estaría indicado iniciar albúmina i.v para evitar el síndrome hepatorenal aunque actualmente se piensa que habría pacientes con cirrosis poco

avanzada que no es necesario y por ello seguramente no lo han incluido en la respuesta. Sólo cuando la PBE se cure iniciaremos el tratamiento de la ascitis.

168. En qué tipo de tumor óseo maligno existe una translocación cromosómica 11/22t en más del 90% de los casos:

1. Osteosarcoma.
2. Mieloma.
3. Sarcoma de Ewing.
4. Condrosarcoma.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta típica del sarcoma de Ewing, preguntada ya hace más de 10 años en la que nos piden indicar la translocación asociada a este sarcoma: t11/22.

169. Un paciente de 64 años de edad, agricultor, exfumador (5 años), EPOC y afecto de artritis reumatoide en tratamiento corticoideo. Consulta en urgencias por presentar cefalea intensa de 2 días de evolución con desviación de comisura bucal. Como antecedente, relata que tras cuadro gripal hace un mes, persiste tos, expectoración purulenta y ocasionalmente hemoptoica, febrícula, anorexia, astenia y pérdida de peso. A su llegada se aprecia la existencia de fiebre de 38.2°C, abscesos cutáneos múltiples en manos, espalda y nalgas (algunos con trayectos fistulosos) y parálisis facial central derecha, infiltrados apicales con pequeño derrame pleural asociado en la radiografía de tórax y leucocitosis con neutrofilia. Entre los siguientes diagnósticos de sospecha consideraría MÁS probable:

1. Neoplasia pulmonar con metástasis cerebrales.
2. Tuberculosis diseminada.
3. Nocardiosis.
4. Aspergilosis.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos presentan un paciente inmunodeprimido (tratamiento corticoideo crónico) que presenta un cuadro constitucional (anorexia, astenia, pérdida de peso) con fiebre y que como focalidad presenta síntomas respiratorios larvados de varias semanas (tos y expectoración purulenta), una cefalea con focalidad neurológica (parálisis facial) y además abscesos cutáneos. Con el dato de los abscesos cutáneos es fácil pensar en que la clínica neurológica puede responder a un absceso cerebral y si lo ligamos todo con el antecedente profesional (agricultor, contacto con la tierra y el suelo) surge la posibilidad de la nocardiosis, que en este caso presenta manifestación pulmonar inespecífica en forma de infiltrado apical asociada a manifestaciones cutáneas y cerebrales. Un tumor pulmonar diseminado no produciría fiebre ni leucocitosis. La duda más razonable de un cuadro constitucional con fiebre y síntomas respiratorios estaría con

la tuberculosis diseminada. En este caso la clave para ir a por la Nocardia y desechar la tuberculosis son los abscesos cutáneos y el antecedente laboral, ya que Nocardia es un microorganismo saprofítico ubicuo que se encuentra en el suelo, en la materia orgánica (sobre todo en descomposición) y en el agua, y se adquiere bien por inhalación o por inoculación a través de la piel.

170. Mujer de 72 años que acude al hospital por dolor torácico opresivo de 2 horas de evolución. La presión arterial es de 68/32 mm Hg, la frecuencia cardíaca es de 124 latidos/min, la frecuencia respiratoria es de 32 respiraciones/min, la saturación de oxígeno del 91% con oxígeno al 50%. A la auscultación pulmonar se aprecian crepitantes bilaterales. Se realiza un ECG que muestra lesión subepicárdica en cara anterior, con imagen especular en cara inferior. En la radiografía de tórax se aprecia patrón alveolar bilateral. ¿Cuál es su decisión terapéutica?:

1. Iniciar infusión de nitratos i.v.
2. Realizar fibrinólisis con tenecteplase (TNK).
3. Realizar angioplastia coronaria urgente.
4. Administrar furosemida 40 mg i.v.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Una de las preguntas más fáciles del MIR. Mujer con clínica anginosa y elevación del ST en ECG (lesión subepicárdica). Se trata de un SCACEST, cuyo manejo prioritario es la reperusión urgente, siendo de elección la angioplastia primaria (opción 3 correcta) sobre la fibrinólisis.

171. En un paciente hospitalizado que no es capaz de alimentarse por vía oral durante más de 6 días, ¿en cuál de las situaciones clínicas siguientes hemos de usar necesariamente nutrición parenteral?:

1. Ictus cardioembólico con disfagia neurológica completa.
2. Caquexia por empiema crónico en paciente inmunodeprimido.
3. Íleo paralítico prolongado.
4. Enfermedad de Alzheimer avanzada con grave riesgo de broncoaspiración.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La incapacidad para la alimentación por vía oral durante más de 5-7 días es indicación de nutrición artificial. Siempre que sea posible, la nutrición enteral es de elección sobre la parenteral, ya que es más fisiológica y tiene menos complicaciones. La nutrición parenteral está indicada por tanto cuando se necesita una nutrición artificial y existen contraindicaciones para la vía enteral, que en esencia son limitaciones para la utilización del tracto digestivo. La pregunta, por tanto, puede traducirse en ¿cuál de las siguientes es contraindicación para la nutrición enteral? Ni

las demencias, ni las disfagias neurógenas, ni la caquexia contraindican el uso del aparato digestivo, por lo que la nutrición enteral sería de elección. El íleo paralítico prolongado supone, por tanto, la única indicación para recurrir la nutrición parenteral.

172. Mujer diagnosticada de diabetes mellitus tipo 1 desde hace 24 años. Acude a consulta con clínica de 3 meses de evolución de hormigueos en ambos pies, con distribución en calcetín, con dolor parestésico y sensación de pies calientes de predominio nocturno, que interfiere notablemente su sueño. ¿Cuál de los siguientes fármacos utilizaría en primera línea para el tratamiento de su patología?:

1. Ibuprofeno.
2. Oxiconona.
3. Duloxetina.
4. Paracetamol.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El tratamiento de la neuropatía diabética, en caso de existir dolor, se realiza con antidepresivos como primera elección. En la pregunta nos ofrecen utilizar duloxetina (inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina), aunque clásicamente se ha utilizado amitriptilina (tricíclico). También se pueden usar de segunda línea otros neuromoduladores como gabapentina o pregabalina.

173. Señale de entre las siguientes la complicación más probable que presenta el paciente intervenido, hace 20 años, de úlcera gástrica mediante antrectomía y gastroyeyunostomía (Billroth II) que acude a su consulta refiriendo dolor abdominal postprandial, distensión abdominal, diarrea y datos analíticos de malabsorción de grasas y de vitamina B12:

1. Gastropatía por reflujo biliar.
2. Adenocarcinoma gástrico.
3. Síndrome de evacuación gástrica rápida (dumping).
4. Síndrome de asa aferente con sobrecrecimiento bacteriano.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de un paciente gastrectomizado que tiene dolor abdominal tras la ingesta lo que debe hacernos pensar en un síndrome de asa aferente, sin embargo para que el cuadro fuera típico deberían decirnos que mejora tras el vómito. Por otro lado, nos dan datos que hacen pensar que existe sobrecrecimiento bacteriano como son malabsorción de grasas y déficit de vitamina B12.

174. En un ensayo clínico se evalúa la no inferioridad del forbuterol frente a serbuterol, siendo la variable principal del estudio el volumen

espiratorio forzado en el primer segundo (VEF1, medido en litros). El límite de no inferioridad se establece en -0,18 litros de diferencia absoluta. Los resultados muestran una diferencia en VEF1 entre forbuterol y serbuterol de +0,26 litros (intervalo de confianza al 95%: -0,15 a +0,40). Señale la respuesta correcta:

1. Forbuterol es no inferior a serbuterol.
2. Serbuterol es no inferior a forbuterol.
3. Forbuterol es no inferior a serbuterol y también superior, porque mejora en 0,26 litros el VEF1.
4. El estudio no es concluyente en cuanto a demostrar la no inferioridad de forbuterol.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sobre análisis de no inferioridad, utilizando como medida de efecto una medida absolutas. En el enunciado os indican cuál será el valor de no significación estadística para la hipótesis de no inferioridad (-0,18); si hubiera sido un estudio de superioridad, el valor de no significación es por definición el 0 para medidas absolutas. Al estar nuestro IC totalmente por encima del valor de no significación, nuestros resultados son significativos (aceptamos la hipótesis alternativa), luego concluimos que forbuterol es no-inferior a serbuterol.

175. ¿Qué se entiende por eficiencia de un servicio sanitario?:

1. La medida en que un servicio sanitario mejora el estado de salud de la población al menor coste posible.
2. La posibilidad que un sujeto tiene de ser atendido por el sistema sanitario independientemente de su condición social, sexo o lugar de nacimiento.
3. La mejora del estado de salud de la población obtenida por un servicio sanitario en condiciones habituales o reales de actuación.
4. La medida en que un servicio sanitario alcanza sus objetivos de mejora del estado de salud de la población a la cual atiende.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Recordad estos tres conceptos que ya han sido preguntados en varias ocasiones en MIR previos: - Eficacia: son los resultados obtenidos en condiciones ideales. - Efectividad: son los resultados obtenidos en condiciones reales. - Eficiencia: es un concepto económico. Es la valoración de los efectos obtenidos en el programa según los recursos económicos invertidos (respuesta 1 correcta).

176. Hombre de 51 años que es ingresado desde Urgencias por anemia macrocítica (Hb 6,3 g/dL, VCM 120 fL). En los estudios realizados se descarta un origen carencial. Los reticulocitos son de 24000/microL. El estudio de médula ósea es compatible con un síndrome mielodisplásico

(SMD). La citogenética muestra una delección en 5q. ¿Cuál es la afirmación correcta en relación a este paciente?:

1. Esta delección (5q-) es una alteración de buen pronóstico y tiene un tratamiento específico (la lenalidomida).
2. Lo recomendable en este paciente sería realizar tipajes HLA para organizar un trasplante alogénico.
3. Se trata de un paciente con un Índice Internacional de Pronóstico (IPSS) alto.
4. El tratamiento en este caso serían las transfusiones únicamente.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Anemia macrocítica secundaria a síndrome mielodisplásico (SMD) con delección en 5q. Se trata de un SMD de buen pronóstico (opción 3 falsa) dado que tiene un tratamiento específico (la lenalidomida) (opción 1 verdadera, opción 2 y 4 falsas). Recuerda además que suele ser más frecuente en mujeres y que cursa habitualmente con anemia macrocítica y trombocitosis.

177. Joven de 18 años de edad con antecedentes de asma, alergia a pólenes, ácaros y pelo de gato, acude a urgencia refiriendo sensación de detención de alimentos a nivel retroesternal con práctica incapacidad para deglutir su propia saliva. Refiere episodios similares en otras ocasiones que han cedido de forma espontánea en pocos minutos. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?:

1. Esófago de Barrett.
2. Anillo esofágico distal (Schatzki).
3. Esofagitis infecciosa.
4. Esofagitis eosinofílica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Varón joven con antecedentes de atopía que presenta disfagia intermitente es claramente esofagitis eosinofílica. El esófago de Barrett sería en un paciente con reflujo de larga evolución y en general no provoca disfagia. El anillo de Schatzki provoca disfagia intermitente pero se asocia a pirosis y no a atopía. La esofagitis infecciosa es una enfermedad más infrecuente que puede dar disfagia, fiebre, odinofagia o dolor torácico.

178. Señale la respuesta FALSA de entre las siguientes en relación con el concepto de gastritis:

1. Es un término que debe reservarse para la definir la existencia de inflamación histológica en la mucosa gástrica.
2. Existe un espectro de manifestaciones clínicas claramente definidas en relación con la existencia de gastritis.

3. El *Helicobacter pylori* es una causa frecuente de gastritis.
4. Existe una escasa correlación entre los datos histológicos, los síntomas del paciente y los datos endoscópicos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica generalmente provocada por *Helicobacter pylori* y cuyo diagnóstico tan solo se puede hacer mediante histología. Generalmente es asintomática, de hecho, normalmente es un hallazgo endoscópico por lo que no tiene unas manifestaciones clínicas definidas ni existe correlación clínica con histología (opción 2 falsa y opción 4 correcta).

179. Un hombre de 52 años sin enfermedades concomitantes, acude a urgencias por melenas de 24 horas de evolución sin repercusión hemodinámica. Niega consumo de antiinflamatorios no esteroideos. El hematocrito es de 33% y el resto de la analítica es normal. La endoscopia digestiva alta realizada de forma urgente a las 6 horas del ingreso muestra un estómago normal, sin sangre ni restos hemáticos y una úlcera excavada de 8 mm de diámetro en cara anterior del bulbo duodenal con "vaso visible" en su base y sin sangrado activo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:

1. En la endoscopia inicial está indicado aplicar una terapéutica endoscópica y posteriormente instaurar tratamiento endovenoso con dosis altas de un inhibidor de la bomba de protones. Esta estrategia ha demostrado reducir el riesgo de recidiva hemorrágica y la mortalidad.
2. En la endoscopia inicial, dada la ausencia de sangrado activo, no está indicado aplicar una terapéutica endoscópica. Posteriormente, para reducir el riesgo de recidiva hemorrágica, se deberá instaurar tratamiento endovenoso con dosis altas de un inhibidor de la bomba de protones.
3. En la endoscopia inicial está indicado aplicar una terapéutica endoscópica. No se ha podido demostrar que instaurar posteriormente tratamiento endovenoso con dosis altas de un inhibidor de la bomba de protones aporte beneficio adicional alguno.
4. Dado que se trata de una úlcera complicada (hemorragia) la mejor opción terapéutica una vez resuelto el episodio hemorrágico, es una vagotomía y piloroplastia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Paciente con hemorragia digestiva alta secundaria a úlcera duodenal con vaso visible (Forrest IIa) por lo que está indicado el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones endovenoso (ha demostrado mejorar los estigmas endoscópicos) y tratamiento endoscópico. La opción 1 es

la más correcta aunque para ser perfecta debería poner mantener el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones ya iniciados a la llegada del paciente en lugar de instaurarlos.

180. Hombre de 60 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial y dislipemia ha sido recientemente diagnosticado de insuficiencia cardíaca. Tras realizar las pruebas pertinentes se objetiva que conserva la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (>50%). En relación al tratamiento señale la respuesta INCORRECTA:

1. El tratamiento inicial debería dirigirse al proceso patológico subyacente.
2. El tratamiento con diuréticos debe iniciarse a dosis altas.
3. En caso de precisar tratamiento con nitratos debe iniciarse a dosis bajas.
4. La disnea puede tratarse reduciendo la activación neurohormonal con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o antagonistas de los receptores de la angiotensina.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta teórica sobre el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. No existe ningún fármaco que haya demostrado mejorar el pronóstico, por lo que el tratamiento es exclusivamente sintomático asociando un inotropeo negativo (beta-bloqueante o calcio-antagonista no dihidropiridínico) con diuréticos a dosis baja. Los fármacos que bajan la precarga (como los diuréticos, o los nitratos si es que el paciente los necesita por otra causa) deben iniciarse a dosis baja para evitar descensos bruscos de precarga que reduzcan el gasto cardíaco. Como el paciente es hipertenso, debemos normalizar las cifras de PA para reducir con ello la postcarga y mejorar la clínica; cualquier antihipertensivo valdría (nos ofrecen IECA o ARA-II, que son opciones correctas).

181. Paciente de 65 años que presenta disnea progresiva de 5 días de evolución hasta hacerse de reposo, ortopnea de tres almohadas y episodios de disnea paroxística nocturna. A la auscultación destaca crepitantes bilaterales, soplo holosistólico irradiado a axila y ritmo de galope por tercer y cuarto ruido. Señale la afirmación INCORRECTA:

1. El tercer ruido coincide con la fase de llenado rápido de la diástole ventricular del ciclo cardíaco.
2. El diagnóstico más probable es el de insuficiencia cardíaca.
3. El soplo holosistólico puede corresponder a una insuficiencia mitral.
4. El cuarto ruido suele aparecer cuando existe un cierto grado de estenosis valvular.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta un poco farragosa pero que puede sacarse por descarte sin demasiada dificultad. Nos cuentan un caso clínico de insuficiencia cardíaca de libro (disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna y signos de congestión pulmonar a la auscultación), con 3R, 4R y soplo sistólico. En este caso, el soplo sistólico puede ser perfectamente por insuficiencia mitral (puede ser la responsable del caso clínico, o por ejemplo ser una insuficiencia mitral funcional en un paciente con una miocardiopatía dilatada). La opción 1 es teórica y cierta: el 3R coincide con la fase de llenado rápido ventricular (protodiastólico) y el 4R con la contracción auricular (telediastólico). La opción "más falsa" (que debe sacarse por descarte) es la 4. En casos de estenosis mitral puede haber 4R por la contracción auricular vigorosa contra una válvula rígida, pero es excepcional porque el paso de sangre es lento (produce un soplo pero no suele producir un extratono); además, en el caso clínico que nos describen es raro que la paciente, que debuta con 65 años, tenga estenosis mitral asociada (cuya manifestación clínica suele ser más precoz. En este caso, el origen más probable del 4R es la propia insuficiencia cardíaca, que puede presentar en reagudizaciones 3R y 4R de forma inespecífica (4R sobre todo en casos con disfunción diastólica).

182. Nos remiten desde oftalmología a un hombre de 31 años que consultó por pérdida de visión y cefalea progresiva. En la exploración física se constata una hemianopsia temporal y en la resonancia magnética hipofisaria una tumoración de 35 x 30 x 20 mm que comprime quiasma y seno cavernoso. Los resultados del estudio funcional son cortisol 14 microg/dL, TSH 1,4 microU/ mL, T4L 1,2 ng/dL, prolactina 480 microg/L (vn < 15), testosterona 160 ng/dL (vn 300-1200), FSH 1,2 U/L (vn 5-15) y LH 2 U/L (vn 3-15). ¿Cuál es el abordaje terapéutico inicial?:

1. Agonistas dopaminérgicos.
2. Cirugía transesfenoidal.
3. Radioterapia externa o radiocirugía.
4. Tratamiento del hipogonadismo hipogonadotropo con testosterona.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Paciente con macroadenoma hipofisario que se acompaña de síntomas visuales e hipogonadismo. Los niveles de prolactina tan elevados confirman que se trata de un prolactinoma y no de un tumor no funcionante o de otro tipo (son raras las prolactinemias por compresión del tallo hipofisario que superen los 100-150 mcg/L). El tratamiento de los prolactinomas es médico, con agonistas dopaminérgicos siempre, salvo contraindicación, intolerancia o mala respuesta.

183. La fiebre de Chikungunya es una enfermedad aguda transmitida por picadura de mosquito. Es endémica en ciertas áreas de África y Asia.

En los últimos años se han reconocido casos en Europa y América. En relación con ella, conteste la respuesta CORRECTA:

1. El síntoma clínico característico, aparte de la fiebre, es la poliartralgia debilitante.
2. El origen geográfico probable de la enfermedad está en el sur de Asia.
3. El diagnóstico se realiza habitualmente durante la fase virémica mediante PCR.
4. La mortalidad es mayor en adolescentes y jóvenes.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Para responderla sin saber mucho simplemente hay que ir a lo seguro y es que el síntoma principal y diferenciador de esta entidad son las artralgias con patrón poliarticular y que son muy intensas y debilitantes (opción 1 correcta). Tras la remisión del cuadro febril pueden persistir artralgias durante meses en algunos pacientes. Se describió por primera vez durante un brote ocurrido en el sur de Tanzania en 1952 (opción falsa 2) y de hecho su nombre significa literalmente “el que te dobla” en el idioma makonde. Las complicaciones graves no son frecuentes, pero en personas mayores la enfermedad puede contribuir a la muerte (opción 4 falsa). La duda más importante está con la opción 3, que es falsa por dos motivos, primero porque la PCR está disponible en muy pocos centros y el método diagnóstico habitual es la serología, y segundo porque estrictamente hablando la técnica basada en la detección de ácidos nucleicos del virus Chikungunya no es una PCR sino una RT-PCR (reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscriptasa), ya que para la detección de virus RNA hay que “retrotranscribir” primero las hebras de RNA a DNA complementario (para lo que se utiliza la enzima transcriptasa inversa), que luego se amplifica con la técnica PCR tradicional.

184. Señalar el metabolito de la esteroidogénesis suprarrenal de mayor utilidad en el diagnóstico de déficit tardío de 21-hidroxilasa:

1. Pregnenolona.
2. 17-OH-pregnenolona.
3. 17-OH-progesterona.
4. Dehidroepiandrosterona (DHEA).

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El déficit de 21-hidroxilasa supone la causa más frecuente de hiperplasia suprarrenal congénita, y la más frecuentemente preguntada en el MIR. Cursa con déficit de glucocorticoides y, en su forma clásica, con hiperandrogenismo fetal e hipoadosteronismo. Las formas atípicas, más tardías, suelen ser más leves y en ocasiones sólo muestran hiperandrogenismo. El diagnóstico, en cualquier caso, se realiza por medición de 17-OH-progesterona en plasma, un

metabolito intermedio que aumenta como consecuencia del déficit enzimático.

185. Respecto a las vacunaciones infantiles, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

1. Los prematuros deben ser vacunados de acuerdo a su edad corregida.
2. Las vacunas vivas atenuadas están generalmente contraindicadas en los niños inmunodeprimidos.
3. La vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis) está contraindicada en niños con alergia al huevo.
4. Las inmunoglobulinas interfieren con las vacunas inactivadas (muertas).

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Los recién nacidos prematuros deben ser vacunados según su edad cronológica, no su edad corregida. Las vacunas atenuadas, con microorganismo vivos, deben ser contraindicadas en cualquier paciente inmunodeprimido. No existen datos de interferencia entre la administración de inmunoglobulinas y vacunas inactivadas y no hay contraindicación en pacientes alérgicos al huevo para administrar la triple vírica. Opción 2, por tanto, correcta.

186. De los siguientes, ¿cuál se considera en la actualidad el aspecto más importante en la evaluación del abdomen agudo?:

1. Realización de una anamnesis completa y exploración física minuciosa.
2. Valoración del hemograma, especialmente el recuento y fórmula leucocitarios.
3. Valoración de los resultados obtenidos en la ecografía de abdomen.
4. Valoración de los resultados obtenidos en la TC abdominal.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Lo más importante a la hora de evaluar un abdomen agudo (y cualquier otra patología) es la anamnesis y la exploración física. Las pruebas complementarias sólo son una ayuda tras haber hecho una correcta historia clínica.

187. Paciente de 66 años diagnosticado de adenocarcinoma de páncreas estadio IV hace 8 meses. Sigue tratamiento con morfina de liberación retardada 200 mg/12 horas vía oral, ibuprofeno 600 mg/6 horas vía oral, parafina y lactulosa. Desde hace 15 días refiere parestesias y dolor lancinante ocasional en zona lumbar derecha y periumbilical que no cede con ingesta de morfina de rescate. La exploración

neurológica es normal. Señale cuál sería el manejo más apropiado:

1. Realizar tomografía axial computarizada y evaluar compresión nerviosa ya que se trata de dolor neuropático.
2. Valorar tratamiento neurolítico ya que el dolor neuropático es de difícil control.
3. Disminuir la dosis de morfina ya que es ineficaz en este tipo de dolor.
4. Administrar amitriptilina o gabapentina, dexametasona y aumentar la dosis de morfina.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El paciente presenta dolor neuropático típico por las características del dolor que nos cuentan en el enunciado: parestesias, lancinante... Este tipo de dolor se trata con antiepilépticos tipo amitriptilina, gabapentina, pregabalina. La dexametasona puede ayudar a disminuir el edema producido por la misma neoplasia. Asimismo, se puede aumentar la dosis de morfina para conseguir mejor control del dolor de base.

188. Hombre de 49 años que consulta por poliuria y polidipsia intensas y pérdida involuntaria de 10 kg de peso y es diagnosticado de diabetes mellitus por una glucemia plasmática de 322 mg/dL y una hemoglobina glicosilada de 9,8%. Su médico le da recomendaciones dietéticas, la conveniencia de realizar ejercicio físico, e inicia tratamiento con metformina 850 mg/12 horas y glimepirida 6 mg/día. En las semanas siguientes los controles glucémicos se van reduciendo progresivamente. A los 4 meses la glucemia es de 94 mg/dL y la HbA1c de 5,9%. El paciente se queja de episodios frecuentes de mareo, dolor epigástrico, visión borrosa, sudoración y temblor, que mejoran comiendo algo y que ocurren sobre todo al final de la mañana y al final de la tarde. ¿Qué modificación propondría en su tratamiento?:

1. Revisar la distribución de hidratos de carbono de su dieta.
2. Suspender la metformina.
3. Suspender la sulfonilurea.
4. Sustituir la metformina por un inhibidor de la DPP4.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La clínica de mareo, sudoración y temblores al final de la mañana o de la tarde, que mejora con la ingesta, es muy sugerente de hipoglucemias de ayuno. El paciente recibe metformina y sulfonilureas. Además, actualmente está sobretratado (Hb glicosilada 5,9% para un objetivo 6,5-7%), por lo que es evidente que necesita un ajuste a la baja. La metformina es el primer escalón farmacológico y contribuye mucho menos a la hipoglucemia que las sulfonilureas, por lo que la

primera medida a realizar sería la retirada de la glimepirida.

189. La clasificación más útil de las vacunas las divide en vivas o atenuadas y vacunas inactivadas. ¿Cuál de las siguientes enfermedades se puede prevenir con una vacuna viva atenuada?:

1. Rubeola.
2. Tos ferina.
3. Encefalitis japonesa.
4. Hepatitis B.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Las vacunas de virus vivos más frecuentemente usadas en los calendarios vacunales son: triple vírica, polio oral, varicela, rotavirus, TBC y fiebre amarilla.

190. ¿Cuál de las siguientes opciones es FALSA en relación al tumor mucinoso papilar intraductal pancreático?:

1. Se consideran lesiones premalignas.
2. Pueden afectar tanto al conducto pancreático principal como a las ramas secundarias y se caracterizan por presentar epitelio productor de mucina.
3. La presencia de nódulos en la pared de la lesión no constituye un signo de alarma.
4. Cuando afecta a las ramas secundarias, la resección quirúrgica está indicada si es mayor de 3 cm.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Muy de moda. Pregunta que con “técnica de examen MIR” podría acertarse. La neoplasia mucinosa papilar intraductal (NPPI) es un tumor quístico que tiene un excelente pronóstico en comparación con otras neoplasias pancreáticas, pero no debemos olvidar que a pesar de que su porcentaje de malignización es bajo, puede degenerar y convertirse en neoplasia (respuesta 1 es cierta). Debemos conocer que hay dos tipos de NPPI: los que afectan al conducto pancreático principal o de Wirsung y los que afectan a ramas secundarias y son una dilatación difusa del conducto pancreático principal y/o sus colaterales con defectos de repleción constatados por técnicas de imagen (correspondientes a globos de mucina o tumor), y salida de moco a través de una papila (respuesta 2 cierta). En esta respuesta la palabra “pueden” nos ha de llamar la atención. La cirugía está indicada en todos los subtipos que presenten estigmas de alto riesgo (Ictericia obstructiva producida por una lesión quística pancreática, realce de componente sólido intraquístico ó conducto pancreático principal > 10mm). Además, estaría también indicada si hay alguna característica de alarma (tamaño del quiste > 30mm, engrosamiento o realce de paredes; Conducto pancreático principal de 6-9 mm; nódulos murales no realzados; estenosis de la rama principal con atrofia de páncreas distal ó adenopatías) y después se realice una ecoendoscopia que muestre nódulo

mural, conducto principal con posible infiltración o citología positiva. Por ello, la respuesta 3 es la falsa y la 4 es cierta. Con algo de sentido común, un nódulo intramural nos ha de hacer sospechar "malignidad" y además por descarte, podría señalarse esta respuesta como correcta.

191. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas al tabaco es FALSA?:

1. La principal causa de muerte relacionada con el tabaco son las neoplasias malignas.
2. En promedio, uno de cada tres fumadores morirá de forma prematura como consecuencia del tabaco.
3. El tabaco aumenta el riesgo de cáncer de vejiga.
4. Los que suspenden el tabaquismo tienen una tasa de mortalidad por cáncer de pulmón casi del 50% menor a los 10 años que los sujetos que continúan el consumo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El tabaco es factor de riesgo para múltiples tumores, pero la principal causa de muerte relacionada con el tabaco es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

192. A la hora de atender pacientes en situaciones graves y complejas, ¿cuáles son las dos actitudes esenciales para una buena relación médicopaciente?:

1. Demostrar buenos conocimientos y asertividad.
2. Tenacidad y constancia.
3. Empatía y compasión.
4. Seguridad y destreza.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Todas las actitudes son positivas y las debe tener cualquier profesional sanitario, pero si estamos en el contexto de comunicación médico-paciente en una situación grave y compleja prevalece la empatía y la compasión por encima de las otras.

193. ¿En cuál de estas situaciones considera adecuada la realización de una biopsia renal en la primera recaída de un síndrome nefrótico en un niño?:

1. Sensibilidad a corticoides.
2. Presencia de edemas incapacitantes.
3. Presencia de síndrome nefrítico.
4. Comienzo entre los 2 y 6 años de vida.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La causa más frecuente con diferencia de síndrome nefrótico en los niños es la enfermedad de cambios mínimos (ECM), responsable de > 80% de los casos. La edad media de inicio se sitúa en torno a los 6 años. El diagnóstico suele

ser clínico (la biopsia no aporta información específica) y suelen responder a un ciclo corto (2 meses) de corticoides en monoterapia (> 90% respuestas); puede haber hasta un 50% de recaídas, pero suelen volver a responder a corticoides en monoterapia. Por ello, la biopsia se realiza en muy contadas ocasiones, solo en aquellos casos que presenten datos clínicos, analíticos o evolutivos que vayan en contra de la evolución típica de una ECM, y que por lo tanto obliguen a descartar otra enfermedad subyacente. Así, algunas de las indicaciones de biopsia son: síndrome nefrótico impuro o síndrome nefrítico (respuesta 3 CORRECTA), hipocomplementemia, no respuesta a esteroides, recidiva intratratamiento o numerosos brotes (3 o más al año).

194. Una paciente presenta una larga historia de múltiples síntomas físicos: pérdida de memoria, dolor de cabeza, mareos, vómitos, dolor genital, dolor en extremidades, distensión abdominal e irregularidades menstruales. Los diversos exámenes médicos han descartado enfermedad médica alguna. ¿Cuál de los siguientes cuadros es más probable que padezca?:

1. Trastorno conversivo.
2. Trastorno hipocóndrico.
3. Trastorno de somatización.
4. Trastorno disociativo.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil sobre los trastornos somatomorfos. Mujer con historia de múltiples síntomas somáticos y normalidad de los exámenes realizados: trastorno de somatización.

195. Hombre de 26 años, soltero, que es traído a consulta por su familia por llevar 3 meses negándose a salir de su casa. La razón que aduce el paciente es el convencimiento de que tiene la mandíbula asimétrica y la cara torcida. Según refiere esta situación es progresiva y cada vez se ve más deforme cuando se observa en el espejo. Se avergüenza de su aspecto, por lo que no quiere salir, se angustia mucho cuando ve su imagen y no puede dejar de pensar todo el día en su deformidad. Ha consultado con varios cirujanos maxilofaciales pero éstos le dicen que no presenta asimetría facial y lo remiten al psiquiatra. El diagnóstico del paciente es:

1. Trastorno depresivo mayor con ideas delirantes incongruentes con el estado de ánimo.
2. Trastorno obsesivo compulsivo.
3. Esquizofrenia paranoide.
4. Trastorno dismórfico corporal.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta controvertida. Las características que se describen en el enunciado sugieren un trastorno dismórfico corporal,

ya que la clínica se focaliza en defectos físicos de la cara y existe gran interferencia en la vida y rutina del paciente. Ahora bien, el enunciado habla de “convencimiento” y esto podría hacer dudar con el diagnóstico diferencial con trastorno delirante de tipo somático. Sin embargo, esta opción no aparece entre las respuestas ofrecidas, siendo el resto descartables ya que no se refiere clínica del estado anímico de base (respuesta 1 falsa), ni cuadro psicótico de tipo esquizofrénico (respuesta 3 falsa); aunque es trastorno dismórfico corporal se relaciona clínica y etiológicamente con el TOC (de hecho cambió la clasificación en el DSM V), la pregunta no señala obsesiones más allá de las corporales que orientarían hacia este trastorno (respuesta 2 falsa).

196. Señalar en que trastorno de la personalidad se observa la ausencia de remordimientos y la incapacidad para planificar el futuro:

1. Trastorno paranoide de la personalidad.
2. Trastorno límite de la personalidad.
3. Trastorno antisocial de la personalidad.
4. Trastorno de la personalidad por evitación.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Respuesta correcta 3. Las características señaladas en el enunciado son propias de un trastorno antisocial de la personalidad en el que destaca la incapacidad para adaptarse a las normas ni sentir remordimientos, falta de empatía y tendencia a conductas arriesgadas y violentas debido a un pensamiento irresponsable e impulsivo.

197. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de un recién nacido con microcefalia, retraso del crecimiento intrauterino, cardiopatía congénita, pie astrágalo vertical y una facies peculiar (microftalmia, hendiduras palpebrales pequeñas, micrognatia y orejas displásicas), las manos con el dedo índice y meñique sobre el medio y anular?:

1. Trisomía 18. (Síndrome de Edwards).
2. Trisomía 13. (Síndrome de Patau).
3. Trisomía 21. (Síndrome de Down).
4. Trisomía 9.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El síndrome de Edwards se trata de un síndrome polimalformativo generalmente incompatible con la vida, de origen genético (trisomía 18). Clínicamente supone la asociación de varias alteraciones: anomalías craneofaciales (microcefalia, fontanelas amplias, occipucio prominente, colobomas, orejas displásicas de implantación baja, boca pequeña, etc.), anomalías de las extremidades (mano trisómica, con tendencia a puños cerrados, con el segundo dedo montado sobre el tercero, y el quinto sobre el cuarto, uñas hipoplásicas, hipoplasia radial, pies zambos, talón prominente, etc.), alteraciones urogenitales (testes no descendidos, hipoplasia de labios mayores, malformaciones

uterinas, alteraciones renales, etc.), presencia de cardiopatía congénita hasta en un 90% de los casos y alteraciones gastrointestinales.

198. La causa más frecuente de quilotórax es:

1. Tumores del mediastino.
2. Traumatismo.
3. Hipertrigliceridemia.
4. Linfoma.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La causa más frecuente de quilotórax es el traumatismo torácico. Traumatismos inferiores a T5 dan derrame derecho y superiores a T5 derrame izquierdo, debido a la anatomía del conducto torácico.

199. Seleccionamos una muestra aleatoria entre los pacientes que acuden a vacunarse de la gripe durante la campaña anual en un centro de salud. Se registra en los pacientes seleccionados si están utilizando fármacos hipolipemiantes y si están diagnosticados de diabetes mellitus, entre otros datos. Se obtiene que la diabetes mellitus es más frecuente entre los pacientes que toman hipolipemiantes que entre los que no los toman. ¿A cuál de los siguientes corresponde el diseño de este estudio?:

1. Un estudio de prevalencia.
2. Un estudio de casos y controles.
3. Un estudio de cohortes prospectivo.
4. Un ensayo clínico aleatorizado.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Clásica pregunta donde el concepto es fácil pero intentan complicarlo por la manera en que redactan el enunciado. Se trata de un estudio sin seguimiento, ni prospectivo ni retrospectivo, donde se recogen dos variables a todos los sujetos seleccionados, por tanto es un estudio transversal. Que no os líe el enunciado: no se trata de un casos-controles ni nada parecido (recordad, no partís de diabéticos y no diabéticos y luego investigáis si toman o no toman hipolipemiente; partís de una muestra seleccionada al azar y hacéis una medición puntual de dos variables).

200. Teniendo en cuenta la clasificación sanitaria de las vacunas, indique cuál de las siguientes es una vacuna no sistemática:

1. Vacuna antigripal.
2. Vacuna antihepatitis B.
3. Vacuna antipoliomielítica.
4. Vacuna antisarampión.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

De todas las citadas, la vacunación antigripal no forma parte del calendario vacunal sistemático. Sus indicaciones son : mayores de 65 años, niños y adolescentes en tratamiento crónico con salicilatos, niños y adultos con cardiopatía, neuropatías, neoplasias, anemias crónicas, metabolopatías e inmunodepresión, personas que pueden transmitir a individuos de alto riesgo o personal sanitario.

201. En un programa de cribado de cáncer de colon, a un paciente de 52 años se le realiza una colonoscopia. Todo el colon es de aspecto normal, salvo el hallazgo de un pólipo pediculado de 2 cm en sigma que se extirpa con asa de diatermia. El resultado anatomopatológico nos indica que existe un carcinoma “in situ” limitado a la cabeza del pólipo. Tiene una TC toracoabdominal informado como normal. Indique cuál sería la conducta correcta a seguir:

1. Resección segmentaria del colon afecto.
2. Vigilancia periódica endoscópica.
3. Resección local de la base del pólipo.
4. Sigmoidectomía más linfadenectomía.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos presentan a un paciente de edad media al que en un programa de cribado de CCR se le realiza una polipectomía endoscópica de un pólipo pediculado. En la anatomía patológica se objetiva un carcinoma “in situ”, es decir, un carcinoma que no sobrepasa la capa “muscularis mucosae”. En este caso, con la resección endoscópica es suficiente como tratamiento ya que no existe invasión de la capa submucosa y por lo tanto, no está indicado el tratamiento quirúrgico (respuestas 1 y 4 incorrectas). Además nos indican que el carcinoma está limitado a la cabeza del pólipo, por lo que no parece razonable realizar una nueva colonoscopia para reseccionar la base pediculada (respuesta 3 incorrecta). En este tipo de situaciones, lo que hay que hacer es un seguimiento estrecho del paciente con colonoscopias periódicas (respuesta 2 correcta).

202. Paciente de 76 años, con hipertensión y diabetes mellitus, que acude a Urgencias porque desde hace 72 horas ha comenzado con un cuadro de palpitaciones y disminución de su capacidad para hacer esfuerzos. A su llegada se documenta una fibrilación auricular con respuesta ventricular en torno a 120 lpm. ¿Cuál de las siguientes opciones es FALSA?:

1. Este paciente debe estar anticoagulado oralmente de por vida, salvo contraindicación.
2. Si decidimos realizar una cardioversión a su llegada a Urgencias, sería necesario hacer previamente una ecocardiografía transesofágica.
3. Al ser el primer episodio de fibrilación

auricular es el candidato idóneo para realizar una ablación con catéter.

4. Para frenar la frecuencia cardíaca podríamos emplear betabloqueantes.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Cuadro de fibrilación auricular “rápida” que atendemos en Urgencias. El paciente lleva más de 48h con la clínica, por lo que no podemos realizar cardioversión sin un ecocardiograma transesofágico previo (o anticoagulación 3 semanas). De momento daremos frenadores (beta-bloqueantes o calcio-antagonistas, en casos de insuficiencia cardíaca aguda o si no existe control con uno de ellos digoxina) e iniciaremos anticoagulación oral permanente, pues el paciente tiene CHA₂DS₂-VASc = 3 (HTA, DM y edad >65 años). No es el candidato “ideal” para realizar ablación de la arritmia. Los pacientes con mejor respuesta a la ablación (o en general a una estrategia de control de ritmo) son los pacientes jóvenes sin cardiopatía y con fibrilación auricular paroxística. Nuestro paciente no sabemos si tiene cardiopatía (aunque tiene varios factores de riesgo cardiovascular) y el episodio actual es posible que se quite sólo antes de 7 días y podamos tacharlo de “paroxístico” (aunque no tiene pinta), pero lo que no le quita nadie es ser anciano.

203. Dentro de las alteraciones funcionales características de la EPOC, ¿cuál está más relacionada con la afectación enfisematosa del parénquima pulmonar?:

1. Disminución de la capacidad de difusión para el monóxido de carbono.
2. Disminución de los niveles de saturación de la oximetría durante las pruebas de esfuerzo.
3. Patrón obstructivo grave en la espirometría (FEV₁<50%).
4. Aumento del volumen residual.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta clásica y tópica. Diferencias entre el perfil clínico del fenotipo bronquitis crónica y del fenotipo enfisematoso. En el enfisema hay una mayor disnea (síntoma subjetivo), pero para un mismo grado de afectación todos los parámetros objetivos (saturación, hipertensión pulmonar, número de reagudizaciones, etc.) están peor en un paciente bronquítico, salvo un único parámetro. La DLCO, difusión de CO, está disminuida en el enfisema por pérdida de la superficie de intercambio gaseoso (en el bronquítico puede haber una leve disminución por discordancia ventilación/perfusión, pero menos frecuente y menos significativa). La FEV₁ suele estar más afectada en los pacientes bronquíticos. El volumen residual puede verse aumentado en ambas patologías, y la desaturación con el esfuerzo también se ve en los dos casos (en el bronquítico por fenómenos de atrapamiento dinámico, en el enfisematoso por la alteración de la difusión pulmonar).

204. Atiende a una mujer de 48 años, en situación premenopáusica que practica deporte regularmente y no es fumadora. Presenta una fractura vertebral en T11 considerada fractura por fragilidad. Señale la respuesta correcta:

1. No es necesario iniciar un tratamiento antirreabsortivo por edad y ausencia de otros factores de riesgo.
2. Recomendaría orientar su dieta a fortalecer el consumo de productos ricos en calcio y fósforo.
3. Debe iniciar tratamiento con un agente antirreabsortivo asociado a suplementos de calcio y vitamina D.
4. No debe instaurarse ningún tratamiento farmacológico hasta disponer de los resultados de una densitometría ósea lumbar y femoral.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En la osteoporosis premenopáusica con antecedente de fractura de fragilidad es aconsejable hacer una densitometría para confirmar si existe baja densidad mineral ósea y hacer un estudio analítico más completo para descartar causas secundarias que, de encontrarse, deben tratarse. Ello no debe retrasar sin embargo el inicio del tratamiento farmacológico, que debe realizarse con vitamina D, calcio y un fármacos específicos como bifosfonatos, terapia hormonal o teriparatida.

205. ¿Cuál de las siguientes opciones terapéuticas se considera actualmente la más eficaz para el tratamiento de una infección crónica de una artroplastia de cadera y conseguir una recuperación funcional?:

1. Antibioterapia intravenosa durante tres semanas, seguida de antibioterapia oral durante seis semanas más.
2. Retirada de la prótesis infectada, desbridamiento quirúrgico, colocación de un espaciador, antibioterapia y pasado un tiempo colocación de una nueva prótesis.
3. Desbridamiento quirúrgico seguido de antibioterapia durante 12 semanas sin retirar la prótesis.
4. Tratamiento antibiótico más drenaje externo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta sobre el tratamiento de una infección crónica de una prótesis de rodilla. El tratamiento de elección consiste en la retirada de la prótesis, colocación de un espaciador de cemento con antibiótico, y administración de antibioterapia intravenosa dirigida durante varias semanas seguida de antibioterapia oral durante meses. Una vez resuelta la infección se retira el espaciador y se implanta una nueva prótesis más compleja que la anterior (prótesis de revisión).

206. Hombre de 88 años autónomo para todas las

actividades de la vida diaria y con antecedentes de HTA bien controlada, fibrilación auricular antiagregada y un adenocarcinoma de próstata a los 78 años actualmente libre de enfermedad. Es traído a urgencias por clínica de afasia y hemiparesia derecha de inicio brusco, 190 minutos antes. ¿Cuál es la actitud más correcta?:

1. Realizar TC craneal y si no hay lesiones hemorrágicas ni otras contraindicaciones en la analítica, iniciaría trombolisis endovenosa de forma inmediata. Si tiene oclusión de vaso proximal, posteriormente realizaría trombectomía mecánica.
2. Realizar TC craneal urgente y si no hay sangrado iniciar anticoagulación.
3. Realizar TC craneal e ingreso en centro de rehabilitación, ya que está fuera del límite de tiempo para perfusión.
4. No hace falta TC craneal, aunque retiraría la antiagregación.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Al contrario que el sangrado cerebral evidenciado en pruebas de neuroimagen, y el tiempo de evolución mayor de 4,5 horas, la edad no es una contraindicación absoluta para la administración de fibrinólisis intravenosa en el tratamiento agudo del infarto cerebral. En este caso, dada la buena situación basal del paciente, y una vez descartada la hemorragia mediante TC cerebral, podría administrarse. Además, tenemos que realizar una prueba de imagen vascular (angioTC) y si el paciente tiene oclusión de un gran vaso proximal, sería candidato a trombectomía mecánica en las primeras 6h (24h si hay mismatch o territorio salvable).

207. Una mujer de 24 años de edad consulta al haber apreciado adenopatías inguinales. En el interrogatorio no se recoge la presencia de ninguna molestia local ni datos sugerentes de infección de transmisión sexual. En la exploración se aprecian dos adenopatías, una en cada ingle, de 1 cm de diámetro mayor, blandas, móviles, no dolorosas. No se aprecia ninguna lesión cutánea en miembros inferiores, ano o periné. ¿Qué prueba considera imprescindible?:

1. Una serología de lúes puesto que lo más probable es que se trate de una infección por Treponema pallidum.
2. Una exploración ginecológica a fin de descartar un cáncer de ovario.
3. Por las características clínicas parece tratarse de unos ganglios normales y no deben hacerse exploraciones complementarias.
4. Debe realizarse una prueba de Paul-Bunell a fin de descartar una mononucleosis infecciosa.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta compleja. Por un lado, ante una chica joven con adenopatías inguinales todos tenemos la tentación de pedir una serología luética. Sin embargo, nos pintan unas adenopatías de características "inocentes": de un centímetro escaso, móviles, blandas y no dolorosas, por lo que lo más probable es que sean. nada (opción 1 falsa), por lo que la opción menos mala en esta pregunta es la 3. Evidentemente con la edad de la paciente no estamos pensando en cáncer de ovario (opción 2 falsa) y aunque la mononucleosis puede hacer adenopatías inguinales no es causa de adenopatías inguinales aisladas y sin ninguna otra clínica (opción 4 falsa).

208. Acude a consultas de pediatría un niño de 13 años de edad por presentar sensación de pirosis durante y tras las comidas y disfagia ocasional, que aumenta con la ingesta de alimentos sólidos 36 como la carne. En los antecedentes familiares destacar que su madre está diagnosticada de hernia hiatal. En los antecedentes personales nos refiere alergia a pólenes, ácaros y látex. En la exploración física, no muestra hallazgos significativos salvo lesiones eccematosas en huecos poplíteos y antecubitales. ¿Cuál de las siguientes pruebas complementarias NO realizaría de acuerdo a los diagnósticos más probables?:

1. Endoscopia digestiva superior.
2. pHmetría esofágica de 24 horas.
3. Test de aliento con carbono 13 para *Helicobacter pylori*.
4. Estudio baritado esófago-gastro-duodenal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Se presenta un caso clínico correspondiente a un paciente con antecedentes familiares de hernia de hiato y personales de alergia y atopia, con sintomatología de reflujo gastro-esofágico y disfagia a sólidos. Dicha sintomatología podría corresponder a una entidad conocida como esofagitis eosinofílica. Esta es una enfermedad primaria del esófago caracterizada por síntomas esofágicos y/o gastrointestinales altos, principalmente disfagia e impactación alimentaria, e intolerancia a los alimentos y síntomas de reflujo gastro-esofágico. Para su diagnóstico precisa de la exclusión de reflujo gastroesofágico y de la presencia de >15 eosinófilos por campo en biopsias de mucosa esofágica. Por lo tanto, en el caso clínico presentado, estarían indicadas todas las exploraciones complementarias que permitieran el diagnóstico de dicha entidad, descartando previamente y a través de un tránsito esófago-gastro-duodenal baritado la presencia de una hernia hiatal que pudiera también explicar la presencia de reflujo gastro-esofágico.

209. Señale cuál de las siguientes enfermedades maculares NO es típica de un ojo con miopía grave:

1. Neovascularización coroidea.
2. Desprendimiento regmatógeno de retina por agujero macular.
3. Maculopatía traccional.
4. Vasculopatía coroidea polipoidea.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media. La miopía magna (maligna, grave o degenerativa) es una patología degenerativa que se produce por un aumento progresivo del eje anteroposterior del globo ocular durante años. El estiramiento de la retina provoca degeneraciones periféricas, con riesgo de ruptura de la retina y por lo tanto de desprendimiento de retina. También se producen roturas prematuras de la membrana de Bruch (estrías de laca) lo que permite que puedan desarrollarse membranas neovasculares coroideas o membranas miópicas (como la DMAE exudativa pero en edades más tempranas y que responden muy bien a 1 dosis de anti-VEGF). El estafiloma posterior es un rasgo distintivo de los miopes altos, constituye el área de protrusión de la pared ocular posterior, por adelgazamiento y expansión de la misma, lo cual ocurre de forma gradual. Además, la alteración coriorretiniana degenerativa provoca placas de atrofia, más frecuentemente a nivel del polo posterior y en la zona peripapilar. Por último, existe una fuerte adhesión vítreo-retiniana a nivel macular, lo que asocia con una maculopatía traccional, que incluye la separación de las capas de la retina (también denominada retinosquiasis foveal) y el agujero macular. La vasculopatía coroidea polipoidea es una enfermedad idiopática variante de la DMAE exudativa, relativamente infrecuente, en que la que los vasos coroideos internos tienen ramificaciones anómalas y múltiples protuberancias como aneurismas (llamados pólipos).

210. Lactante de 3 meses correctamente vacunado para su edad, que tras dos semanas de rinorrea, estornudos y tos, ingresa por intensificación de los accesos de tos, con cianosis al final de los mismos, que finalizan con inspiración profunda o gallo inspiratorio, precisando estimulación, aspiración de secreciones y oxígeno para recuperarse de los mismos. Según su sospecha diagnóstica y con respecto a la vacuna de dicha enfermedad, todas son verdaderas EXCEPTO:

1. La vacuna en España se administra combinada con la antidiftérica y antitetánica.
2. Se deben vacunar a los adultos que vayan a estar en contacto con lactantes menores de 6 meses.
3. La inmunidad tanto natural como vacunal, permanece de por vida.
4. La vacunación está preparada a partir de microorganismos muertos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Tanto la infección natural por tos ferina como la vacunación

confieren una protección limitada; se estima en 4-20 años para la infección natural y en 4-7 años para la adquirida mediante la vacunación(opción 1 falsa); la opción 2 en un consejo general, aunque lo ya establecido es la vacunación en el tercer trimestre de gestación a las madres embarazadas. El resto de opciones son correctas.

